

Bunga Rampai **PERAN PERAWAT DALAM DUKUNGAN MENYUSUI PADA IBU POSTPARTUM**

Vika Tri Zelharsandy • Puji Hastuti • Aida Kusnaningsih
Enok Nurliawati • Ernauli Meliyana
Tutik Rahayu • Ayut Merdikawati

Editor: Nurna Ningsih



BUNGA RAMPAI: PERAN PERAWAT DALAM DUKUNGAN MENYUSUI PADA IBU POSTPARTUM

Penulis:

Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dr. Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.
Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Nurna Ningsih, S.Kp., M.Kes.

Bunga Rampai: Peran Perawat Dalam Dukungan Menyusui Pada Ibu Postpartum

Penulis:

Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dr. Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.
Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.

Editor: Nurna Ningsih, S.Kp., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-48-0

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga berjudul “Bunga Rampai Peran Perawat dalam Dukungan Menyusui pada Ibu Postpartum” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Bunga rampai ini disusun sebagai upaya untuk memperkaya referensi dan memperkuat pemahaman tenaga keperawatan dalam mendampingi ibu pada masa postpartum, khususnya dalam mendukung keberhasilan menyusui yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Masa postpartum merupakan periode adaptasi yang penting, baik secara fisik maupun psikologis. Pada fase ini, proses laktasi dan praktik menyusui membutuhkan dukungan yang tepat agar ibu dapat menyusui secara optimal. Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, mulai dari pengkajian, edukasi, intervensi, hingga evaluasi, termasuk melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama. Oleh karena itu, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis sekaligus bahan pembelajaran bagi mahasiswa, perawat klinis, pendidik, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan maternal dan neonatal.

Bunga rampai ini tersusun dalam tujuh bab yang saling berkesinambungan. Bab 1 membahas konsep dasar masa postpartum dan laktasi sebagai landasan ilmiah. Bab 2 menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyusui, baik dari sisi ibu, bayi, maupun lingkungan. Bab 3 memaparkan pengkajian keperawatan pada ibu postpartum dalam pemberian ASI sebagai langkah awal menentukan kebutuhan asuhan. Selanjutnya, Bab 4 menekankan pentingnya edukasi teknik menyusui yang benar serta perawatan payudara untuk mencegah masalah menyusui. Bab 5 menguraikan intervensi keperawatan pada kondisi bendungan ASI dan puting lecet yang sering terjadi pada awal menyusui. Bab 6 membahas dukungan keluarga sebagai kunci keberhasilan ASI eksklusif. Terakhir, Bab 7 memuat evaluasi keberhasilan dukungan menyusui pada ibu postpartum sebagai dasar perbaikan layanan dan peningkatan mutu asuhan keperawatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat memberikan manfaat nyata, menjadi sumber rujukan yang relevan, serta mendorong perawat untuk terus

meningkatkan kompetensi dan kepedulian dalam mendukung keberhasilan menyusui pada ibu postpartum.

Juni, 2026

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
 CHAPTER 1 KONSEP DASAR MASA POSTPARTUM DAN LAKTASI	
Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Post Partum.....	2
C. Perubahan Psikologi Masa Postpartum.....	7
D. Kunjungan Masa Postpartum.....	8
E. Kebutuhan Dasar Ibu Postpartum	8
F. Tanda Bahaya Masa Postpartum.....	10
Referensi	16
 CHAPTER 2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN MENYUSUI	
Dr. Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyusui.....	19
C. Program Pemerintah dalam Mendukung Keberhasilan Menyusui	27
D. Simpulan	28
Referensi	29
 CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA IBU POSTPARTUM DALAM PEMBERIAN ASI	
Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	32
A. Pendahuluan.....	32
B. Tujuan Pengkajian Pada Ibu Postpartum Terkait Pemberian ASI.....	33
C. Komponen Pengkajian Keperawatan Pada Ibu Postpartum Terkait Pemberian ASI	35
D. Penutup	56
E. Simpulan	57
Referensi	58
Glosarium.....	63

CHAPTER 4 EDUKASI TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR DAN PERAWATAN PAYUDARA

Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.	64
A. Pendahuluan.....	64
B. Fisiologi Laktasi: Landasan Hormonal dan Mekanis.....	65
C. Edukasi Teknik Menyusui	67
D. Teknis Menyusui yang Benar: Posisi dan Perlekatan	68
E. Perawatan Payudara (Breast Care) Antenatal dan Post Natal	70
F. Intervensi Pijat Oksitosin untuk Mengatasi Menyusui Tidak Efektif.....	71
G. Manajemen Komplikasi Laktasi: Bendungan ASI (Breast Engorgement).....	73
H. Simpulan dan Rekomendasi Klinis.....	74
Referensi	76
Glosarium	77

CHAPTER 5 INTERVENSI KEPERAWATAN PADA BENDUNGAN ASI DAN PUTING LECET

Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep.	78
A. Pendahuluan.....	78
B. INTERVENSI KEPERAWATAN PADA BENDUNGAN ASI DAN PUTING LECET	84
C. Hambatan dalam Melakukan Intervensi Bendungan ASI dan Puting Lecet	87
D. Kesimpulan.....	89
Referensi	90

CHAPTER 6 DUKUNGAN KELUARGA DALAM KEBERHASILAN ASI EKSKLUSIF

Dr. Ns. Tutik Rahayu, Mkep., Sp.Kep.Mat.	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Konsep Dasar Pemberian ASI Eksklusif	95
C. Dukungan Keluarga dalam Keberhasilan ASI Eksklusif	97
D. Aktor Kunci dalam Dinamika Dukungan Keluarga terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif,	98
E. Mekanisme Psikobiologis: Bagaimana Dukungan Mempengaruhi Produksi ASI.. ..	100
F. Dimensi Psikososial dalam Dinamika Dukungan	102
G. Dinamika Konflik dan Hambatan Dukungan dalam Pemberian ASI Eksklusif	103
H. Faktor Sosial Budaya dan Konteks Lokal dalam Pemberian ASI Eksklusif.....	105
I. Intervensi Berbasis Keluarga untuk Meningkatkan ASI Eksklusif	106
J. Implikasi untuk Praktik Keperawatan Maternitas	108
Referensi	110

CHAPTER 7 EVALUASI KEBERHASILAN DUKUNGAN MENYUSUI PADA IBU POSTPARTUM

Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.....	116
A. Pendahuluan.....	116
B. Konsep Dukungan Menyusui pada Ibu Postpartum	117
C. Indikator Keberhasilan Menyusui.....	119
D. Metode Evaluasi Dukungan Menyusui.....	124
E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Dukungan Menyusui pada Ibu Postpartum .	130
Referensi	133
 PROFIL PENULIS	 137



CHAPTER 1



KONSEP DASAR MASA POSTPARTUM DAN LAKTASI

Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Masa postpartum dan laktasi merupakan periode penting dalam kehidupan seorang ibu setelah proses persalinan. Masa postpartum atau masa nifas adalah periode yang dimulai setelah lahirnya plasenta hingga alat reproduksi ibu kembali seperti keadaan sebelum hamil, yang umumnya berlangsung selama sekitar enam minggu. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang memerlukan perhatian khusus agar kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga (Sutrini et al., 2020).

Menurut (World Health Organization, 2022), masa postnatal/postpartum didefinisikan sebagai periode yang dimulai segera setelah lahirnya bayi dan berlangsung sampai enam minggu (42 hari) setelah persalinan. WHO juga menegaskan bahwa periode ini merupakan fase kritis bagi kesehatan ibu dan bayi sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan dan dukungan yang optimal.

Selain pemulihan kondisi tubuh ibu, masa postpartum juga berkaitan erat dengan proses laktasi, yaitu proses pembentukan dan pengeluaran air susu ibu (ASI). Laktasi menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi karena ASI mengandung zat gizi lengkap, antibodi, hormon, serta faktor pertumbuhan yang mendukung perkembangan optimal bayi. Keberhasilan proses menyusui dipengaruhi oleh kondisi fisik dan emosional ibu, dukungan keluarga, serta pengetahuan mengenai teknik menyusui yang benar. Pemahaman mengenai konsep dasar masa postpartum dan laktasi sangat penting bagi tenaga kesehatan maupun ibu agar dapat mengenali perubahan normal, mendeteksi komplikasi sejak dini, serta memberikan perawatan yang tepat. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan ibu mampu menjalani masa nifas dengan sehat, nyaman, dan dapat memberikan ASI secara optimal kepada bayinya (Suciati & Wulandari, 2020).

Dalam hal ini, bidan dan perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan postpartum dan dukungan laktasi. Bidan berperan dalam melakukan pemantauan kondisi ibu dan bayi, mendeteksi komplikasi masa nifas, memberikan edukasi tentang perawatan diri, serta membimbing ibu dalam proses menyusui yang benar. Sementara itu, perawat berperan dalam memberikan

perawatan holistik, membantu pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis ibu, mendukung keberhasilan pemberian ASI, serta melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi (Mufida et al., 2022).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar masa postpartum dan laktasi sangat diperlukan bagi bidan dan perawat agar mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, aman, dan berkualitas. Dengan asuhan yang tepat, diharapkan ibu dapat melewati masa nifas dengan sehat serta mampu memberikan ASI secara optimal demi mendukung tumbuh kembang bayi.

B. Post Partum

1. Definisi Masa Postpartum

Masa postpartum adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Selama masa pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik yang bersifat fisiologis dan banyak memberikan ketidaknyamanan pada awal *post partum*, yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadi patologis bila tidak diikuti dengan perawatan yang baik (Fatimah, 2022).

Postpartum merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Selama masa pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik yang bersifat fisiologis dan banyak memberikan ketidaknyamanan pada awal *post partum*, yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadi patologis bila tidak diikuti dengan perawatan yang baik (Kemenkes, 2023).

2. Tujuan Asuhan Masa Postpartum

Menurut (Azizah, 2019), ada beberapa tujuan asuhan masa postpartum yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologi ibu dan bayi Dengan diberikannya asuhan, ibu akan mendapatkan fasilitas dan dukungan dalam upaya untuk menyesuaikan peran barunya sebagai ibu (pada kasus ibu dengan kelahiran anak pertama) dan pendampingan keluarga dalam membuat pola baru saat kelahiran anak kedua. Jika ibu dapat melewati masa ini dengan baik maka kesejahteraan fisik dan psikologis bayi pun akan meningkat. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis harus diberikan oleh tenaga kesehatan.

- b. Pencegahan, diagnosa dini, dan pengobatan komplikasi pada ibu postpartum
Dengan diberikannya asuhan pada ibu postpartum, kemungkinan munculnya permasalahan dan komplikasi akan lebih cepat terdeteksi sehingga penanganannya dapat lebih maksimal
- c. Mendukung dan meningkatkan keyakinan ibu, serta memungkinkan ibu untuk mampu melaksanakan perannya dalam situasi keluarga dan budaya khusus
Pada saat memberikan asuhan postpartum, keterampilan seorang bidan sangat dituntut untuk memberikan pendidikan kesehatan.

3. Tahapan Masa Postpartum

Menurut (Guyton, 2021) ada beberapa tahapan yang di alami oleh wanita selama masa postpartum, yaitu sebagai berikut :

- a. *Immediate puerperium*, yaitu waktu 0-24 jam setelah melahirkan. Ibu telah di perbolehkan berdiri atau jalan-jalan.
- b. *Early puerperium*, yaitu waktu 1-7 hari pemulihan setelah melahirkan. pemulihan menyeluruh alat-alat reproduksi berlangsung selama 6- minggu.
- c. *Late puerperium*, yaitu waktu 1-6 minggu setelah melahirkan, inilah waktu yang diperlukan oleh ibu untuk pulih dan sehat sempurna. Waktu sehat bisa berminggu-minggu, bulan dan tahun.

4. Perubahan Fisiologis Masa Postpartum

Sistem tubuh ibu akan kembali beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi post partum. Organ-organ tubuh ibu yang mengalami perubahan setelah melahirkan antara lain (Savita, dkk, 2022) :

a. Uterus

Involusi merupakan suatu proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil. Perubahan ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan palpasi untuk meraba dimana Tinggi Fundus Uterinya (TFU).

Tabel 1. 1 Ukuran uterus pada masa postpartum

Inversio Uteri	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus
Plasenta lahir	Setinggi pusat	1000 gram	12,5 cm
7 hari	Pertengahan pusat & simfisis	5000 gram	7,5 cm
14 hari	Tidak teraba	300 gram	5 cm
6 minggu	Normal	60 gram	2,5 cm

Sumber: (Suhendra, 2022)

Proses involusi uterus adalah sebagai berikut (Savita, dkk, 2022) ;

1) *Iskemia myometrium*

Hal ini disebabkan oleh kontraksi dan retraksi uterus yang terus menerus setelah pengeluaran plasenta sehingga membuat uterus menjadi relatif anemi dan menyebabkan serat otot atrofi.

2) *Atrofi jaringan*

Atrofi jaringan terjadi sebagai reaksi penghentian hormon estrogen saat pelepasan plasenta.

3) *Autolisis*

Autolisis merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterus. Enzim protolitik akan memendekkan jaringan otot yang telah mengendur hingga panjangnya 10 kali panjang sebelum, hamil dan lebarnya 5 kali lebar sebelum hamil yang terjadi selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena penurunan hormon estrogen dan progesterone.

4) Efek Oksitosin

Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterus sehingga akan menekan pembuluh darah yang mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke uterus. Proses ini membantu untuk mengurangi perdarahan. Ukuran uterus pada masa postpartum akan mengecil seperti sebelum hamil.

b. Lokhea

Lokhea adalah ekskresi cairan rahim selama masa postpartum. Lokhea berbau amis atau anyir dengan volume yang berbeda-beda pada setiap wanita. Lokhea yang berbau tidak sedap menandakan adanya infeksi. Lokhea mempunyai perubahan warna dan volume karena adanya proses involusi. Lokhea dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan warna dan waktu keluarnya:

1) *Lokhea rubra.*

Lokhea ini keluar pada hari pertama sampai hari ke 4 masa post partum. Cairan yang keluar berwarna merah karena terisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan mekonium.

2) *Lokhea sanguinolenta.*

Lokhea ini berwarna merah kecokelatan dan berlendir, serta berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 post partum.

3) *Lokhea serosa*.

Lokhea ini berwarna kuning kecokelatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Keluar pada hari ke-7 sampai hari ke-14.

4) *Lokhea alba*.

Lokhea ini mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Lokhea alba ini dapat berlangsung selama 2-6 minggu post partum. Lokhea yang menetap pada awal periode post partum menunjukkan adanya tanda-tanda perdarahan sekunder yang mungkin disebabkan oleh tertinggalnya sisa atau selaput plasenta. Lokhea alba atau serosa yang berlanjut dapat menandakan adanya endometritis, terutama bila disertai dengan nyeri pada abdomen dan demam.

Bila terjadi infeksi, akan keluar cairan nanah berbau busuk yang disebut dengan "lokhea purulenta". Pengeluaran lokhea yang tidak lancar disebut "lokhea statis".

c. Perubahan Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan, serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol.

d. Perubahan Perineum

Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Pada post partum hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum hamil.

e. Perubahan Sistem

Pencernaan Biasanya ibu mengalami konstipasi setelah persalinan. Hal ini disebabkan karena pada waktu melahirkan alat pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong, pengeluaran cairan yang berlebihan pada waktu persalinan, kurangnya asupan makan, hemoroid dan kurangnya aktivitas tubuh.

f. Perubahan Sistem Perkemihan

Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya ibu akan sulit untuk buang air kecil dalam 24 jam pertama. Penyebab dari keadaan ini adalah terdapat *spasme sfinkter* dan edema leher kandung kemih setelah mengalami kompresi (tekanan) antara kepala janin dan tulang pubis selama persalinan

berlangsung. Kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Keadaan tersebut disebut "*diuresis*".

g. Perubahan Sistem Muskuloskeletal

Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah partus, pembuluh darah yang berada di antara anyaman otot-otot uterus akan terjepit, sehingga akan menghentikan perdarahan. Ligamen-ligamen, diafragma pelvis, serta fasia yang meregang pada waktu persalinan, secara berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali. Stabilisasi secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan.

h. Perubahan Sistem Kardiovaskuler

Setelah persalinan, shunt akan hilang tiba-tiba. Volume darah bertambah, sehingga akan menimbulkan dekompensasi kordis pada penderita vitum cordia. Hal ini dapat diatasi dengan mekanisme kompensasi dengan timbulnya hemokonsentrasi sehingga volume darah kembali seperti sediakala. Pada umumnya, hal ini terjadi pada hari ketiga sampai kelima postpartum.

i. Perubahan Tanda-tanda

Vital Pada masa postpartum, tanda – tanda vital yang harus dikaji antara lain:

- 1) Suhu badan Dalam 1 hari (24 jam) post partum, suhu badan akan naik sedikit ($37,50 - 38^{\circ} \text{C}$) akibat dari kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan kelelahan. Apabila dalam keadaan normal, suhu badan akan menjadi biasa. Biasanya pada hari ketiga suhu badan naik lagi karena ada pembentukan Air Susu Ibu (ASI). Bila suhu tidak turun, kemungkinan adanya infeksi pada endometrium.
- 2) Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali per menit. Denyut nadi sehabis melahirkan biasanya akan lebih cepat. Denyut nadi yang melebihi 100x/ menit, harus waspada kemungkinan dehidrasi, infeksi atau perdarahan post partum.
- 3) Tekanan darah Tekanan darah biasanya tidak berubah. Kemungkinan tekanan darah akan lebih rendah setelah ibu melahirkan karena ada perdarahan. Tekanan darah tinggi pada saat post partum menandakan terjadinya preeklampsia post partum.
- 4) Pernafasan Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas. Bila pernafasan pada masa post partum menjadi lebih cepat, kemungkinan ada tanda-tanda syok.

C. Perubahan Psikologi Masa Postpartum

Menurut Savita,dkk (2022), proses persalinan dan lahirnya bayi memberikan arti dan makna yang sangat besar bagi seorang ibu. Bahkan sering kali dapat mengubah sikap dan psikologis orang tua. Hal-hal yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi pada masa postpartum, antara lain sebagai berikut :

1. Memahami fungsi menjadi orang tua
2. Adanya respon dan dukungan dari keluarga
3. Riwayat dan pengalaman kehamilan serta persalinan sebelumnya
4. Harapan, keinginan, dan aspirasi saat hamil dan melahirkan

Periode ini diekspresikan oleh Reva Rubin yang terjadi pada tiga tahap berikut:

1. Fase Taking In

Hari pertama sampai kedua setelah persalinan ibu masih merasakan lelah karena proses persalinan yang dilaluinya, terkesan pasif terhadap bayi dan lingkungan sekitar. Ibu masih merasakan nyeri pada jalan lahir, rasa mulas akibat proses involusi, dan kurang tidur. Kebutuhan ibu postpartum yang wajib diperhatikan pada fase ini adalah terpenuhinya kebutuhan asupan nutrisi, dan istirahat. Dukungan keluarga dan petugas kesehatan dalam mendampingi dan membantu ibu melewati fase ini sangat diharapkan ibu tidak mengalami gangguan psikologis seperti rasa bersalah karena belum mampu merawat bayinya, belum bisa menyusui karena ASI belum keluar, dan kecewa terhadap jenis kelamin yang tidak sesuai harapan.

2. Fase Taking Hold

Fase ini berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir akan ketidak mampuan dan sudah mulai ada rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Perhatian terhadap kemampuan mengatasi fungsi tubuhnya misal kelamcaran buang air besar. Hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, dukungan, dan pemberian penyuluhan dan pendidikan kesehatan tentang perawatan diri dan bayinya.

Tugas petugas kesehatan antara lain mengajarkan cara perawatan bayi, cara menyusui yang benar, cara perawatan luka jahitan, senam postpartum, pendidikan kesehatan gizi, istirahat, kebersihan diri, dan lain-lain.

3. Fase Letting go

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya. Fase ini berlangsung sepuluh hari setelah melahirkan/ibu sudah kembali dirumah. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Terjadi peningkatan akan perawatan diri dan bayinya. Ibu merasa lebih percaya

diri akan peran barunya, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya. Terjadi penyesuaian dalam hubungan keluarga untuk mengobservasi bayi, hubungan antar pasangan memerlukan penyesuaian dengan kehadiran anggota baru (bayi). Dukungan suami dan keluarga dalam merawat bayi akan sangat membantu ibu, sehingga kebutuhan akan istirahat tetap terpenuhi untuk menjaga kondisi fisiknya.

D. Kunjungan Masa Postpartum

Pelayanan postpartum ialah pelayanan kesehatan terpadu serta menyeluruh yang ditawarkan bagi ibu serta bayi selama enam jam hingga 42 hari setelah kelahiran. Layanan komprehensif disediakan di sini, termasuk pengumpulan riwayat, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (termasuk laboratorium), KB pascapersalinan, manajemen kasus, KIE, serta rujukan jika diperlukan. Kunjungan pascapersalinan digunakan sebagai sarana pengujian tindak lanjut pascapersalinan. Kunjungan postpartum atau biasa disebut dengan istilah KF dilakukan minimal empat kali. Kunjungan ibu dan bayi baru lahir dilakukan pada waktu yang bersamaan (Zakiyah, 2020).

1. Kunjungan kesatu (KF 1) dilaksanakan pada enam jam hingga 2 hari (48 jam) pasca melahirkan.
2. Kunjungan kedua (KF 2) dilaksanakan 3 sampai 7 hari pasca melahirkan.
3. Kunjungan ketiga (KF 3) dilakukan dari 8 hingga 28 hari pasca melahirkan.
4. Kunjungan keempat (KF 4) dilakukan dari 29 hingga 42 hari pasca melahirkan.

Kunjungan pertama dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan kunjungan kedua sampai dengan kunjungan keempat dapat dilakukan kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan.

E. Kebutuhan Dasar Ibu Postpartum

Menurut (Liana, 2019) kebutuhan dasar ibu postpartum adalah sebagai berikut:

1. Nutrisi dan Cairan Masalah nutrisi perlu mendapat perhatian karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Kebutuhan gizi ibu saat menyusui adalah sebagai berikut:
 - a. Konsumsi tambahan kalori 500 kalori tiap hari
 - b. Diet berimbang protein, mineral dan vitamin
 - c. Minum sedikitnya 2 liter tiap hari (+8 gelas)
 - d. Fe/tablet tambah darah sampai 40 hari pasca persalinan
 - e. Kapsul Vit. A 200.000 unit

2. Ambulasi dini (*early ambulation*) adalah kebijaksanaan agar secepatnya tenaga kesehatan membimbing ibu *post partum* bangun dari tempat tidur membimbing secepat mungkin untuk berjalan. Ibu *post partum* sudah diperbolehkan bangun dari tempat tidur dalam 24 - 48 jam postpartum. Hal ini dilakukan bertahap. Ambulasi dini tidak dibenarkan pada ibu *post partum* dengan penyulit misalnya anemia, penyakit jantung penyakit paru-paru, demam dan sebagainya. Keuntungan dari ambulasi dini:
 - a. Ibu merasa lebih sehat
 - b. Fungsi usus dan kandung kemih lebih baik.
 - c. Kita mengajarkan ibu untuk merawat bayinya.
 - d. Tidak ada pengaruh buruk terhadap proses pasca persalinan, tidak memengaruhi penyembuhan luka, tidak menyebabkan perdarahan, tidak memperbesar kemungkinan prolapsus atau retrotexto uteri
3. Eliminasi. Setelah 6 jam *post partum* diharapkan ibu dapat berkemih, jika kandung kemih penuh atau lebih dari 8 jam belum berkemih disarankan melakukan kateterisasi. Hal-hal yang menyebabkan kesulitan berkemih (*predlo urine*) pada *post partum*: Berkurangnya tekanan intra abdominal.
 - a. Otot-otot perut masih lemah.
 - b. Edema dan uretra
 - c. Dinding kandung kemih kurang sensitive
 - d. Ibu post partum diharapkan bisa defekasi atau buang air besar setelah hari kedua post partum jika hari ketiga belum defekasi bisa diberi obat pencahar oral atau rektal.
4. Kebersihan diri Pada masa postpartum seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu kebersihan tubuh pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sangat penting untuk tetap terjaga. Langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Anjurkan kebersihan seluruh tubuh terutama perineum
 - b. Mengajarkan ibu cara memberikan alat kelamin dengan sabun dan air dari depan ke belakang.
 - c. Sarankan ibu ganti pembalut setidaknya dua kali sehari .
 - d. Membersihkan tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan alat kelamin.
 - e. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi luka jahit pada alat kelamin, menyarankan untuk tidak menyentuh daerah tersebut.

F. Tanda Bahaya Masa Postpartum

1. Tanda bahaya masa postpartum menurut (Kemkes RI, 2023):
 - a. Demam lebih dari 2 hari
 - b. Perdarahan lewat jalan lahir
 - c. Keluar cairan berbau dari jalan lahir
 - d. Ibu terlihat sedih, murung, menangis tanpa sebab
 - e. Payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit
 - f. Nyeri ulu hati, mual muntah, sakit kepala, sakit pandangan kabur, kejang dengan atau tanpa bengkak pada kaki, tangan dan wajah.

2. Manajemen Laktasi

a. Pengertian

Manajemen laktasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh ibu, ayah dan keluarga untuk menunjang keberhasilan menyusui. Menyusui merupakan proses pemberian air susu kepada bayi baik secara langsung pada payudara ibu ataupun melalui pemerasan (*expresses breast-feeding*). Laktasi merupakan bagian terpadu dari proses reproduksi yang memberikan makanan bayi secara ideal dan alamiah serta merupakan dasar biologik dan psikologik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang ideal bagi pertumbuhan neonatus. Sejumlah komponen yang terkandung di dalam ASI sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan dan perlindungan pertama terhadap infeksi. Proses pembentukan air susu merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan hipotalamus, pituitari dan payudara, yang sudah dimulai saat fetus sampai pada masa pasca persalinan. ASI yang dihasilkan memiliki komponen yang tidak konstan dan tidak sama dari waktu ke waktu tergantung stadium laktasi (Azizah, 2019).

b. Manfaat ASI

ASI eksklusif memberikan dua manfaat sekaligus yaitu bagi ibu dan bayinya (Kemenkes, 2018). Manfaat yang ada adalah :

1) Bagi bayi

Bayi ASI merupakan sumber dari segala nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya karena mengandung makanan terlengkap untuk bayi yang diperlukan selama 6 bulan pertama, ASI juga mengandung antibody bagi bayi terutama untuk melancarkan pencernaan dan gangguan pernafasan. Dengan ibu taat memberikan ASI eksklusif sang bayi akan cepat berkembang sistem motorik sehingga pada bayi yg mendapat ASI eksklusif bayi cepat bisa berjalan.

Kandungan ASI melindungi bayi dari alergi. Bayi yang minum ASI memiliki kecenderungan untuk memiliki berat badan ideal.

2) Bagi ibu

Memberikan ASI bermanfaat untuk ibu di segala aspek kehidupannya. Dengan memberikan ASI membantu ibu mempercepat pengembalian uterus setelah melahirkan sehingga mengurangi pendarahan. Membantu menurunkan berat badan selama hamil sehingga ibu bisa kembali memiliki berat badan yang ideal, mempermudah ibu dalam kesehariannya karena bisa diberikan kapan saja dan dimana saja. Pemberian ASI secara eksklusif dapat berfungsi sebagai kontrasepsi karena isapan bayi merangsang hormon prolaktin yang menghambat terjadinya ovulasi sehingga menunda kesuburan. Kedekatan ibu dan bayi pun tetap terjalin sehingga ibu akan merasa bangga dan bahagia bisa menyusui bayinya.

c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran ASI

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses laktasi adalah makanan, ketenangan jiwa dan pikiran, dukungan suami dan keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis dan fisiologis payudara, pola istirahat, faktor isapan anak dan frekuensi penyusuan, berat badan lahir bayi, umur kehamilan saat melahirkan, menghirup asap rokok/polusi dan mengkonsumsi alkohol, usia ibu dan paritas (Purnami, 2019).

d. Proses Produksi Air Susu Ibu (ASI)

Pengeluaran ASI merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks antara rangsangan mekanik, saraf, dan bermacam-macam hormon (Purwanto, 2018). Pengaturan hormon terhadap pengeluaran ASI dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1) Produksi Air Susu Ibu (Prolaktin)

Prolaktin merupakan suatu hormon yang disekresi oleh glandula pituitary. Hormon ini memiliki peranan penting dalam produksi ASI. Peningkatan kadar prolaktin akan menghambat ovulasi, dan dengan demikian juga mempunyai fungsi kontrasepsi.

a) Refleks Prolaktin

Hormon Prolaktin berperan dalam produksi ASI di tingkat alveoli. Makin sering bayi menyusu maka makin banyak pula produksi ASI. Hisapan bayi akan merangsang puting susu dan payudara, karena ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Faktor pemacu sekresi prolaktin akan merangsang hipofise anterior sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli untuk mengambil protein, gula

dan lemak dari darah ibu. Semua bahan tersebut adalah bahan utama dalam pembuatan air susu.

b) Refleks Let Down

Hormon ini berfungsi memacu kontraksi otot polos yang ada di dinding alveolus dan dinding saluran, sehingga ASI dipompa keluar. Oksitosin akan bekerja memacu refleks pengeluaran ASI atau reflek oksitosin yang juga disebut Let Down Reflex. Tanda yang bisa diamati adalah keluarnya ASI dari payudara yang sedang tidak digunakan, perubahan pola hisapan bayi dari cepat dan dangkal menjadi lambat dan dalam, tanda bayi menelan ASI yaitu terdengar suara saat bayi menelan ASI, dan terlihat sedikit susu di sudut mulut bayi. Pada saat ibu memerah, Let Down Reflex dapat diamati dengan tanda keluarnya ASI yang sangat deras dan memancar ke segala arah dari payudara ibu. Faktor-faktor yang 16 mempengaruhi refleks aliran adalah melihat bayi, mendengar suara bayi, mencium bayi, dan memikirkan bayi.

2) Pengeluaran Air Susu Ibu (*Oksitosin*)

Apabila bayi disusui, maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat di dalam glandula pituitari posterior. Akibat langsung reflek ini adalah dikeluarkannya oksitosin dari pituitari posterior. Hal-hal ini kan menyebabkan sel-sel mioepitel (sel "keranjang" atau sel "laba-laba") disekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong air susu masuk kedalam pembuluh ampullae sehingga susu siap untuk dikonsumsi bayi. Pengeluaran oksitosin ternyata disamping dipengaruhi oleh isapan bayi juga dipengaruhi oleh reseptor yang terletak pada sistem duktus.

3) Pemeliharaan Air Susu Ibu

Dua faktor penting untuk pemeliharaan laktasi adalah rangsangan yaitu penghisapan oleh bayi akan memberikan rangsangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memeras air susu dari payudara atau menggunakan pompa. Bayi sebaiknya menghisap payudara hingga payudara kosong sebelum diberikan payudara yang lain. Apabila air susu yang diproduksi tidak dikeluarkan, maka laktasi akan tertekan (mengalami hambatan) karena terjadi pembengkakan alveoli dan sel keranjang tidak dapat berkontraksi. Air susu ibu tidak dapat dipaksa masuk ke dalam duktus laktifer.

e. Cara Menyusui Yang Benar

Menurut (Liana, 2019) mengatakan bagi ibu yang menyusui bayinya perawatan putting susu merupakan suatu hal yang sangat penting. Payudara harus 17 dibersihkan dengan teliti setiap hari selama mandi dan sekali lagi

ketika hendak menyusui. Hal ini akan mengangkat kolostrum yang kering atau sisa susu untuk mencegah akumulasi dan masuknya bakteri baik ke puting maupun ke mulut bayi. Salep atau krim khusus dapat digunakan untuk mencegah pecah-pecah pada puting. Cara menyusui yang benar (Fatimah, 2022):

- 1) Cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih yang mengalir.
 - 2) Keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola sekitarnya.
 - 3) Letakkan bayi menghadap perut ibu atau payudara, mulailah menyusui dari payudara yang terakhir belum dikosongkan.
 - 4) Jika payudara besar, pegang payudara dengan ibu jari dan jari lainnya menopang bagian payudara.
 - 5) Rangsang bayi menggunakan jari yang didekatkan ke sisi mulut bayi (bisa menggunakan kelingking).
 - 6) Dekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu, kemudian masukkan puting dan areola ke mulut bayi.
 - 7) Setelah payudara yang dihisap terasa kosong, lepaskan isapan bayi dengan menekan dagu ke bawah atau jari kelingking ibu ditempelkan ke mulut bayi. Susui berikutnya pada payudara berikutnya. Setelah itu keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola sekitarnya, kemudian biarkan kering dengan sendirinya (jangandilap).
 - 8) Sendawakan bayi.
- f. Dukungan Tenaga Kesehatan dalam Pemberian ASI
- Tenaga kesehatan mempunyai peranan yang sangat istimewa dalam menunjang pemberian ASI. Peran bidan dapat membantu ibu untuk memberikan ASI dengan baik dan mencegah masalah-masalah umum terjadi. Peranan awal tenaga kesehatan dalam mendukung pemberian ASI adalah (Ibrahim & Rahayu, 2021):
- 1) Meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang cukup dari payudara ibunya.
 - 2) Membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri.
 - 3) Membiarkan bayi bersama ibunya segera sesudah lahir selama beberapa jam pertama.
 - 4) Mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu untuk mencegah masalah umum yang timbul.
 - 5) Membantu ibu pada waktu pertama kali memberi ASI.
 - 6) Menempatkan bayi didekat ibu pada kamar yang sama (rawat gabung).
 - 7) Memberikan ASI pada bayi sesering mungkin.

8) Memberikan kolustrum dan ASI saja.

g. Tanda Bayi Cukup Minum ASI

Pada dasarnya, kebutuhan bayi terhadap ASI dan produksi ASI sangat bervariasi. Oleh karena itu, ibu sulit memprediksi tercukupi kebutuhan ASI pada bayi. Terkait hal ini, ibu perlu memperhatikan tanda-tanda kelaparan atau kepuasan yang ditunjukkan oleh bayi, serta penambahan berat badan bayi sebagai indikator kecukupan bayi terhadap ASI (Carolina, 2023).

Kecukupan minum pada bayi dapat dilihat dari kepuasan bayi menyusui dengan tanda-tanda bayi cukup ASI sebagai berikut:

1) Frekuensi bayi menyusui

Pada bayi umur 1 hingga 3 bulan yang cukup minum, frekuensinya akan teratur. Bayi akan terlelap setelah minum susu dan terbangun lagi untuk minum di waktu yang sama. Frekuensi 8-12 kali atau lebih dari 12 kali dalam sehari.

2) Bayi tampak puas

Tanda bayi cukup ASI bisa dilihat dari ekspresi bayi. Jika setelah menyusui bayi terlihat santai, tenang, tidak rewel dan puas, maka ini tanda bayi sudah cukup minum ASI. Sedangkan sebelum menyusui bayi akan rewel dan tidak nyaman, bayi yang baik pola minumnya, maka akan teratur juga jam minumnya 2-3 bangun untuk minum.

3) Bayi sering BAK

Pada beberapa hari awal setelah lahir atau saat bayi mendapatkan susu pertama biasanya bayi hanya dapat membasahi 1-2 popok perhari. Setelah ASI banyak diproduksi dan bayi mampu menyusui dengan baik maka bayi akan lebih sering BAK sehingga dapat membasahi 10-20 popok sehari. BAK bayi 11 cenderung berwarna kuning muda atau jernih. Frekuensi BAK bayi normal sebanyak 10-20 kali sehari. Dan semakin bertambahnya usia pada bayi frekuensinya semakin berkurang. Bayi harus BAK minimal 6 kali sehari sebagai tanda cukup ASI.

4) Pola BAB cenderung berkurang

Pada bulan pertama, bayi setidaknya BAB 2-5 kali sehari dengan warna kehijauan hingga keemasan. Warna feces mulai berubah kekuningan pada hari kelima setelah lahir. Setelah berusia 1 bulan, frekuensi BAB pada bayi semakin jarang. Setelah bayi mulai makan atau sekitar 6 bulan keatas frekuensinya semakin jarang yang mungkin akan 1 kali sehari. Frekuensi BAB pada bayi usia 0- 3 bulan yang mendapat ASI saja mengalami BAB 5-40 kali dalam seminggu atau sekitar 2-5 kali dalam sehari. Biasanya bayi umur 1

hari akan BAB 2 kali dalam sehari , dan semakin sering setelah minumnya tercukupi.

h. Tanda Bayi Tidak Cukup ASI

Tanda bayi tidak cukup ASI dapat ditandai dengan berat badan bayi yang terus menurun, bayi jarang BAK atau kurang dari 6 kali dalam sehari, warna feces bayi masih gelap, bayi akan rewel dan akan terlihat lesu, payudara ibu cenderung kencang dan tidak menyusut setelah disusui.

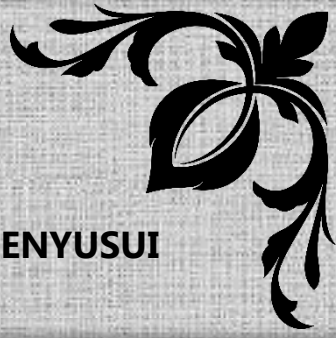
Menurut (Taqiyah et al., 2022) penilaian kepuasan bayi dapat dilihat melalui kecukupan bayi minum ASI dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai acuan untuk mengetahui keluarnya ASI dan jumlahnya mencukupi bagi bayi pada 2- 3hari pertama kelahiran,diantaranya adalah sebelum disusui payudara ibu terasa tegang, ASI yang banyak dapat keluar dari putting dengan sendirinya, ASI yang kurang dapat dilihat saat stimulasi pengeluaran ASI, ASI hanya sedikit yang keluar, bayi baru lahir yang cukup mendapatkan ASI maka BAK-nya selama 24 jam minimal 10-20 kali, warna urin kuning jernih, jika ASI cukup setelah menyusu maka bayi tertidur/tenang selama2-3jam kemudian bangun untuk minum lagi. Indikator lain untuk melihat bahwa produksi ASI mencukupi bagi bayi adalah karakteristik dari BAB bayi, Pada 24 jam pertama bayi mengeluarkan BAB yang berwarna hijau pekat, kental dan lengket, yang dinamakan dengan mekonium, BAB ini berasal dari saluran pencernaan bayi, serta cairan amnion.

Referensi

- Azizah, N. (2019). Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. In Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-78-2>.
- Carolina, M. (2023). fektivitas Bedside Teaching Teknik Menyusui Yang Benar Terhadap Keberhasilan Ibu Menyusui Di Ruang Nifas RSUD Kota Palangka Raya. *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan, Vol.1, No.(110)*.
- Ibrahim, F., & Rahayu, B. (2021). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 10(1)*, 18–24. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i1.497>
- Mufida, R. T., Rohmah, M., & Wungo, P. (2022). Analisis Ibu menyusui terhadap Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan. *Journal for Quality in Women's Health, 5(1)*, 36–41. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v5i1.90>
- Suciati, S., & Wulandari, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan, 10(2)*, 1–6. <https://journal.unita.ac.id/index.php/bidan/article/view/406>
- Sutrini, Entin, Aulia, & Aini, H. (2020). Hubungan Faktor-Faktor Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Bekerja Di Rsu Budi Kemuliaan. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan), 7(2)*, 385–394. <https://doi.org/10.36743/medikes.v7i2.243>
- Taqiyah, Y., Iftitah Alam, R., & Jama, F. (2022). Edukasi Kebutuhan Gizi Seimbang pada Ibu Menyusui di Ruang Nifas RSUD Ibnu Sina Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat, 2(1)*, 5–8.
- Ummah, K. (2021). Episiotomi. Ruri Yuni Astari. wahyuningsih, sri. (2019). Buku arajan asuhan keperawatan postpartum dilengkap dengan panduan persiapan praktikum mahasiswa keperwatan. CV.budi utama
- World Health Organization. (2022). *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience*. Geneva: WHO
- Zakiah, Z., Palifiana, D. A., & Ratnaningsih, E. (2020). *Buku Ajar FISILOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR*. Respati Press Universitas Respati Yogyakarta



CHAPTER 2



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN MENYUSUI

Dr. Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Proses menyusui merupakan fase dimana Ibu ikut berperan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) segera setelah bayi lahir sampai dengan enam bulan (ASI Eksklusif), dan tetap diteruskan sampai bayi berusia dua puluh empat bulan, akan memastikan kecukupan gizi yang dibutuhkan dan meningkatkan imunitas bayi sehingga lebih tahan terhadap penyakit. Nutrisi yang terkandung dalam ASI pada setiap tahap laktasi (kolostrum, ASI transisi, dan ASI matang) mengurangi faktor-faktor penyebab stunting, yaitu morbiditas bayi dan kurangnya asupan nutrisi pada bayi (Safaah et al., 2022). Produksi ASI pada ibu yang menyusukan bayinya lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui bayinya, padahal produksi ASI ini dibutuhkan untuk memenuhi kecukupan gizi bayi seiring pertambahan usianya. Selama masa menyusui Ibu post partum mampu memproduksi ASI sekitar 550-1000ml setiap hari (Kristiyansari, 2009). Proses menyusui termasuk didalamnya produksi ASI, seringkali menemui kendala, yang akhirnya menghambat bahkan menghentikan proses menyusui. Beberapa kendala yang sering dihadapi ibu bisa berasal dari individu Ibu maupun dari lingkungan luar Ibu, diantaranya permasalahan payudara dan puting, kesehatan ibu, kurangnya pengetahuan tentang ASI Eksklusif, pekerjaan ibu, pengalaman menyusui ibu sebelumnya yang kurang memuaskan, serta kemampuan dan kemudahan akses orang tua bayi dalam membeli susu formula (Cadwel & Turner-Maffei, 2013; Tim Kerja Hukum dan Humas, 2024). Kendala dari tenaga kesehatan juga ditemui dimana perawat merasa kurang pengetahuan dan pengalaman dalam mempromosikan pemberian ASI dan tidak menerima pendidikan khusus tentang pemberian ASI pada bayi prematur, seperti seberapa sering ibu harus memerah ASI dan kapan memulai memerah ASI setelah melahirkan (Lestari et al., 2025), padahal peran perawat sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan menyusui pada ibu post partum.

Data menunjukkan bahwa jumlah Ibu yang memberikan ASI eksklusif mengalami penurunan. Hasil survei di negara Australia didapatkan 81,4% dari 221 Ibu berniat untuk menyusui secara eksklusif, dengan 59% berencana untuk

melanjutkan setidaknya selama enam bulan, namun hanya 47% yang menyusui secara eksklusif selama tiga bulan pertama (Mokhlesi et al., 2025). Mengutip data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang menyatakan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia adalah 71,58%, 72,04%, dan 73,97% dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Data tersebut menunjukkan peningkatan persentase, meskipun masih jauh dari target nasional 100% (Lestari et al., 2025). Angka cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif hingga usia 6 bulan di Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai 81,2%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 74,8%, meskipun demikian pelaksanaan IMD yang dibutuhkan dalam mendukung ketercapaian pemberian ASI eksklusif dan meningkatkan lama pemberian ASI, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang awalnya sebesar 78,7% menjadi 69,1% (Triyono, 2025).

Upaya meningkatkan perilaku ibu postpartum dalam memberikan ASI pada bayinya harus terus digencarkan. Tiga faktor utama yang bisa diperkuat sehingga ibu lebih mudah dalam menjalankan peran penyusuan untuk bayinya. Faktor pertama adalah faktor predisposisi (*predisposing factors*) yang meliputi aspek sosio-demografi seperti status pekerjaan dan pendapatan. Faktor pemungkin (*enabling factors*) mencakup fasilitas yang mendukung terjadinya perubahan perilaku, seperti tempat bersalin dan ruang ASI di tempat kerja, dan faktor pendorong (*precipitating factors*) yang melibatkan pengaruh dari orang di sekitar ibu, seperti petugas kesehatan yang memberikan informasi tentang ASI eksklusif serta dukungan orang penting dalam kehidupan Ibu yaitu suami. Dukungan lingkungan, orang penting dalam kehidupan ibu seperti suami dan keluarganya terbukti dalam penelitian berhubungan secara signifikan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Arsi et al., 2026; Tim Kerja Hukum dan Humas, 2024). Perawat sebagai tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung keberhasilan menyusui, dimulai sejak masa persiapan kelahiran karena kadang kelahiran tidak bisa diprediksi apakah sesuai perkiraan atau bahkan maju, sehingga edukasi tentang pemberian ASI sejak masa antepartum sangat penting seperti waktu yang tepat memerah ASI 1-6jam setelah melahirkan, frekuensi memerah ASI bisa 8-10kali/hari, serta mempraktikkan cara melakukan pijatan yang lembut pada payudara (Lestari et al., 2025). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan proses menyusui pada masa post partum dibahas lebih rinci dalam uraian dibawah ini.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyusui

Faktor yang memengaruhi keberhasilan ibu post partum dalam menyusui bayinya dibagi dalam banyak perspektif. Penelitian Alabi et al., (2020) membagi menjadi 2 (dua) faktor besar yang memengaruhi keberhasilan menyusui Ibu post partum, yaitu Faktor internal meliputi yang meliputi pendidikan ibu, pengetahuan, Jenis kelamin bayi, usia ibu, ketersediaan waktu seorang ibu dalam menyusui yang berkaitan erat dengan status pekerjaan. Dan faktor eksternal meliputi Jenis persalinan (baik operasi pervaginam maupun caesar), masalah pada payudara/puting susu, ASI belum keluar pada hari pertama, nilai-nilai atau adat budaya, dukungan keluarga serta dukungan tenaga kesehatan. Hambatan lain pada proses menyusui yang ditemukan dari hasil penelitian Ramos-Morcillo et al., (2020) antara lain sikap dan motivasi, pengetahuan, kurangnya pelatihan ketika hamil, umur, persepsi, kurangnya sosialisasi dari tenaga kesehatan, tradisi atau budaya lingkungan, kurangnya persiapan sebelum melahirkan, dan peran keluarga dalam mengambil keputusan.

Uraian tentang faktor-faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan menyusui menurut berbagai sumber dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam diri Ibu

a. Faktor biologis

Faktor biologis yang bisa memengaruhi keberhasilan menyusui meliputi faktor usia Ibu, faktor paritas dan interval kehamilan, faktor permasalahan pada payudara yang dialami selama proses menyusui seperti puting lecet, puting rata/inverted, nyeri pada puting saat, selama dan setelah menyusui, payudara bengkak dan waktu ASI pertama keluar (Alabi et al., 2020; Cadwel & Turner-Maffei, 2013). Beberapa penelitian menghasilkan simpulan berbeda dengan tinjauan teoritis terkait usia, paritas dan interval kehamilan dengan keberhasilan menyusui dalam hal ini pemberian ASI eksklusif. Hasil analisis menunjukkan tidak ada korelasi signifikan antara variabel tersebut. Meskipun secara teoritis interval kehamilan yang pendek dapat memengaruhi kondisi fisik ibu dan produksi ASI, namun sebagian besar ibu masih mampu memberikan ASI eksklusif dengan sukses bahkan ketika interval kehamilan kurang dari dua tahun (Arsi et al., 2026). Produksi ASI sendiri dipengaruhi banyak faktor diantaranya makanan yang dikonsumsi ibu, ketenangan jiwa dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomi payudara, lama istirahat/tidur, isapan bayi, dan obat-obatan yang dikonsumsi selama masa menyusui (Kristiyansari, 2009).

Faktor biologis yang juga pernah dilakukan penelitian mengenai keterkaitannya dengan lama menyusui adalah tingkat kesuburan ibu. Hal ini dilihat dari berapa lama ibu mulai hamil (*time to pregnancy/TTP*) yang dihitung dari awal mulai melakukan hubungan seksual dengan dinyatakan positif hamil. *Cut off* lama TTP dihitung 3bulan atau kurang. Meskipun diagnosis infertil adalah tidak adanya kehamilan setelah 12bulan melakukan hubungan seksual aktif, tetapi waktu 3bulan digunakan sebagai waktu awal dimana pasangan suami istri bisa menjalani konseling kesuburan. Hasil penelitian didapatkan ada korelasi TTP dengan lama menyusui, dimana ibu dengan TTP pendek cenderung lebih bisa mencapai lama menyusui yang dianjurkan. Hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa TTP pendek lebih banyak pada pasangan dengan usia yang kurang dari 35tahun, yang juga menjelaskan bahwa ibu dengan TTP memanjang berkurang pemberian ASI eksklusifnya dikarenakan faktor hormonal dimana kadar prolaktin dan oksitosin lebih rendah sehingga memengaruhi produksi ASI (Li et al., 2025).

b. Faktor pengetahuan dan persepsi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemberian ASI eksklusif tidak berkorelasi positif. Para ibu mungkin tidak benar-benar mengetahui tentang pemberian ASI eksklusif, sehingga mereka mungkin tidak melaksanakan proses menyusui dengan benar. Semakin baik pengetahuan ibu tentang masalah ini, semakin efektif cakupan pemberian ASI eksklusif. Pada ibu dengan pengetahuan positif yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, biasanya dipengaruhi oleh faktor internal, yang didukung oleh kurangnya pendidikan tentang manfaat dan isi pemberian ASI eksklusif (Nurul et al., 2023). Pengetahuan yang baik didukung oleh faktor pengalaman dan pelatihan yang pernah diikuti. Ibu yang menjalani pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan dan membuat ibu menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif, termotivasi, percaya diri, dan lebih mampu mengatasi masalah selama menyusui (Afriyani et al., 2022).

c. Faktor sikap dan motivasi Ibu

Sikap ibu terhadap pemberian ASI juga memengaruhi durasinya. Ibu yang menganggap pemberian ASI lebih sehat, mudah, dan nyaman akan menyusui lebih lama dibandingkan ibu yang menganggap pemberian ASI membatasi, membuat tidak nyaman, dan merepotkan (Lestari et al., 2025). Sikap merupakan kesiapan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu, yang melibatkan pikiran dan perasaan. Reaksi dapat berupa perilaku positif atau negatif. Jika ibu menyusui memiliki penerimaan positif tentang pemberian ASI eksklusif, akan membuat keputusan untuk memberikan

ASI eksklusif dan akan terus memberikannya. Hubungan yang signifikan antara sikap dan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif menentukan kesediaan seseorang untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan (Nurul et al., 2023).

Menyusui didorong oleh motivasi dari dalam individu ibu yaitu keyakinan bahwa ibu bisa menyusui. Faktor keyakinan ibu secara statistik mempunyai nilai koefisien paling tinggi menuju ke keberhasilan menyusui pada ibu nifas, sedangkan isyarat bertindak yang dipunyai Ibu memengaruhi keberhasilan menyusui secara tidak langsung, dimana ibu harus melalui pencapaian peran terlebih dahulu baru berhasil menyusui bayinya (Safaah, 2024). Motivasi pribadi dan pengalaman hidup ibu yang mendorong keputusan pemberian ASI pada bayi. Sebagian besar ibu menindaklanjuti niat pemberian ASI yang dirasakan sebelum melahirkan. Namun, banyak yang berhenti lebih awal dari yang direncanakan yaitu terjadi dalam beberapa bulan pertama postpartum, sebagian besar disebabkan oleh tantangan yang berkaitan dengan persepsi kurangnya produksi ASI, rasa sakit, atau kelelahan (Staal et al., 2026).

d. Faktor pekerjaan

Ibu bekerja dan menyusui sudah ada sejak dahulu, perbedaannya dengan saat sekarang adalah, ibu bekerja diluar rumah sehingga harus meninggalkan bayinya. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan kesulitan dalam pengaturan menyusui. Ibu bekerja tentu akan lebih kesulitan dalam memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja, karena ibu bekerja harus membagi waktu mereka untuk bekerja dan menyusui, sementara ibu yang tidak bekerja memiliki banyak waktu dan dapat lebih fokus pada menyusui bayinya (Afriyani et al., 2022). Beberapa strategi yang berhasil dilakukan dalam menyiasati kondisi ini adalah dengan menyusui pada jam istirahat jika tempat kerja dekat dengan rumah/penitipan bayi, melakukan pemompaan ASI selama bekerja dan menyimpannya sehingga bisa dikonsumsi bayi setelahnya. Banyak ibu yang sudah mengumpulkan ASI di sela-sela menyusui bayinya selama masa cuti melahirkan, sebagai persiapan saat kembali bekerja (Cadwel & Turner-Maffei, 2013). Penambahan cuti melahirkan yang diperpanjang dan perbaikan kebijakan tentang dukungan menyusui di tempat kerja dapat memberikan manfaat kesehatan masyarakat yang substansial dengan memfasilitasi praktik menyusui eksklusif yang berkelanjutan di kalangan ibu bekerja, dan juga kebijakan tempat kerja secara khusus seperti fleksibilitas tempat kerja dan ketersediaan fasilitas menyusui berhubungan erat dengan tingkat pemberian ASI yang lebih tinggi (Staal et al., 2026).

- e. Faktor riwayat penyakit/tindakan medis pada ibu (operasi pada payudara, operasi bariatric lambung pada ibu)

Ibu yang pernah mendapatkan prosedur augmentasi payudara (bedah plastik kosmetik yang bertujuan untuk memperbesar ukuran, memperbaiki bentuk, atau mengoreksi payudara yang tidak simetris), reduksi payudara (prosedur bedah plastik yang bertujuan mengurangi ukuran, berat, dan volume payudara dengan mengangkat kelebihan jaringan lemak, kelenjar, dan kulit) memiliki peluang laktasi tidak adekuat dan insufisiensi menyusui yang lebih besar, serta cenderung berhenti menyusui lebih cepat dari pada ibu yang tidak pernah mengalaminya (Hurst, 1996; Souto, et.al., 2003 dalam (Cadwel & Turner-Maffei, 2013)). Tindakan pembedahan lain yang pernah diteliti keterkaitannya dengan proses menyusui adalah operasi bariatrik (prosedur pembedahan pada saluran pencernaan yang bertujuan membantu penurunan berat badan secara drastis). Ibu menyusui dengan riwayat operasi tersebut mengalami permasalahan produksi ASI yang tidak cukup disebabkan asupan kalori harian yang direkomendasikan selama menyusui sulit dicapai bagi ibu pasca operasi bariatrik, karena kapasitas lambung yang berkurang dan faktor psikologis dapat membatasi konsumsi makanan. Faktor lain yang memengaruhi produksi ASI dan keberhasilan menyusui karena kadar prolaktin menurun dalam satu tahun setelah operasi dan kulit payudara yang kendur setelah penurunan berat badan juga menjadi permasalahan menyusui lain yang terkait dengan operasi bariatrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami kulit payudara kendur setelah penurunan berat badan memiliki kemungkinan 75% lebih kecil untuk menyusui selama lebih dari 6 bulan (Mokhlesi et al., 2025).

- f. Faktor pengalaman menyusui

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pengalaman menyusui positif lebih cenderung menyusui dan melanjutkan menyusui dalam jangka waktu yang lebih lama, meskipun ibu mempunyai riwayat pembedahan yang berkaitan dengan penurunan berat badan, tetapi pengalaman menyusui positif dalam studi ini mengacu pada perasaan puas, percaya diri, dan terpenuhi ibu saat menyusui setelah operasi bariatrik, tanpa merasa cemas tentang pengelolaan berat badan atau mengembalikan bentuk tubuh mereka. Ibu dengan pengalaman menyusui yang positif sebelumnya merasa yakin bahwa mereka memiliki cukup ASI dapat memberi nutrisi pada bayi mereka dan dapat mengelola berat badan mereka secara efektif setelah operasi bariatrik (Mokhlesi et al., 2025). Pengalaman menyusui bisa dikaitkan dengan usia dan paritas. Beberapa penelitian menghasilkan temuan yang saling

melengkapi, dimana ada yang menemukan bahwa usia ibu lebih muda cenderung lebih patuh dalam pemberian ASI eksklusif dikarenakan paparan informasi yang lebih luas dan keikutsertaan dalam konseling laktasi. Tetapi ada juga yang menemukan bahwa usia muda lebih kecil partisipasinya dalam memberikan ASI eksklusif dikarenakan mereka menghadapi tantangan yang besar dalam mempertahankan ASI eksklusif. Hal ini dihubungkan dengan beberapa faktor diantaranya persaingan tanggung jawab sosial dan ekonomi, pengalaman yang terbatas dalam perawatan bayi, dan usia muda rentan terhadap tekanan teman sebaya atau keluarga yang menghalangi pemberian ASI (Disha et al., 2025).

g. Faktor jenis persalinan

Ibu melahirkan dengan caesar menemui kendala menyusui bayinya segera setelah persalinan, disebabkan pemberian anestesi terutama anestesi umum, adanya luka operasi di abdomen, serta bisa dari bayi yang mengantuk dan tidak responsif untuk menyusu terutama pada ibu yang mendapatkan obat penghilang rasa sakit sebelum operasi (Kristiyansari, 2009). Hubungan antara cara persalinan dan praktik pemberian makan bayi dini tetap menjadi isu sensitif dalam kebijakan promosi menyusui, dengan bukti yang menunjukkan bahwa persalinan normal mendukung pemberian ASI eksklusif, sedangkan operasi caesar dikaitkan dengan penggunaan susu formula sejak dini dan dikaitkan dengan praktik pemberian ASI yang kurang optimal. Hal ini mendukung perlunya meninjau kembali prosedur rumah sakit, terutama di lingkungan bedah obstetri untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi pemberian ASI yang dimulai segera setelah persalinan baik pervagina atau pun secara caesar (Minarini et al., 2025).

2. Faktor dari luar Ibu

a. Faktor dukungan keluarga/suami dan faktor pengambilan keputusan

Keberhasilan ibu dalam menyusui didukung oleh orang-orang di sekitar mereka yang membantu ibu dalam proses menyusui sehingga proses menyusui menjadi menyenangkan. Perasaan bahagia juga timbul karena bayi yang dinantikan telah lahir, diikuti dengan keluarga terutama suami yang memberikan dorongan melalui ucapan-ucapan positif kepada ibu. Semakin baik dukungan dalam bentuk verbal yang diperoleh, semakin baik lingkungan tempat tinggal, maka akan semakin baik kondisi fisik dan emosional ibu, sehingga dapat memengaruhi tingkat efikasi dirinya. Persuasi verbal ini memungkinkan seorang ibu untuk merasa kuat secara fisik dan mendapat dukungan mental. Sikap positif dan komentar-komentar manis dari suami dan

anggota keluarga lainnya, meskipun kecil dapat membantu meredakan kelelahan dan memberikan dukungan emosional bagi ibu (Putri et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, dimana sebagian besar ibu yang menerima dukungan keluarga tinggi berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Peran keluarga penting dalam memperkuat motivasi dan kepercayaan diri ibu selama proses menyusui, bisa dalam bentuk pemberian dukungan emosional, informasi dan instrumental. Dukungan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan praktis dalam kegiatan sehari-hari, yang memungkinkan ibu untuk lebih efektif fokus pada pemberian ASI. Keterlibatan keluarga, khususnya dukungan dari suami dan anggota keluarga dekat lainnya sangat penting dalam mempromosikan keberhasilan praktik pemberian ASI eksklusif (Arsi et al., 2026).

Peran dan tanggung jawab suami dalam proses menyusui meningkat setelah diberikan intervensi berupa "Menyusui–Awal yang Baik Bersama" untuk dukungan pemberian ASI. Suami yang awalnya memandang bahwa kehamilan, persalinan, dan menyusui dipandang sebagai tanggung jawab ibu. Hal ini berawal dari persepsi bahwa perbedaan biologis menjadi alasan untuk pembagian tanggung jawab orang tua. Meskipun mereka mengakui bahwa menyusui dipandang sebagai "tugas bersama orang tua," keterlibatan praktis mereka tetap terbatas. Peran mereka terutama dipahami sebagai pendukung pasangan mereka, bukan sebagai peserta aktif dalam proses menyusui. Suami lebih menekankan pada peran penyedia sumber daya keuangan. Hasil penelitian dengan intervensi ini menunjukkan bahwa suami bisa ditingkatkan perannya melalui pengaktifan kesadaran para ayah akan peran penting mereka dalam keberhasilan menyusui, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam praktik menyusui (Jacobsen et al., 2025).

b. Faktor dukungan tenaga kesehatan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ibu kurang mendapatkan edukasi menyusui selama kunjungan prenatal. Meskipun jumlah kunjungan prenatal menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan pemberian ASI eksklusif, namun data kualitatif mengungkapkan bahwa penyedia layanan perawatan prenatal belum memberikan edukasi tentang menyusui (Minarini et al., 2025). Tenaga kesehatan mempunyai kewajiban yang diamanahkan oleh kebijakan pemerintah, dimana harus memberikan dukungan dalam bentuk konseling menyusui sehingga keberhasilan menyusui meningkat. Tenaga kesehatan berperan meningkatkan pengetahuan ibu tentang laktasi dengan memberikan promosi kesehatan yang berupa pelatihan

atau pendidikan kesehatan saat ibu melakukan kunjungan perawatan antenatal. Promosi kesehatan tentang laktasi bisa diberikan langsung saat ibu mengunjungi fasilitas kesehatan dan juga bisa dilakukan melalui daring/online. Hasil penelitian menyebutkan ibu yang mengikuti kegiatan promosi kesehatan tentang laktasi meningkat pengetahuan dan keterampilannya. Ibu menjadi lebih percaya diri, termotivasi, dan sangat berkomitmen terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Afriyani et al., 2022). Tenaga kesehatan bisa mengintegrasikan promosi kesehatan laktasi pada masa sebelum dan setelah melahirkan, meningkatkan tindak lanjut dengan perawat komunitas untuk kunjungan rumah, melakukan pembinaan jejaring dukungan kelompok menyusui sehingga capaian keberhasilan menyusui dapat ditingkatkan (Disha et al., 2025).

c. Faktor sosial ekonomi dan demografi

Pendidikan ibu yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan pemberian ASI, hal ini dimungkinkan kemudahan dalam mengakses informasi tentang manfaat menyusui sehingga menyadari pentingnya menyusui eksklusif di masa bayi. Pendidikan juga mengarahkan ibu dalam menggunakan sistem perawatan kesehatan secara lebih efektif untuk mencari dukungan menyusui. Untuk mengatasi hambatan menyusui di kalangan ibu yang kurang berpendidikan, perlu adanya inisiatif pendidikan/pelatihan yang membekali mereka dengan pengetahuan dan sumber daya penting untuk mendukung menyusui yang berkelanjutan (Haddad et al., 2025). Meskipun pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan manfaat menyusui, pendidikan juga membuat para ibu terpapar praktik pemberian makan alternatif seperti pemberian susu formula, terutama di lingkungan perkotaan di mana pemasaran komersial pengganti ASI sangat marak (Disha et al., 2025).

d. Faktor sosial, tradisi, budaya

Faktor budaya dari keluarga dimana mereka masih mempunyai keyakinan bahwa dengan pemberian ASI saja tidak dapat mengenyangkan bayi, dan banyak ibu di pedesaan yang tidak memberikan kolostrum pada bayi, karena dianggap sebagai susu basi yang tidak baik untuk bayi. Keyakinan yang menganggap bahwa kolostrum yang berwarna kekuningan kental merupakan zat yang beracun sehingga harus dibuang. Kenyataannya bahwa kolostrum merupakan ASI yang keluar pada hari pertama dan dua hari berikutnya namun pada dua hari berikutnya memiliki kadar gizi menurun dibandingkan hari pertama yang mengandung banyak protein dan immunoglobulin (IgA) serta leukosit yang dapat melawan mikroba patogen pada bayi (Hasnah & Ramadhani, 2024; Safaah, 2024).

e. Faktor bayi (kondisi dan situasi anak yang dirawat di Rumah Sakit)

Bayi baru lahir kadang memerlukan perawatan setelah dilahirkan, yang mengharuskan menjalani rawat inap di rumah sakit. Selama masa perawatan bayi yang hanya diberi susu formula selama 48 jam pertama kehidupan memiliki risiko 28 kali lebih besar lebih mungkin diberi susu formula saat keluar dari rumah sakit daripada diberi ASI eksklusif, dibandingkan dengan bayi yang tidak menerima susu formula selama rawat inap. Hubungan yang signifikan secara statistik juga teridentifikasi antara jumlah hari pemberian susu formula hingga penghentian pemberian ASI eksklusif dan jenis pemberian makan saat keluar dari rumah sakit (Minarini et al., 2025). Dari perspektif ibu, hambatan utama untuk menyusui bayi yang dirawat di ruang perawatan intensif disebabkan kurangnya pengetahuan tentang cara meningkatkan laktasi atau cara menyimpan ASI dengan benar, kurangnya dukungan untuk menyusui dan mempertahankan keberhasilan laktasi, volume ASI yang sedikit dan tidak memuaskan, serta keterbatasan waktu kunjungan dan waktu pemberian ASI di ruang perawatan intensif (Lestari et al., 2025). Pada kelahiran berisiko tinggi, banyak ibu melaporkan bahwa *skin to skin contact* tidak dilakukan pada bayi prematur atau bayi yang membutuhkan perawatan intensif segera setelah persalinan. Kelahiran dengan risiko tinggi, mengganggu implementasi "periode emas" yaitu periode penting yang dilakukan untuk merangsang produksi ASI, memulai menyusui dini, dan memperkuat ikatan emosional ibu dan bayi. Praktik kontak kulit dengan kulit yang merupakan bentuk dukungan menyusui yang dirasakan ibu sebagai pilar fundamental untuk keberhasilan menyusui menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, intervensi rumah sakit dan pendidikan harus diperkuat untuk mengurangi konsekuensi negatif dari pemisahan dan kesulitan memulai laktasi.

f. Faktor regulasi rumah sakit

Inisiasi menyusui dini yang dilakukan sebagai prosedur perawatan di ruang persalinan, dengan memberikan kontak kulit ke kulit langsung antara ibu dengan bayi baru lahir, tetap berada dalam pelukan ibu selama 30 menit atau selama satu jam atau lebih, diterima ibu sebagai dukungan emosional dan menjadikan pengalaman positif terhadap proses menyusui (Minarini et al., 2025). Prosedur IMD tepat digunakan untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif dan proses menyusui yang berlanjut hingga 24 bulan usia bayi. Kebijakan tentang menempatkan bayi dalam satu ruangan dengan ibu setelah lahir (rawat gabung/rooming in) juga membantu ibu menyadari peran barunya dengan melihat manusia baru lahir dari dirinya (Hastuti, 2022).

C. Program Pemerintah dalam Mendukung Keberhasilan Menyusui

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi ibu menjalankan perannya selama inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, dan selama proses menyusui. Pembahasan mengenai inisiasi menyusui dini (IMD) yaitu proses bayi diletakkan di dada ibu segera setelah lahir untuk memfasilitasi *skin to skin contact* (kontak kulit ibu ke kulit bayi) dalam Peraturan Pemerintah RI No 33 Tahun 2012 sudah dijelaskan secara lebih eksplisit jika dibandingkan dengan KMK No 450/MENKES/SK/VI/2004. Informasi dalam peraturan ini sudah diberikan penjelasan dengan jelas bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif dan durasi pemberian ASI Eksklusif hingga usia bayi 6 bulan dengan tidak menambahkan makanan atau minuman lain. Perubahan mengenai isi kebijakan IMD terletak pada durasi inisiasi menyusui dini paling singkat 1 jam (60 menit) (Hasnah & Ramadhani, 2024).

KMK No 450/MENKES/SK/VI/2004 menyebutkan bahwa aktor yang memiliki peran dalam keberhasilan proses menyusui adalah semua tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini terdapat dalam keputusan bahwa tenaga kesehatan berkewajiban menginformasikan pada ibu baru melahirkan untuk memberikan ASI Eksklusif. Keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif ini juga di dukung dengan optimalnya pelaksanaan PP 15 tahun 2013. Salah satunya adalah dukungan tempat bekerja seperti penyediaan ruang laktasi yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Regulasi mewajibkan pengusaha/tempat kerja menyediakan ruang laktasi dan waktu untuk memerah ASI, dimana dibutuhkan ruangan yang nyaman, memiliki pintu yang dapat dikunci, sirkulasi udara baik, dan luas yang memadai. Sedangkan untuk waktu menyusui Ibu bekerja berhak mendapatkan kesempatan memerah ASI atau menyusui selama jam kerja (Kementrian Kesehatan RI,, n.d.).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024, adalah peraturan yang memperketat perihal promosi susu formula yang berpotensi menghambat ASI Eksklusif. Peraturan tersebut juga terdapat pengawasan bagi produsen dan distributor. Bagi produsen atau distributor susu formula bayi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif. Produsen juga wajib memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk jika melakukan pemberian bantuan Susu Formula pada pihak tenaga kesehatan dan lain-lain. Peraturan Pemerintah Pemerintah ini sejalan dengan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly/WHA*) tentang "*Ending the Inappropriate Promotion of Foods for Infants and Young Children*" (Mengakhiri Promosi Makanan yang Tidak Tepat untuk Bayi dan Anak Kecil) mengamanatkan larangan donasi materi informasi

dan edukasi oleh industri, yang selaras dengan panduan dari WHA tersebut, termasuk larangan total terhadap hadiah atau insentif untuk petugas kesehatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 juga menegaskan ibu berhak mendapat dukungan keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pada pasal 45 juga disebutkan bahwa peran aktif orang tua/keluarga dalam upaya kesehatan anak dilakukan melalui IMD. Pemerintah memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana (denda atau penjara) bagi pihak yang menghalangi pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan UU Kesehatan yang berlaku. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka stunting, dan menjamin hak-hak ibu menyusui di ruang publik maupun tempat kerja adalah tujuan dari regulasi ini disusun.

D. Simpulan

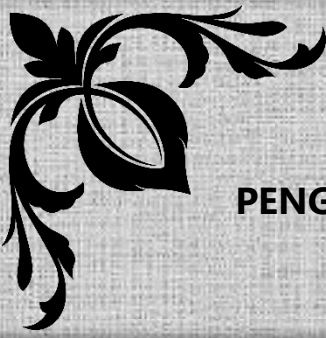
Permasalahan menyusui memerlukan perhatian khusus yang melibatkan semua sektor, mulai dari individu ibu, lingkungan sekitar, petugas kesehatan, sampai dengan Pemerintah. Faktor yang secara empiris terbukti memengaruhi keberhasilan proses menyusui harus diperkuat dan dimanfaatkan untuk meningkatkan ketercapaian cakupan IMD, keberhasilan pemberian ASI eksklusif, sampai dengan lama menyusui mencapai usia bayi 24 bulan. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Pemerintah harus mengembangkan dan menyediakan pelayanan kesehatan antenatal yang komprehensif dimana menysasar ibu muda dan berpendidikan rendah serta mengawasi pelaksanaan regulasi pengganti ASI, 2) Tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah terjadwal kepada ibu-ibu dengan bayi berusia 0-6 bulan untuk memantau praktik menyusui dan mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi, 3) Bagi para ibu, untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan konseling laktasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Posyandu, 4) Suami dan anggota keluarga diharapkan memberikan dukungan nyata dalam perawatan bayi, memberikan motivasi, menyediakan makanan bergizi bagi ibu, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan menciptakan lingkungan rumah yang nyaman selama periode menyusui.

Referensi

- Afriyani, A. I., Wulaningsih, I., Sari, N., & Khalimah, N. (2022). Related Factors To Exclusive Breastfeeding To Postpartum Mothers. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 4(2), 367–372. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v4i2.1159>.
- Alabi, T. A., Adejoh, S. O., Atinge, S., & Umahi, E. (2020). Social and Bio-Medical Predictors of Exclusive Breastfeeding Among Nursing Mothers in Lagos and Taraba States, Nigeria. *Journal of Pediatric Nursing*, 52(52), e96–e102. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.12.002>
- Arsi, R., Rachmawati, U., & Afdhal, F. (2026). Factors associated with exclusive breastfeeding success among breastfeeding mothers in Ogan Komering Ulu Regency, Indonesia: A cross-sectional study. *Lentera Perawat*, 7(2), 260–269. <https://jurnal.stikesalmaarif.ac.id/index.php/lenteraperawat/>
- Cadwel, K., & Turner-Maffei, C. (2013). *Manajemen Laktasi, Buku Saku, edisi terjemahan bahasa Indonesia* (D. Widiarti & A. O. Tampubolon, Eds.). EGC.
- Disha, D. B. Z., Rahman, M. S., & Mahin, M. I. (2025). Breastfeeding Practices and Associated Factors Among Mothers of Infants Aged 12 Months or Younger Attending Selected Tertiary Hospital in Dhaka, Bangladesh. *Food Science and Nutrition*, 13(12). <https://doi.org/10.1002/fsn3.71323>
- Haddad, C., Boutros, P. H., Sacre, H., Rizk, R., EL Khoury, C. F., Abdallah, B., Karam, J., & Salameh, P. (2025). Differential effects of work and socioeconomic status on breastfeeding duration in times of crisis. *Discover Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00790-5>
- Hasnah, F., & Ramadhani, F. D. (2024). Analisis Kebijakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif di Indonesia. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.33757/jik.v8i1.746>
- Hastuti, P. (2022). Konsep Asuhan Keperawatan Nifas (Postnatal). In R. O. Adesta (Ed.), *Keperawatan Maternitas* (pp. 141–167).
- Jacobsen, M. H., Gadeberg, A. K., Rossau, H. K., Nilsson, I. M. S., & Villadsen, S. F. (2025). Understanding fathers' responses to breastfeeding as a "shared parental task": a realist evaluation of a Danish breastfeeding support intervention. *Archives of Public Health*, 83(1). <https://doi.org/10.1186/s13690-025-01790-2>
- Kementrian Kesehatan RI; (n.d.). *Penjelasan Aturan Susu Formula Bayi*. Biro

- Kristiyansari, W. (2009). *ASI, Menyusui & SADARI* (Sujiantini; & A. Setiawan, Eds.; 4th ed.). Nuha Medika.
- Lestari, P. M., Ramadanti, A., Latifah, M. E., Sutrisno, M. A. F., Andrina, H., & Stevanny, B. (2025). Factors Affecting Breastfeeding Practice among Mothers with Hospitalized Neonates. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.24198/obgynia.v8i1.707>
- Li, J., Hong, X., Zhu, X., Wu, J., Yang, H., Zhang, X., & Wang, B. (2025). The associations between female fecundability and postpartum breastfeeding: A prospective cohort study. *Plos One*, 20(9 September), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0331877>
- Minarini, G., Lima, E., Figueiredo, K., Carmona, A. P., Bueno, M., Monroy, N., & Primo, C. (2025). Factors Influencing Exclusive Breastfeeding During the Postpartum Period: A Mixed-Methods Study. *Nutrients*, 17(18), 1–16. <https://doi.org/10.3390/nu17182992>
- Mokhlesi, S. S., Vasilevski, V., & Sweet, L. (2025). Factors associated with breastfeeding in women with a history of bariatric surgery: A cross-sectional survey study. *Midwifery*, 148(May), 104496. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2025.104496>
- Nurul, R., Mukhlisah, N., Radhiah, S., Patui, N. S., Yani, A., & Krisnasari, S. (2023). Factors Associated with Exclusive Breastfeeding at the Bulili Health Center, South Bureaubuli Village, Palu City. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17(3), 640–646. <https://doi.org/10.33860/jik.v17i3.2907>
- Putri, R. A., Indriani, L., Hasina, S. N., Budury, S., & Santy, W. H. (2025). Factors Related to Breastfeeding Self Efficacy of Exclusive ASI in the Mawar Room RSI Jemursari Surabaya. *Journal Of Nursing Practice*, 8(3), 516–524. <https://doi.org/10.30994/jnp.v8i3.443>
- Ramos-Morcillo, A. J., Harillo-Acevedo, D., Armero-Barranco, D., Leal-Costa, C., Moral-García, J. E., & Ruzafa-Martínez, M. (2020). Barriers Perceived by Managers and Clinical Professionals Related to the Implementation of Clinical Practice Guidelines for Breastfeeding through the Best Practice Spotlight Organization Program. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(17), 1–17. <https://doi.org/10.3390/IJERPH17176248>

- Safaah, N. (2024). *Pengembangan Model Pencapaian Peran Ibu Berbasis Health Beliefe Model Terhadap Keberhasilan Menyusui Pada Ibu Nifas*. Universitas Airlangga.
- Safaah, N., Yunitasari, E., Efendi, F., Sunanita, S., & Suhartono, S. (2022). Relationship between exclusive breastfeeding and stunting among children aged 2-5 years in Indonesia. *Gaceta Medica de Caracas*, (1019–1024), 130. <https://doi.org/https://doi.org/10.47307/GMC.2022.130.s5.21>
- Staal, I. I. E., Manshanden, N., Schreuder, A., Vermeulen, M. J., van den Akker, C. H. P., Buurman, M., van Drongelen, K., Velzel, J., & Bouwmeester-Landweer, M. B. R. (2026). Prevalences and determinants of newborn feeding practices in the Netherlands: insights from the 2023 national survey. *European Journal of Public Health*, 36(2). <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckag055>
- Tim Kerja Hukum dan Humas, R. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Ibu Dalam Memberikan Asi Eksklusif*. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3694/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kegagalan-ibu-dalam-memberikan-asi-eksklusif
- Triyono, E. A. (2025). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2024. In *Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. <https://dinkes.jatimprov.go.id>



CHAPTER 3



PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA IBU POSTPARTUM DALAM PEMBERIAN ASI

Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan

Masa postpartum merupakan periode penting dalam kehidupan ibu dan bayi setelah persalinan. Periode ini terjadi berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial pada ibu yang memerlukan penyesuaian pada ibu, salah satunya produksi dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) (Lowdermilk et al., 2020). ASI merupakan makanan atau sumber nutrisi terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi lengkap, antibodi, serta faktor pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang dan meningkatkan daya tahan tubuh bayi (Hockenberry & Wilson, 2019). Pemberian ASI selain bermanfaat bagi bayi, juga bagi ibu yaitu membantu mempercepat involusi uterus, memperlambat ikatan emosional ibu dan bayi, menurunkan risiko perdarahan postpartum dan beberapa penyakit pada ibu (Pillitteri, 2018). Dukungan pelayanan kesehatan yang optimal sangat diperlukan untuk keberhasilan menyusui, salah satunya melalui pengkajian keperawatan yang komprehensif pada ibu postpartum.

Pengkajian keperawatan pada ibu postpartum dalam pemberian ASI dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan psikologis ibu serta kemampuan ibu dalam menyusui. Pengkajian ini penting agar berbagai masalah yang dapat menghambat proses laktasi dapat dikenali sejak dini dan segera ditangani (Lowdermilk et al., 2020). Beberapa aspek yang perlu dikaji meliputi status laktasi dan produksi ASI, kondisi payudara dan puting susu, posisi dan teknik menyusui, refleksi let-down, kondisi bayi saat menyusu, serta dukungan keluarga dan keadaan emosional ibu (Hockenberry & Wilson, 2019). Dengan pengkajian yang tepat, perawat dapat memberikan intervensi dan edukasi yang sesuai untuk membantu kelancaran proses menyusui serta mencegah terjadinya masalah seperti bendungan ASI, puting lecet, mastitis, maupun kegagalan pemberian ASI eksklusif (Pillitteri, 2018).

Pemberian ASI telah diakui secara global sebagai intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa praktik menyusui yang optimal mampu menyelamatkan ratusan ribu nyawa bayi setiap tahun serta menurunkan risiko berbagai penyakit pada ibu, termasuk kanker payudara. Selain itu, ASI eksklusif

selama enam bulan pertama kehidupan terbukti dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak, memperkuat daya tahan tubuh, serta menurunkan risiko penyakit infeksi dan penyakit kronis di masa mendatang. Dengan berbagai manfaat tersebut, pemberian ASI bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dasar yang harus didukung oleh tenaga kesehatan melalui pelayanan yang profesional dan berkesinambungan.

Meskipun manfaat ASI sangat besar, praktik menyusui masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat global maupun nasional. Banyak ibu belum mampu memberikan ASI eksklusif secara optimal karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, rendahnya dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, serta adanya hambatan sosial dan budaya. Di Indonesia sendiri, cakupan pemberian ASI eksklusif memang menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun angka tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan. Selain itu, masih banyak bayi yang belum mendapatkan ASI pada satu jam pertama setelah kelahiran dan sebagian bayi telah menerima makanan tambahan sejak awal kehidupan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara rekomendasi kesehatan dan praktik yang terjadi di lapangan.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI pada ibu postpartum. Melalui pengkajian yang sistematis dan berkesinambungan, perawat dapat membantu ibu memahami cara menyusui yang benar, meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat dan menyusui bayinya, serta memberikan dukungan emosional selama masa adaptasi setelah melahirkan (Lowdermilk et al., 2020). Dengan demikian, pengkajian keperawatan tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik ibu dan bayi, tetapi juga berperan dalam menciptakan pengalaman menyusui yang nyaman, meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, dan mendukung kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh (Hockenberry & Wilson, 2019).

B. Tujuan Pengkajian Pada Ibu Postpartum Terkait Pemberian ASI

Pengkajian keperawatan pada ibu postpartum terkait pemberian ASI merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses asuhan keperawatan. Melalui pengkajian, perawat dapat memahami kondisi ibu dan bayi secara menyeluruh sehingga kebutuhan dan masalah yang berkaitan dengan proses menyusui dapat diketahui lebih awal. Pengkajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan tindakan dan intervensi yang tepat untuk mendukung keberhasilan pemberian ASI. Pengkajian yang tidak optimal dapat mengakibatkan tidak teridentifikasi sejak dini atau

terlambatnya ditangani hal-hal yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI, seperti produksi ASI yang kurang, kesalahan teknik menyusui, atau masalah pada payudara, (Hockenberry & Wilson, 2019).

Pengkajian keperawatan pada ibu postpartum terkait pemberian ASI juga bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi fisik ibu. Masa nifas ditandai dengan perubahan fisiologis yang signifikan, seperti proses involusi uterus, penyembuhan luka, dan adaptasi produksi ASI. Masalah seperti bendungan ASI, puting lecet, dan mastitis dapat muncul jika tidak dilakukan pemantauan yang baik. Oleh karena itu, pengkajian fisik menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan menyusui (Lowdermilk et al., 2020).
2. Mengidentifikasi kondisi psikologis ibu. Aspek psikologis ibu juga perlu dikaji secara menyeluruh. Ibu nifas rentan mengalami kecemasan, stres, hingga depresi postpartum yang dapat memengaruhi hormon oksitosin dan prolaktin dalam proses laktasi. Kondisi emosional yang tidak stabil dapat menghambat pengeluaran ASI, sehingga pengkajian psikologis menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan (WHO, 2022).
3. Membantu menilai tingkat pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyusui. Banyak ibu yang belum memahami teknik menyusui yang benar, seperti posisi dan perlekatan bayi. Kesalahan teknik merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pemberian ASI eksklusif. Dengan pengkajian yang tepat, perawat dapat memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan ibu (UNICEF, 2021)..
4. Mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dukungan keluarga serta lingkungan yang dapat memengaruhi praktik menyusui. Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap praktik menyusui. Kepercayaan tradisional, kurangnya dukungan keluarga, serta pengaruh lingkungan dapat menjadi hambatan dalam pemberian ASI. Oleh karena itu, pengkajian sosial menjadi penting untuk memahami konteks kehidupan ibu dan memberikan intervensi yang tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2021).
5. Mendapatkan data yang akurat dan sebagai dasar dalam penyusunan diagnosis dan intervensi keperawatan. Data yang akurat memungkinkan perawat menentukan prioritas masalah serta merancang tindakan yang efektif dan individual. Tanpa pengkajian yang komprehensif, intervensi yang diberikan cenderung tidak tepat sasaran (Potter et al., 2021).
6. Deteksi dini komplikasi pada ibu dan bayi. Bayi yang tidak mendapatkan ASI dengan baik berisiko mengalami malnutrisi, infeksi, dan gangguan pertumbuhan. Sementara itu, ibu dapat mengalami gangguan laktasi atau infeksi payudara. Deteksi dini melalui pengkajian akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

(WHO, 2023).

7. Mendukung pencapaian target kesehatan global terkait pemberian ASI eksklusif. Organisasi Kesehatan Dunia menargetkan peningkatan cakupan ASI eksklusif hingga minimal 70% pada tahun 2030. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, sangat penting dalam mencapai target tersebut melalui pengkajian dan pendampingan yang berkelanjutan (WHO & UNICEF, 2023).
8. Membangun hubungan terapeutik antara perawat dan ibu. Komunikasi yang baik selama proses pengkajian dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu serta memperkuat motivasi dalam menyusui. Dukungan emosional dari tenaga kesehatan terbukti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI (Rollins et al., 2016).
9. Membantu memastikan keberlanjutan pemberian ASI setelah ibu kembali ke rumah. Perawat dapat menilai kesiapan ibu dalam menghadapi tantangan menyusui secara mandiri, termasuk dukungan keluarga dan lingkungan. Hal ini penting untuk mempertahankan praktik ASI eksklusif hingga enam bulan (Kemenkes RI, 2021).

C. Komponen Pengkajian Keperawatan Pada Ibu Postpartum Terkait Pemberian ASI

Komponen pengkajian ibu postpartum dalam pemberian ASI harus dilakukan secara komprehensif (biologis, psikologis, sosial, dan teknis menyusui) karena keberhasilan laktasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut adalah komponen utama yang perlu dikaji:

1. Data Identitas dan Riwayat Kesehatan

Pengkajian data identitas dan riwayat kesehatan meliputi umur, paritas, pendidikan, pekerjaan, serta riwayat kehamilan dan persalinan. Riwayat persalinan secara normal atau operasi sesar penting dikaji karena dapat memengaruhi inisiasi menyusui dini dan kenyamanan ibu saat menyusui (Lowdermilk et al., 2020).

2. Kondisi Fisik Ibu

Pengkajian kondisi fisik ibu meliputi:

a. Tanda vital (suhu, nadi, tekanan darah),

Pengkajian tanda vital pada ibu menyusui penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran kondisi fisiologis ibu selama masa laktasi serta membantu mendeteksi secara dini adanya komplikasi yang dapat memengaruhi keberhasilan menyusui dan pemberian ASI. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan frekuensi pernapasan dapat menunjukkan

adanya infeksi, nyeri, kelelahan, perdarahan postpartum, maupun stres fisik yang dapat menghambat produksi dan pengeluaran ASI. Suhu tubuh yang meningkat, misalnya, dapat mengindikasikan mastitis atau bendungan ASI, sedangkan perubahan tekanan darah dan nadi dapat menunjukkan gangguan hemodinamik yang memengaruhi kondisi ibu secara umum. Selain itu, kondisi fisik ibu yang stabil akan mendukung proses pelepasan hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan penting dalam produksi dan pengeluaran ASI. Oleh karena itu, pengkajian tanda vital menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan pada ibu postpartum untuk mendukung keberhasilan menyusui secara optimal (Dewi et al., 2025; Rosa et al., 2025; Cahyanti et al. 2024).

b. Kondisi payudara

Kondisi payudara perlu dikaji secara menyeluruh karena sangat memengaruhi kelancaran proses menyusui. Pengkajian meliputi bentuk payudara, kesimetrisan, adanya bendungan ASI, serta tanda-tanda mastitis. Payudara yang normal umumnya berbentuk bulat, tampak penuh pada bagian atas dan bawah, posisi payudara sejajar, serta ukuran payudara kanan dan kiri relatif sama. Kondisi ini mendukung proses produksi dan pengeluaran ASI yang optimal (Wambach & Spencer, 2021).

Selain menilai bentuk payudara, perawat juga perlu mengkaji adanya bendungan ASI. Bendungan ASI biasanya ditandai dengan payudara terasa penuh dan keras, terdapat benjolan, payudara tampak bengkak dan kemerahan, terasa panas saat disentuh, serta menimbulkan nyeri terutama saat menyusui. Pada kondisi ini, aliran ASI sering kali menjadi tersendat sehingga bayi mengalami kesulitan saat menyusu. Jika tidak segera ditangani, bendungan ASI dapat menyebabkan ibu merasa tidak nyaman dan mengganggu keberhasilan pemberian ASI (Lowdermilk et al., 2020; Pillitteri, 2018; Sihite, N. A. R. F., Novayelinda, R., & Lestari, 2022).

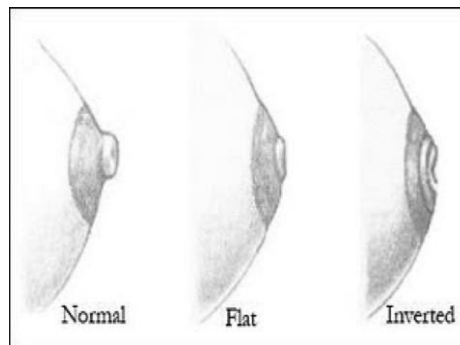
Pengkajian juga perlu memperhatikan tanda-tanda mastitis, yaitu peradangan pada payudara yang umumnya disebabkan oleh infeksi atau bendungan ASI yang tidak tertangani. Mastitis ditandai dengan payudara membengkak, terasa tegang dan panas saat disentuh, kulit payudara tampak kemerahan, sering berbentuk seperti potongan baji, serta nyeri yang menetap dan dapat bertambah saat menyusui. Pada beberapa kasus, dapat ditemukan penebalan jaringan atau benjolan pada payudara. Kondisi ini biasanya disertai gejala sistemik seperti demam tinggi dengan suhu lebih dari 38°C, menggigil, nyeri otot, dan tubuh terasa lemas atau kelelahan (Amir, Forster, Lumley, & McLachlan, 2007; Academy of Breastfeeding Medicine, 2022). Oleh karena itu,

pengkajian kondisi payudara sangat penting dilakukan agar masalah menyusui dapat dikenali sejak dini dan segera mendapatkan penanganan yang tepat.

c. Kondisi puting payudara menonjol, datar atau lecet

Pengkajian kondisi puting payudara merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan pada ibu menyusui karena kondisi puting sangat memengaruhi keberhasilan proses menyusui. Puting yang sehat dan normal akan memudahkan bayi melekat dengan baik sehingga proses pengisapan ASI dapat berlangsung efektif (Riordan & Wambach, 2019; Hockenberry & Wilson, 2021). Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji bentuk dan keadaan puting payudara secara menyeluruh, seperti apakah puting tampak menonjol, datar, terbenam, atau mengalami lecet dan nyeri.

- 1) Puting menonjol Puting menonjol merupakan kondisi normal di mana puting tampak keluar atau menonjol dari areola payudara. Kondisi ini sangat mendukung proses menyusui karena memudahkan bayi untuk melekat dan mengisap payudara secara efektif. Bayi dapat memasukkan puting dan sebagian areola ke dalam mulut dengan lebih mudah sehingga proses pengeluaran ASI berlangsung optimal (Riordan & Wambach, 2019; Pillitteri, 2018).



Gambar 3. 1 Kondisi Puting Pada Payudara

Sumber: <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/seputar-payudara-7>

Pada pengkajian, perawat melakukan observasi terhadap bentuk puting baik saat payudara dalam keadaan istirahat maupun setelah diberikan rangsangan ringan, seperti sentuhan atau stimulasi lembut. Puting yang normal biasanya akan tetap tampak menonjol atau semakin menonjol saat dirangsang. Selain itu, perawat juga dapat menilai apakah terdapat kelainan lain seperti nyeri, lecet, atau tanda iritasi pada puting (Riordan & Wambach, 2019; Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021).

Ibu dengan puting menonjol umumnya tidak mengalami hambatan dalam proses menyusui karena bayi lebih mudah melakukan pelekatan yang benar. Kondisi ini membantu proses menyusui menjadi lebih nyaman, efektif, dan

mendukung kecukupan ASI bagi bayi. Namun demikian, edukasi mengenai teknik menyusui yang tepat tetap perlu diberikan agar ibu dapat mempertahankan kenyamanan dan mencegah terjadinya masalah pada puting selama masa menyusui (Riordan & Wambach, 2019; Pillitteri, 2018).

2) Puting Datar

Puting datar merupakan kondisi ketika puting payudara tidak tampak menonjol keluar, melainkan terlihat rata dengan area areola. Kondisi ini dapat memengaruhi proses menyusui karena bayi mungkin mengalami kesulitan untuk melekat dan mengisap payudara secara optimal. Akibatnya, proses menyusui dapat menjadi kurang efektif dan berisiko menghambat pengeluaran ASI. Pengkajian puting datar dilakukan melalui inspeksi bentuk puting payudara dan dapat dibantu dengan teknik *pinch test*. Teknik ini dilakukan dengan menekan area areola secara perlahan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah puting dapat menonjol keluar atau tetap datar. Melalui pengkajian ini, perawat dapat menilai tingkat kesulitan yang mungkin dialami ibu dan bayi selama proses menyusui (Riordan & Wambach, 2019; Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021).

Ibu dengan puting datar tetap dapat berhasil menyusui apabila mendapatkan dukungan dan penanganan yang tepat. Perawat perlu memberikan edukasi mengenai teknik pelekatan yang benar agar bayi dapat mengisap sebagian besar areola, bukan hanya puting. Selain itu, stimulasi puting sebelum menyusui, seperti pijatan ringan atau penggunaan teknik tertentu untuk membantu puting lebih menonjol, juga dapat dianjurkan untuk mempermudah bayi saat menyusui. Dukungan dan pendampingan yang baik sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya (Riordan & Wambach, 2019; Academy of Breastfeeding Medicine, 2021).

3) Puting Lecet

Puting lecet merupakan salah satu masalah yang sering dialami ibu menyusui dan dapat mengganggu kenyamanan selama proses menyusui. Kondisi ini ditandai dengan adanya kemerahan, luka, nyeri, kulit puting pecah-pecah, bahkan terkadang disertai perdarahan. Puting lecet umumnya terjadi akibat pelekatan bayi yang kurang tepat, posisi menyusui yang salah, atau frekuensi menyusui yang tidak sesuai sehingga puting mengalami gesekan berulang saat bayi menyusui (Riordan & Wambach, 2019; Kent et al., 2015). Pada pengkajian, perawat perlu menilai keluhan yang dirasakan ibu, seperti nyeri saat menyusui, rasa perih, atau sensasi terbakar pada

puting. Selain itu, dilakukan observasi terhadap kondisi kulit puting untuk melihat adanya luka, kemerahan, pembengkakan, pecah-pecah, maupun tanda inflamasi dan infeksi. Perawat juga perlu mengkaji teknik dan posisi menyusui yang dilakukan ibu karena hal tersebut sering menjadi penyebab utama terjadinya puting lecet (Riordan & Wambach, 2019; Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021).

Puting lecet dapat menyebabkan ibu merasa takut menyusui karena rasa nyeri yang muncul saat bayi mengisap payudara. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, proses menyusui dapat terganggu dan berisiko menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Kent et al., 2015; Riordan & Wambach, 2019). Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai teknik pelekatan yang benar, posisi menyusui yang nyaman, serta perawatan puting payudara agar proses menyusui tetap berjalan dengan baik dan nyaman bagi ibu maupun bayinya.

d. Adanya rasa nyeri

Rasa nyeri seperti nyeri pada luka perineum maupun nyeri luka operasi sesar, merupakan hal yang perlu dikaji pada ibu postpartum karena kondisi fisik ini sangat memengaruhi kemampuan dan kenyamanan ibu dalam menyusui. Nyeri yang dirasakan ibu dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat duduk, bergerak, atau mencari posisi menyusui yang tepat sehingga proses menyusui menjadi kurang optimal. Akibatnya, ibu mungkin menjadi takut menyusui, frekuensi menyusui berkurang, dan produksi ASI dapat terhambat (Pillitteri, 2018; Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021).

Pada pengkajian, perawat perlu menilai lokasi, intensitas, durasi, serta karakteristik nyeri yang dirasakan ibu. Selain itu, perlu dikaji apakah nyeri muncul saat bergerak, duduk, menggendong bayi, atau ketika menyusui. Pengamatan terhadap kondisi luka juga penting dilakukan, seperti adanya kemerahan, bengkak, perdarahan, atau tanda infeksi pada luka perineum maupun luka operasi. Perawat dapat menggunakan skala nyeri untuk membantu menilai tingkat keparahan nyeri yang dialami ibu (Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021; Lowdermilk, Perry, Cashion, & Alden, 2020).

Nyeri yang tidak tertangani dengan baik dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis ibu, seperti menyebabkan kelelahan, stres, dan gangguan istirahat, yang pada akhirnya berdampak pada proses laktasi. Oleh karena itu, perawat perlu memberikan dukungan dan intervensi yang tepat, seperti membantu ibu menemukan posisi menyusui yang nyaman, mengajarkan teknik relaksasi, serta memberikan edukasi mengenai perawatan luka agar ibu

tetap dapat menyusui dengan nyaman dan optimal (Lowdermilk, Perry, Cashion, & Alden, 2020; Pillitteri, 2018).

3. Status Laktasi dan Produksi ASI

Pengkajian status Laktasi dan Produksi ASI meliputi

a. Waktu mulai menyusui (inisiasi dini atau tidak)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses meletakkan bayi di dada atau perut ibu segera setelah lahir selama minimal satu jam agar bayi dapat mencari puting susu dan mulai menyusui secara alami. IMD berperan penting dalam merangsang produksi hormon prolaktin dan oksitosin yang mendukung produksi dan pengeluaran ASI. Perawat perlu menanyakan waktu pertama kali bayi disusui setelah lahir, apakah dilakukan dalam satu jam pertama kehidupan atau setelahnya. Selain itu, dikaji pula keberhasilan pelekatan bayi, respons hisapan bayi, dan hambatan yang dialami ibu selama proses menyusui awal.

Pelaksanaan IMD berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan meningkatkan keberlangsungan menyusui hingga enam bulan (Widström et al., 2019). Bayi yang mendapatkan kesempatan IMD memiliki refleks menyusui yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan IMD. Inisiasi menyusui dini memberikan manfaat fisiologis dan psikologis baik bagi ibu maupun bayi, seperti meningkatkan ikatan ibu dan bayi (*bonding attachment*), menjaga suhu tubuh bayi, serta menurunkan risiko kematian neonatal (Safari, Aryankhesal, dan Ghiasvand, 2018). Oleh karena itu, pengkajian terkait waktu mulai menyusui penting dilakukan untuk menentukan kebutuhan edukasi dan intervensi laktasi pada ibu postpartum.

b. Frekuensi menyusui

Frekuensi menyusui merupakan salah satu komponen penting dalam pengkajian status laktasi pada ibu postpartum. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan pemberian ASI, efektivitas proses menyusui, keberhasilan produksi ASI, dan membantu mengidentifikasi masalah laktasi seperti kurangnya produksi ASI, pelekatan yang tidak efektif, atau bayi yang kurang aktif menyusui. Frekuensi menyusui dikaji dengan menanyakan jumlah menyusui bayi dalam 24 jam, durasi menyusui, serta pola menyusui bayi baik siang maupun malam hari. Perawat juga perlu menilai apakah bayi menyusui sesuai kebutuhan (*on demand feeding*) atau berdasarkan jadwal tertentu (Riordan & Wambach, 2019; Hockenberry & Wilson, 2021).

Pemberian ASI sesuai kebutuhan bayi berkaitan dengan keberhasilan ASI eksklusif yang lebih tinggi dibandingkan pemberian ASI terjadwal (Brown, Raynor, dan Lee, 2011). Frekuensi menyusui yang lebih sering berhubungan dengan peningkatan produksi ASI karena stimulasi hisapan bayi akan

merangsang pelepasan hormon prolaktin dan oksitosin (Kent et al., 2012). Bayi baru lahir umumnya menyusui sebanyak 8–12 kali dalam 24 jam, terutama pada minggu-minggu awal kehidupan. Frekuensi menyusui yang kurang dapat menyebabkan penurunan produksi ASI dan meningkatkan risiko bendungan ASI pada ibu (Academy of Breastfeeding Medicine, 2022; Riordan & Wambach, 2019).

c. Tanda kecukupan ASI (bayi puas, BAK/BB meningkat)

Pengkajian tanda kecukupan ASI pada bayi merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan ibu menyusui karena dapat menggambarkan apakah kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dengan baik. Pengkajian ini tidak hanya berfokus pada jumlah ASI yang keluar, tetapi juga pada respons dan kondisi bayi setelah menyusui. Bayi yang mendapatkan ASI cukup umumnya tampak tenang, aktif, dan memiliki pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan proses menyusui berjalan efektif (Riordan & Wambach, 2019; Hockenberry & Wilson, 2021).

Salah satu tanda utama kecukupan ASI dapat dilihat dari frekuensi buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB) bayi. Bayi yang memperoleh ASI cukup biasanya buang air kecil sekitar 6–8 kali per hari dengan warna urin jernih atau kuning muda. Selain itu, bayi juga tampak puas setelah menyusui, tidak terus-menerus menangis karena lapar, dan dapat tidur dengan nyaman di antara waktu menyusui. Perawat juga perlu mengkaji pola hisapan bayi saat menyusui, seperti adanya hisapan yang kuat dan ritmis disertai suara menelan, yang menunjukkan ASI masuk dengan baik (Riordan & Wambach, 2019; Pillitteri, 2018).

Kenaikan berat badan bayi juga menjadi indikator penting dalam menilai kecukupan ASI. Bayi yang mendapatkan ASI cukup akan mengalami peningkatan berat badan sesuai usia dan tampak sehat serta aktif. Selain itu, payudara ibu biasanya terasa lebih lunak setelah menyusui karena ASI telah dikeluarkan dengan baik. Melalui pengkajian yang tepat, perawat dapat mendeteksi lebih dini apabila terdapat tanda ketidakcukupan ASI sehingga dapat segera memberikan edukasi, dukungan, dan intervensi yang diperlukan untuk membantu keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Hockenberry & Wilson, 2021; Riordan & Wambach, 2019).

d. Refleks *let-down* (pengeluaran ASI).

Refleks *let-down* atau refleks pengeluaran ASI merupakan proses keluarnya ASI dari alveoli menuju duktus laktiferus akibat rangsangan hormon oksitosin yang dipicu oleh hisapan bayi, sentuhan pada payudara, maupun

kondisi emosional ibu. Pada pengkajian status laktasi dan produksi ASI, refleksi let-down perlu dikaji karena sangat memengaruhi kelancaran pemberian ASI. Ibu dengan refleksi let-down yang baik biasanya menunjukkan tanda seperti ASI menetes atau memancar saat bayi menyusui, rasa penuh atau kesemutan pada payudara, bayi tampak menelan secara ritmis, serta bayi terlihat puas setelah menyusui. Sebaliknya, stres, kecemasan, kelelahan, nyeri, dan kurangnya stimulasi dapat menghambat pelepasan oksitosin sehingga pengeluaran ASI menjadi tidak lancar (Riordan & Wambach, 2019; Uvnäs-Moberg et al., 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hormon oksitosin memiliki peran penting dalam proses menyusui dan refleksi let-down. Stimulasi oksitosin berhubungan dengan perilaku mengisap bayi dan keberhasilan menyusui pada periode awal postpartum. Intervensi relaksasi seperti meditasi, musik, dan mindfulness dapat meningkatkan produksi ASI serta menurunkan stres ibu menyusui, yang secara tidak langsung membantu memperlancar refleksi let-down (Uvnäs-Moberg et al., 2020; Erickson, Emeis, & Simonian, 2023).

Pengkajian dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan sederhana pada ibu menyusui. Pada anamnesis, perawat menanyakan apakah ibu merasakan sensasi tertentu saat ASI keluar, seperti rasa kesemutan, penuh, hangat, atau kontraksi ringan pada payudara ketika bayi mulai menyusui. Selain itu, dikaji juga faktor yang dapat memengaruhi refleksi let-down, seperti stres, kecemasan, kelelahan, nyeri, rasa percaya diri ibu, serta frekuensi menyusui (Riordan & Wambach, 2019; Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021).

Pada observasi, perawat memperhatikan tanda-tanda *refleksi let-down*, seperti ASI menetes atau memancar dari payudara, bayi tampak mengisap dengan ritme teratur disertai suara menelan, perubahan pola hisapan bayi dari cepat menjadi lambat dan dalam, serta bayi tampak puas setelah menyusui. Perawat juga dapat mengamati apakah ASI keluar dari payudara sebelah lain saat bayi menyusui pada satu sisi. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan menilai kondisi payudara sebelum dan sesudah menyusui, misalnya payudara terasa lebih lunak setelah menyusui sebagai tanda ASI keluar dengan baik. Jika refleksi *let-down* tidak optimal, biasanya ibu mengeluh ASI sulit keluar, bayi tampak rewel saat menyusui, atau proses menyusui berlangsung lama namun bayi belum puas (Riordan & Wambach, 2019; Lowdermilk, Perry, Cashion, & Alden, 2020).

4. Teknik Menyusui

Pengkajian teknik menyusui meliputi

a. Posisi ibu dan bayi

Posisi menyusui yang benar membantu bayi melekat dengan baik pada payudara sehingga proses pengeluaran ASI menjadi optimal dan ibu merasa nyaman selama menyusui. Perawat menilai posisi tubuh ibu apakah dalam keadaan rileks dan nyaman, seperti duduk atau berbaring dengan penopang yang baik pada punggung dan lengan. Selain itu, dikaji posisi bayi meliputi kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus, tubuh bayi menghadap ke tubuh ibu, serta mulut bayi berada sejajar dengan puting payudara. Posisi yang tepat memungkinkan bayi mendapatkan perlekatan yang efektif pada areola dan mengurangi risiko puting lecet. Teknik dan posisi menyusui yang benar berhubungan signifikan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif serta menurunkan kejadian nyeri puting pada ibu menyusui. Posisi yang tidak tepat dapat menyebabkan bayi sulit mengisap ASI secara efektif sehingga bayi menjadi cepat lapar dan produksi ASI dapat menurun (Kronborg et al., 2018). Edukasi posisi menyusui yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat meningkatkan keterampilan ibu dalam menyusui dan memperbaiki kualitas pelekatan bayi pada payudara. Oleh karena itu, pengkajian posisi ibu dan bayi perlu dilakukan secara rutin agar masalah menyusui dapat dideteksi dan ditangani lebih dini (Coke et al., 2021).

b. Perlekatan (*latch on*)

Perlekatan yang baik sangat menentukan efektivitas pengeluaran ASI, kenyamanan ibu saat menyusui, serta kecukupan nutrisi bayi. Pada pengkajian, perawat menilai apakah mulut bayi membuka lebar saat menyusu, dagu bayi menempel pada payudara, bibir bayi terutama bibir bawah terlipat keluar, dan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Selain itu, perawat juga mengobservasi adanya suara menelan, irama hisapan bayi, serta keluhan nyeri pada ibu. Perlekatan yang benar memungkinkan bayi mengisap ASI secara efektif dan membantu pengosongan payudara secara optimal.

Perlekatan yang tidak tepat merupakan salah satu penyebab utama masalah menyusui seperti puting lecet, nyeri payudara, dan kegagalan ASI eksklusif. Bayi yang tidak melekat dengan baik cenderung tidak mendapatkan ASI secara optimal sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan dan kepuasan bayi setelah menyusu (Thompson et al., 2016). Teknik perlekatan yang baik berkaitan dengan transfer ASI yang lebih efektif dan meningkatkan keberhasilan menyusui jangka panjang. Edukasi dan pendampingan mengenai teknik perlekatan oleh tenaga kesehatan terbukti membantu ibu

meningkatkan keterampilan menyusui dan mengurangi risiko penghentian ASI dini (Kent et al., 2015). Oleh karena itu, pengkajian pelekatan perlu dilakukan secara rutin pada ibu postpartum untuk mendeteksi masalah menyusui lebih awal dan menentukan intervensi yang tepat dalam mendukung keberhasilan laktasi.

c. Cara bayi mengisap.

Cara mengisap yang efektif menunjukkan bahwa bayi mampu memperoleh ASI dengan cukup dan membantu pengosongan payudara secara optimal. Pada pengkajian, perawat mengobservasi pola hisapan bayi selama menyusui, meliputi kekuatan hisapan, irama mengisap dan menelan, serta respons bayi setelah menyusui. Bayi yang mengisap dengan baik biasanya menunjukkan hisapan yang kuat dan teratur disertai suara menelan yang jelas. Selain itu, pipi bayi tampak bulat saat mengisap dan tidak cekung ke dalam. Setelah menyusui, bayi umumnya tampak puas dan tenang. Efektivitas cara bayi mengisap dipengaruhi oleh koordinasi antara gerakan lidah, rahang, dan proses menelan.

Hisapan bayi yang efektif membantu pengeluaran ASI secara optimal dan merangsang produksi ASI yang adekuat. Sebaliknya, hisapan yang lemah atau tidak teratur dapat menyebabkan bayi tidak mendapatkan ASI yang cukup serta meningkatkan risiko bendungan ASI pada ibu (Geddes et al., 2012). Bayi dengan teknik mengisap yang baik memiliki transfer ASI yang lebih efektif dibandingkan bayi dengan pola hisapan yang kurang optimal. Pengkajian cara bayi mengisap juga penting untuk mendeteksi adanya gangguan menyusui, seperti pelekatan yang tidak tepat atau masalah oral motorik pada bayi. Dengan demikian, pengkajian cara bayi mengisap merupakan bagian penting dalam evaluasi teknik menyusui untuk mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan kesehatan ibu maupun bayi (Kent et al., 2013).

5. Kondisi Bayi

Pengkajian kondisi bayi meliputi

a. Refleks mengisap dan menelan

Pengkajian kondisi bayi pada proses menyusui penting dilakukan untuk menilai kemampuan bayi memperoleh ASI secara efektif. Salah satu aspek utama yang dikaji adalah refleks mengisap (*sucking reflex*) dan refleks menelan (*swallowing reflex*). Kedua refleks ini merupakan refleks fisiologis yang sangat berperan dalam keberhasilan proses menyusui, terutama pada bayi baru lahir. Pada pengkajian, perawat mengobservasi kemampuan bayi dalam melekat pada payudara, kekuatan hisapan, irama mengisap dan menelan, serta koordinasi antara mengisap, menelan, dan bernapas. Refleks mengisap yang

baik ditandai dengan gerakan hisapan yang kuat, ritmis, dan teratur, sedangkan refleks menelan ditandai dengan adanya suara atau gerakan menelan setelah beberapa kali hisapan. Bayi yang memiliki refleks mengisap dan menelan yang efektif umumnya tampak tenang dan puas setelah menyusui (Hockenberry & Wilson, 2021; Riordan & Wambach, 2019).

Refleks mengisap dan menelan yang baik berperan penting dalam efektivitas transfer ASI dari payudara ibu ke bayi. Koordinasi oral motorik yang optimal membantu bayi mendapatkan nutrisi yang cukup dan mendukung pertumbuhan bayi. Sebaliknya, gangguan pada refleks mengisap dan menelan dapat menyebabkan kesulitan menyusui, asupan ASI tidak adekuat, dan peningkatan risiko gangguan pertumbuhan (Geddes et al., 2012). Koordinasi mengisap, menelan, dan bernapas berkembang secara bertahap pada bayi baru lahir dan menjadi indikator penting maturitas neurologis bayi. Bayi dengan refleks yang lemah atau tidak terkoordinasi memerlukan pemantauan dan intervensi khusus agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi (Lau dan Smith, 2011). Oleh karena itu, pengkajian refleks mengisap dan menelan perlu dilakukan secara rutin pada bayi baru lahir untuk mendeteksi dini gangguan menyusui dan mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

b. Berat badan dan kenaikannya

Pengkajian berat badan dan kenaikan berat badan bayi merupakan bagian penting dalam evaluasi status nutrisi dan keberhasilan pemberian ASI. Berat badan menjadi indikator utama untuk menilai apakah bayi memperoleh asupan ASI yang cukup dan mengalami pertumbuhan yang optimal. Pada bayi baru lahir, penurunan berat badan sementara pada beberapa hari pertama kehidupan merupakan kondisi fisiologis, namun setelah itu berat badan diharapkan meningkat secara bertahap (Hockenberry & Wilson, 2021; Riordan & Wambach, 2019).

Pada pengkajian, perawat menilai berat badan lahir, perubahan berat badan harian, serta pola kenaikan berat badan bayi sesuai usia. Bayi umumnya mengalami penurunan berat badan sekitar 5–10% pada minggu pertama setelah lahir dan kembali ke berat badan lahir dalam 10–14 hari. Setelah periode tersebut, kenaikan berat badan menjadi indikator penting kecukupan nutrisi dan efektivitas menyusui yaitu naik $\pm 20\text{--}30$ gram/hari atau $\pm 150\text{--}200$ gram/minggu (Hockenberry & Wilson, 2021; Academy of Breastfeeding Medicine, 2022).

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dengan teknik menyusui yang baik memiliki pola pertumbuhan yang optimal selama enam bulan pertama kehidupan. Kenaikan berat badan yang adekuat menunjukkan bahwa transfer

ASI berlangsung efektif dan kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, Bayi yang tidak mengalami kenaikan berat badan sesuai usia berisiko mengalami kekurangan asupan ASI atau gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pemantauan berat badan secara rutin sangat penting dilakukan pada masa neonatal. Pengkajian berat badan dan kenaikannya penting dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan laktasi, memantau pertumbuhan bayi, serta menentukan kebutuhan intervensi apabila ditemukan gangguan pertumbuhan (Hockenberry & Wilson, 2021; Riordan & Wambach, 2019).

c. Frekuensi BAK/BAB

Pengkajian frekuensi buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) pada bayi merupakan bagian penting dalam menilai kecukupan asupan ASI dan status hidrasi bayi. Pola eliminasi bayi dapat menjadi indikator awal keberhasilan menyusui dan kondisi kesehatan bayi baru lahir. Pengkajian dilakukan dengan menanyakan kepada ibu mengenai jumlah BAB dan BAK bayi dalam 24 jam, warna urin dan feses, serta perubahan pola eliminasi sesuai usia bayi. Pada bayi baru lahir yang mendapatkan ASI cukup, frekuensi BAK biasanya meningkat secara bertahap dari hari ke hari. Setelah usia 5–7 hari, bayi umumnya BAK sekitar 6–8 kali per hari dengan urin berwarna jernih atau kuning muda. Sementara itu, frekuensi BAB pada bayi yang mendapat ASI eksklusif dapat mencapai 3–8 kali per hari pada minggu-minggu awal kehidupan. Feses bayi yang mengkonsumsi ASI biasanya berwarna kuning keemasan dan bertekstur lembek (Hockenberry & Wilson, 2021; Riordan & Wambach, 2019).

Bayi yang memperoleh ASI eksklusif memiliki pola BAB yang lebih sering dibandingkan bayi yang mendapatkan susu formula. Frekuensi eliminasi yang normal mencerminkan proses pencernaan dan hidrasi yang baik pada bayi (Dewey et al., 2003). Sebaliknya, Bayi yang mengalami penurunan atau jarang BAB dan BAK berisiko kekurangan asupan ASI, dan dehidrasi yang merupakan tanda adanya masalah menyusui atau gangguan kesehatan tertentu (Nommsen-Rivers et al., 2008).

d. Tanda dehidrasi atau malnutrisi Bayi

Pengkajian tanda dehidrasi dan malnutrisi pada bayi merupakan bagian penting dalam evaluasi status kesehatan dan kecukupan nutrisi, khususnya pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Pengkajian ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya kekurangan cairan maupun kekurangan asupan nutrisi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada pengkajian dehidrasi, perawat mengobservasi frekuensi buang air kecil, warna

urin, kelembapan mukosa mulut, turgor kulit, kondisi ubun-ubun, serta respons dan aktivitas bayi. Tanda dehidrasi pada bayi meliputi mulut dan bibir kering, mata cekung, ubun-ubun cekung, frekuensi BAK menurun, urin pekat, bayi tampak lemas, rewel, dan penurunan berat badan yang berlebihan (Hockenberry & Wilson, 2021; Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021).

Dehidrasi pada neonatus sering terjadi akibat kurangnya asupan ASI karena teknik menyusui yang tidak efektif atau keterlambatan produksi ASI (Moritz dan Ayus, 2010). Penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat lahir dapat menjadi indikator penting adanya dehidrasi pada bayi baru lahir. Selain dehidrasi, pengkajian malnutrisi juga penting dilakukan untuk menilai kecukupan nutrisi bayi. Pengkajian meliputi pemantauan berat badan, panjang badan, lingkaran kepala, pola menyusui, serta tanda klinis seperti bayi tampak kurus, kehilangan lemak subkutan, pertumbuhan terhambat, dan bayi tampak lemah atau kurang aktif. Malnutrisi pada bayi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, dan peningkatan risiko morbiditas serta mortalitas. Bayi dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat juga berisiko mengalami keterlambatan perkembangan fisik maupun neurologi. Pemantauan berat badan, status hidrasi, dan efektivitas menyusui sangat penting dalam mendeteksi dini masalah nutrisi pada bayi baru lahir (Noel-Weiss et al., 2008). Oleh karena itu, pengkajian tanda dehidrasi dan malnutrisi perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bayi memperoleh asupan cairan dan nutrisi yang adekuat.

6. Kondisi Psikologis Ibu

a. Tingkat kecemasan/stres

Pengkajian kondisi psikologis ibu merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan postpartum karena keadaan emosional ibu dapat memengaruhi proses laktasi, kemampuan merawat bayi, serta kesehatan ibu secara keseluruhan. Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah tingkat kecemasan dan stres ibu selama masa menyusui dan perawatan bayi. Perawat menilai respons emosional ibu melalui wawancara dan observasi, seperti perasaan cemas, takut, mudah marah, sedih, sulit tidur, kelelahan, atau ketidakmampuan beradaptasi dengan peran baru sebagai ibu. Selain itu, perawat juga dapat mengkaji faktor penyebab stres, seperti kurangnya dukungan keluarga, kesulitan menyusui, kondisi kesehatan bayi, maupun perubahan fisik dan hormonal setelah persalinan. Tingkat kecemasan dan stres dapat dinilai menggunakan instrumen seperti *Edinburgh Postnatal Depression*

Scale (EPDS) atau *Perceived Stress Scale* (PSS) (Lowdermilk, Perry, Cashion, & Alden, 2020; Cox, Holden, & Sagovsky, 1987).

Ibu postpartum dengan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi memiliki risiko lebih besar mengalami kegagalan menyusui dan penghentian ASI lebih dini (Dennis dan McQueen, 2009). Kondisi psikologis yang terganggu dapat memengaruhi pelepasan hormon oksitosin sehingga refleks pengeluaran ASI (*let down reflex*) menjadi terhambat. Stres psikologis pada ibu postpartum berhubungan dengan penurunan produksi ASI dan rendahnya kepercayaan diri ibu dalam menyusui (Lau, 2001). Dukungan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan terbukti membantu menurunkan tingkat kecemasan ibu serta meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu, pengkajian tingkat kecemasan dan stres penting dilakukan untuk mendeteksi masalah psikologis sejak dini dan menentukan intervensi yang tepat dalam mendukung kesehatan mental ibu postpartum.

b. *Baby blues* atau depresi postpartum

Baby blues merupakan gangguan emosional ringan yang umum terjadi pada ibu postpartum, biasanya muncul pada hari ke-2 hingga ke-14 setelah persalinan. Kondisi ini ditandai dengan perubahan suasana hati, mudah menangis, cemas, sensitif, mudah marah, dan merasa lelah. Pada pengkajian, perawat menanyakan perubahan perasaan ibu sejak melahirkan, pola tidur, kemampuan beradaptasi dengan peran baru, serta dukungan keluarga yang diterima. *Baby blues* terjadi akibat perubahan hormonal, kelelahan fisik, dan stres adaptasi setelah persalinan. Meskipun bersifat ringan dan sementara, kondisi ini perlu dipantau karena dapat berkembang menjadi depresi postpartum apabila tidak ditangani dengan baik (O'Hara dan McCabe, 2013).

Depresi postpartum merupakan gangguan mood yang lebih berat dan berlangsung lebih lama dibandingkan *baby blues*. Kondisi ini dapat muncul dalam beberapa minggu hingga satu tahun setelah persalinan. Gejala yang dikaji meliputi perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas, gangguan tidur, kelelahan berat, rasa bersalah, kecemasan berlebihan, kesulitan merawat bayi, hingga muncul pikiran menyakiti diri sendiri atau bayi. Pengkajian dapat dilakukan melalui wawancara dan penggunaan instrumen seperti *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS). Depresi postpartum dapat berdampak negatif terhadap ikatan ibu dan bayi (*bonding attachment*), keberhasilan menyusui, serta perkembangan emosional dan kognitif anak (Stewart & Vigod, 2016; Cox, Holden, & Sagovsky, 1987). Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting agar ibu mendapatkan dukungan psikologis dan penanganan yang tepat.

c. Motivasi menyusui

Kondisi psikologis berpengaruh langsung pada hormon oksitosin dan kelancaran ASI (WHO, 2022). Pengkajian motivasi ibu merupakan bagian penting dalam evaluasi kondisi psikologis postpartum, terutama dalam mendukung keberhasilan menyusui dan kemampuan ibu merawat bayi. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi kesiapan, kemauan, dan ketekunan ibu dalam menjalankan peran sebagai ibu serta memberikan ASI kepada bayinya. Perawat menilai keinginan ibu untuk menyusui, keyakinan ibu terhadap manfaat ASI, kesiapan ibu menghadapi tantangan menyusui, serta dukungan yang diterima dari keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, perawat juga dapat mengkaji ekspresi emosional ibu, semangat dalam merawat bayi, dan kemampuan ibu mempertahankan praktik menyusui meskipun menghadapi hambatan. Motivasi ibu dapat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, pengetahuan, budaya, dukungan sosial, dan kondisi psikologis ibu (Riordan & Wambach, 2019; Dennis, 1999).

Motivasi yang tinggi pada ibu berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan lamanya durasi menyusui (Brown dan Lee, 2011). Ibu yang memiliki keyakinan dan motivasi kuat cenderung lebih mampu mengatasi masalah menyusui serta mempertahankan pemberian ASI meskipun mengalami kesulitan pada awal postpartum. Motivasi ibu dipengaruhi oleh dukungan pasangan, tenaga kesehatan, dan lingkungan sosial. Dukungan emosional dan edukasi yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu (*breastfeeding self-efficacy*) sehingga ibu lebih termotivasi untuk menyusui bayinya secara optimal (Meedya, Fahy, dan Kable, 2010).

7. Pengetahuan dan Sikap Ibu

a. Pemahaman Ibu tentang ASI eksklusif

Pengkajian pemahaman dan sikap ibu terhadap ASI eksklusif merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan maternitas untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keyakinan, dan kesiapan ibu dalam memberikan ASI kepada bayi. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat dan vitamin, selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Pada pengkajian, perawat menilai sejauh mana ibu memahami pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI bagi ibu dan bayi, durasi pemberian ASI eksklusif, teknik menyusui yang benar, serta risiko pemberian makanan tambahan terlalu dini. Selain itu, perawat juga mengkaji sikap ibu terhadap menyusui, keyakinan budaya, dukungan keluarga, dan hambatan yang mungkin memengaruhi praktik ASI eksklusif (World Health Organization, 2023; Riordan & Wambach, 2019).

Tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif berhubungan signifikan dengan keberhasilan praktik menyusui. Ibu yang memiliki pemahaman baik mengenai manfaat ASI cenderung lebih termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya (Al Ketbi et al., 2018). Pengetahuan yang baik juga membantu ibu lebih percaya diri dalam menghadapi masalah menyusui selama masa postpartum. Sikap positif ibu terhadap ASI eksklusif dipengaruhi oleh edukasi kesehatan, pengalaman menyusui sebelumnya, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Kurangnya pemahaman mengenai ASI eksklusif dapat menyebabkan ibu memberikan susu formula atau makanan tambahan lebih dini sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada bayi (Acharya dan Khanal, 2015).

b. Pemahaman Ibu Tentang Manfaat ASI

Pemahaman ibu yang baik tentang manfaat ASI dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan ibu dalam menyusui bayinya secara optimal. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji tingkat pengetahuan ibu terkait manfaat ASI bagi bayi maupun ibu. Perawat menanyakan pemahaman ibu mengenai kandungan nutrisi ASI, manfaat ASI terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi, perlindungan terhadap infeksi, serta manfaat menyusui bagi kesehatan ibu. Selain itu, dikaji pula sikap ibu terhadap pemberian ASI, keyakinan budaya, pengalaman menyusui sebelumnya, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ibu dalam memberikan ASI (Riordan & Wambach, 2019; World Health Organization, 2023).

ASI memiliki manfaat besar bagi bayi karena mengandung nutrisi lengkap dan antibodi yang membantu meningkatkan sistem imun serta menurunkan risiko infeksi, diare, dan penyakit pernapasan (Victora et al. 2016). Pemberian ASI eksklusif juga berhubungan dengan peningkatan perkembangan kognitif dan penurunan risiko obesitas pada anak. Selain manfaat bagi bayi, menyusui juga memberikan manfaat kesehatan bagi ibu. Menyusui dapat membantu mempercepat involusi uterus, mengurangi perdarahan postpartum, serta menurunkan risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Ibu yang memahami manfaat ASI dengan baik cenderung memiliki sikap positif terhadap praktik menyusui dan lebih konsisten memberikan ASI eksklusif (Chowdhury et al., 2015).

c. Cara mengatasi masalah menyusui

Pengkajian pemahaman dan sikap ibu mengenai cara mengatasi masalah menyusui penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan ibu dalam menghadapi hambatan selama proses laktasi. Kurangnya pengetahuan menjadi penyebab utama kegagalan menyusui (Kemenkes RI, 2021). Masalah

menyusui seperti puting lecet, bendungan ASI, produksi ASI yang dirasa kurang, nyeri payudara, dan kesulitan pelekatan bayi sering menjadi penyebab penghentian ASI eksklusif. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji sejauh mana ibu memahami cara penanganan masalah tersebut dan sikap ibu dalam menghadapi kesulitan menyusui (Riordan & Wambach, 2019; Perry, Hockenberry, Lowdermilk, & Wilson, 2021).

Perawat menanyakan pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar, cara memperbaiki pelekatan bayi, frekuensi menyusui yang dianjurkan, perawatan payudara, serta langkah yang dilakukan ketika muncul masalah selama menyusui. Selain itu, dikaji pula sikap ibu terhadap pemberian ASI, tingkat kepercayaan diri ibu (*breastfeeding self-efficacy*), dan sumber dukungan yang dimiliki ibu, seperti keluarga dan tenaga kesehatan (Dennis, 1999; Riordan & Wambach, 2019). Edukasi dan dukungan menyusui dari tenaga kesehatan dapat meningkatkan kemampuan ibu dalam mengatasi masalah laktasi dan mempertahankan pemberian ASI eksklusif (McFadden et al. 2017). Ibu yang memiliki pengetahuan baik tentang penanganan masalah menyusui cenderung lebih percaya diri dan tidak mudah menghentikan proses menyusui ketika mengalami hambatan. Kurangnya pemahaman ibu mengenai cara mengatasi masalah menyusui menjadi salah satu faktor utama kegagalan ASI eksklusif. Dukungan keluarga, konseling laktasi, dan pendidikan kesehatan terbukti membantu ibu mengatasi masalah menyusui secara efektif serta meningkatkan keberhasilan menyusui jangka panjang (Binns, Lee, dan Low, 2016). Oleh karena itu, pengkajian pemahaman dan sikap ibu mengenai cara mengatasi masalah menyusui sangat penting untuk menentukan kebutuhan edukasi dan intervensi keperawatan dalam mendukung keberhasilan laktasi.

8. Dukungan Sosial dan Keluarga

a. Dukungan suami dan keluarga

Perawat menilai bentuk dukungan yang diberikan suami dan keluarga, baik dukungan emosional, informasional, maupun bantuan fisik. Dukungan emosional dapat berupa perhatian, empati, dan pemberian semangat kepada ibu. Dukungan informasional meliputi pemberian informasi dan saran terkait menyusui, sedangkan dukungan instrumental berupa bantuan dalam merawat bayi atau membantu pekerjaan rumah tangga sehingga ibu dapat lebih fokus menyusui. Selain itu, perawat juga mengkaji sikap keluarga terhadap ASI eksklusif dan keterlibatan suami dalam proses perawatan bayi. Dukungan suami memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan menyusui dan motivasi ibu dalam mempertahankan ASI eksklusif (Rempel dan Rempel, 2011).

Ibu yang mendapatkan dukungan positif dari suami cenderung memiliki rasa percaya diri lebih tinggi dan mampu mengatasi hambatan selama proses menyusui. Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar menjadi faktor penting yang memengaruhi durasi menyusui. Kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan ibu mengalami stres, kelelahan, dan penurunan motivasi dalam memberikan ASI (Meedya, Fahy, dan Kable, 2010). Sebaliknya, dukungan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan psikologis ibu dan memperkuat komitmen ibu dalam menyusui (Fahy, dan Kable, 2010).

b. Peran lingkungan sekitar

Perawat menilai bentuk dukungan yang diberikan lingkungan kepada ibu, seperti dukungan emosional, pemberian informasi, bantuan praktis dalam merawat bayi, serta sikap lingkungan terhadap pemberian ASI eksklusif. Perawat juga perlu mengkaji apakah terdapat pengaruh budaya, mitos, atau kebiasaan tertentu yang dapat mendukung maupun menghambat praktik menyusui. Selain itu, penting untuk mengetahui apakah ibu memiliki akses terhadap kelompok pendukung menyusui atau layanan konseling laktasi. Dukungan lingkungan sosial yang positif berhubungan dengan meningkatnya keberhasilan ASI eksklusif dan kesejahteraan psikologis ibu postpartum (Emmott dan Mace, 2015). Lingkungan yang memberikan dukungan emosional dan penghargaan terhadap praktik menyusui dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat dan menyusui bayinya. Pengaruh lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan komunitas, berperan penting dalam keputusan ibu untuk memulai dan mempertahankan pemberian ASI (Hector, King, dan Webb, 2005). Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan ibu lebih mudah menghentikan pemberian ASI eksklusif karena tekanan sosial, kurangnya bantuan, atau adanya informasi yang salah mengenai menyusui.

c. Kepercayaan/mitos budaya

Perawat menanyakan kepercayaan keluarga mengenai pemberian ASI, makanan pantangan bagi ibu menyusui, pemberian makanan tambahan dini, penggunaan susu formula, maupun praktik tradisional tertentu selama masa menyusui. Selain itu, dikaji pula apakah keluarga mendukung atau justru membatasi praktik ASI eksklusif berdasarkan mitos yang dipercaya. Pengkajian ini penting karena beberapa mitos dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan menyusui dan status kesehatan bayi. Kepercayaan budaya dan pengaruh anggota keluarga, terutama nenek atau orang tua, memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan terkait pemberian ASI dan perawatan bayi. Beberapa budaya masih mempercayai bahwa ASI pertama (*kolostrum*)

tidak baik untuk bayi sehingga dibuang, padahal kolostrum mengandung antibodi penting bagi kekebalan bayi (Aubel, 2012). Mitos mengenai ketidakcukupan ASI sering menyebabkan ibu memberikan makanan atau minuman tambahan lebih dini sebelum usia enam bulan. Kepercayaan yang kurang tepat ini dapat menghambat keberhasilan ASI eksklusif dan meningkatkan risiko infeksi pada bayi (Mgongo et al., 2013).

9. Lingkungan dan Fasilitas

a. Kebersihan lingkungan

Pengkajian lingkungan dan fasilitas merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan ibu dan bayi karena kondisi lingkungan dapat memengaruhi kesehatan, keberhasilan menyusui, serta pencegahan infeksi pada ibu postpartum dan bayi baru lahir. Perawat menilai kebersihan ruangan, ventilasi, pencahayaan, ketersediaan air bersih, sanitasi, kebersihan tempat tidur bayi, serta kebersihan peralatan yang digunakan untuk perawatan ibu dan bayi. Selain itu, perawat juga mengkaji kebiasaan keluarga dalam menjaga kebersihan tangan sebelum menyentuh bayi atau sebelum menyusui (Lowdermilk, Perry, Cashion, & Alden, 2020; World Health Organization, 2022).

Lingkungan yang bersih dan sehat penting untuk mengurangi risiko infeksi pada ibu postpartum maupun bayi baru lahir yang sistem imunnya masih belum matang. Kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk berhubungan dengan meningkatnya risiko infeksi neonatal dan gangguan kesehatan bayi. Lingkungan yang tidak higienis dapat meningkatkan paparan bakteri dan virus yang berisiko menyebabkan diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi kulit pada bayi (Titaley et al., 2010). Praktik kebersihan yang baik, termasuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan rumah, merupakan faktor penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir. Kebersihan lingkungan juga mendukung kenyamanan ibu selama masa nifas dan membantu proses pemulihan postpartum WHO dan UNICEF (2019).

b. Privasi saat menyusui

Privasi merupakan keadaan dimana ibu merasa aman, nyaman, dan tidak terganggu saat menyusui bayinya. Lingkungan yang mendukung privasi dapat membantu ibu lebih rileks sehingga proses pengeluaran ASI berlangsung lebih optimal. Perawat menilai apakah ibu memiliki tempat khusus atau ruang yang nyaman untuk menyusui, adanya gangguan dari lingkungan sekitar, serta perasaan ibu saat menyusui di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Selain itu, dikaji pula dukungan keluarga dan fasilitas umum terhadap kebutuhan ibu menyusui, seperti tersedianya ruang laktasi, tirai penutup, atau area menyusui

yang nyaman dan bersih (Riordan & Wambach, 2019; World Health Organization, 2022).

Kurangnya privasi saat menyusui dapat menyebabkan ibu merasa malu, cemas, dan tidak nyaman sehingga memengaruhi keputusan ibu untuk menyusui, terutama di tempat umum. Kondisi psikologis yang tidak nyaman dapat menghambat refleksi oksitosin dan menurunkan kelancaran pengeluaran ASI (Boyer, 2012). Tersedianya lingkungan yang mendukung, termasuk ruang laktasi dan privasi yang memadai, berhubungan dengan peningkatan keberhasilan ASI eksklusif dan durasi menyusui (Dinour dan Szaro, 2017). Ibu yang merasa didukung oleh lingkungan cenderung lebih percaya diri dalam menyusui bayinya baik di rumah maupun di luar rumah.

c. Akses layanan kesehatan

Akses layanan kesehatan meliputi keterjangkauan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, kemudahan transportasi, biaya pelayanan, serta akses terhadap edukasi dan konseling laktasi. Perawat menilai apakah ibu mudah mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan postpartum, imunisasi bayi, konseling menyusui, dan bantuan ketika mengalami masalah laktasi. Selain itu, dikaji pula jarak rumah ke fasilitas kesehatan, ketersediaan sarana transportasi, dukungan pembiayaan, serta pengalaman ibu dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pengkajian ini penting untuk mengidentifikasi hambatan yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi (World Health Organization, 2022; Lowdermilk, Perry, Cashion, & Alden, 2020).

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berhubungan dengan meningkatnya risiko masalah kesehatan ibu dan bayi, termasuk rendahnya cakupan ASI eksklusif dan keterlambatan penanganan komplikasi neonatal. Ibu yang memiliki akses layanan kesehatan yang baik cenderung lebih mudah memperoleh informasi dan dukungan terkait menyusui (Titaley et al., 2010). Dukungan layanan kesehatan, terutama konseling laktasi dan edukasi menyusui oleh tenaga kesehatan, berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif (Rollins et al., 2016). Pelayanan kesehatan yang mudah diakses membantu ibu mendapatkan penanganan dini terhadap masalah menyusui sehingga dapat mempertahankan pemberian ASI lebih lama.

10. Riwayat dan Praktik Menyusui Sebelumnya

Pengkajian kondisi bay Riwayat dan Praktik Menyusui Sebelumnya meliputi

a. Pengalaman menyusui sebelumnya

Pengalaman menyusui dapat memengaruhi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta kesiapan ibu dalam memberikan ASI pada bayi saat ini.

Pada pengkajian, perawat menanyakan apakah ibu pernah menyusui sebelumnya, lama pemberian ASI, keberhasilan ASI eksklusif, masalah yang pernah dialami selama menyusui, serta cara ibu mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, dikaji pula pengalaman emosional ibu selama menyusui, dukungan yang diterima, dan alasan penghentian menyusui apabila pernah terjadi. Pengkajian ini membantu perawat memahami faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan menyusui saat ini. Ibu yang memiliki pengalaman menyusui sebelumnya cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri (*breastfeeding self-efficacy*) yang lebih tinggi dibandingkan ibu primipara (Otsuka et al., 2014)

Pengalaman positif dalam menyusui dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan ibu dalam menghadapi masalah laktasi pada periode postpartum berikutnya. Pengalaman menyusui sebelumnya berhubungan signifikan dengan keberhasilan dan durasi pemberian ASI eksklusif. Ibu yang pernah berhasil menyusui lebih cenderung mempertahankan praktik menyusui pada anak berikutnya dibandingkan ibu yang memiliki pengalaman negatif atau pernah mengalami kegagalan menyusui (Blyth et al., 2002).

b. Masalah yang pernah dialami

Pengalaman masalah menyusui pada periode sebelumnya dapat memengaruhi kesiapan, kepercayaan diri, dan keberhasilan ibu dalam menyusui pada masa postpartum saat ini. Oleh karena itu, perawat perlu mengidentifikasi jenis masalah yang pernah dialami serta cara ibu mengatasinya. Perawat menanyakan apakah ibu pernah mengalami masalah seperti puting lecet, bendungan ASI, mastitis, produksi ASI yang dirasa kurang, nyeri saat menyusui, kesulitan pelekatan bayi, maupun penghentian ASI dini (Riordan & Wambach, 2019; Dennis, 1999). Selain itu, dikaji pula dampak masalah tersebut terhadap kondisi fisik dan psikologis ibu, serta dukungan yang diperoleh selama menghadapi masalah menyusui. Masalah menyusui yang paling sering dialami ibu postpartum meliputi nyeri puting, pelekatan yang tidak efektif, dan persepsi ketidakcukupan ASI (Kent et al., 2015). Masalah tersebut dapat menyebabkan ibu mengalami stres dan meningkatkan risiko penghentian ASI eksklusif lebih dini apabila tidak mendapatkan dukungan dan penanganan yang tepat. Pengalaman negatif selama menyusui sebelumnya dapat menurunkan kepercayaan diri ibu dalam menyusui bayi berikutnya (Gianni et al., 2019). Sebaliknya, ibu yang memperoleh edukasi dan dukungan laktasi yang adekuat lebih mampu mengatasi masalah menyusui dan mempertahankan pemberian ASI eksklusif.

c. Penggunaan susu formula

Pemberian susu formula sejak dini sering berkaitan dengan penurunan frekuensi menyusui, berkurangnya stimulasi produksi ASI, serta meningkatnya risiko penghentian ASI eksklusif. Pada pengkajian, perawat menanyakan apakah ibu pernah memberikan susu formula pada bayi sebelumnya, waktu mulai pemberian formula, alasan pemberian, frekuensi penggunaan, serta pengaruhnya terhadap proses menyusui. Selain itu, dikaji pula pemahaman ibu mengenai indikasi pemberian susu formula dan pengalaman emosional ibu terkait keputusan tersebut. Pengkajian ini penting untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi pola menyusui ibu saat ini untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi pola menyusui ibu saat ini (World Health Organization, 2023; Riordan & Wambach, 2019).

Pemberian susu formula pada awal kehidupan bayi berhubungan dengan meningkatnya risiko penghentian ASI eksklusif lebih dini. Bayi yang mendapatkan tambahan susu formula cenderung menyusui lebih sedikit sehingga stimulasi hormon prolaktin dan oksitosin pada ibu menjadi berkurang dan produksi ASI dapat menurun (Chantry et al., 2014). menunjukkan bahwa persepsi ibu mengenai ketidakcukupan ASI menjadi salah satu alasan utama pemberian susu formula. Faktor kurangnya dukungan keluarga, promosi susu formula, dan minimnya edukasi laktasi juga memengaruhi keputusan ibu untuk memberikan susu formula pada bay (Pérez-Escamilla et al., 2016).

D. Penutup

Pengkajian keperawatan pada ibu postpartum dalam pemberian ASI memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan menyusui. Pengkajian yang dilakukan secara komprehensif memungkinkan perawat mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, serta berbagai hambatan yang dialami ibu selama proses laktasi. Pengkajian yang tepat sebagai dasar bagi perawat dalam memberikan intervensi, edukasi, dan dukungan yang sesuai sehingga ibu merasa lebih nyaman, percaya diri, dan mampu memberikan ASI secara optimal kepada bayinya. Oleh karena itu, pengkajian yang baik tidak hanya membantu meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup ibu serta bayi pada masa postpartum.

E. Simpulan

Pengkajian keperawatan pada ibu postpartum dalam pemberian ASI merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan proses menyusui dan pemberian ASI eksklusif. Pengkajian dilakukan secara menyeluruh meliputi kondisi fisik ibu, status laktasi dan produksi ASI, kondisi payudara dan puting, teknik serta posisi menyusui, refleks let-down, tanda kecukupan ASI pada bayi, hingga faktor psikologis dan dukungan keluarga. Melalui pengkajian yang tepat, berbagai masalah yang dapat menghambat proses menyusui dapat dikenali sejak dini sehingga perawat dapat memberikan intervensi, edukasi, dan dukungan yang sesuai. Dengan demikian, pengkajian keperawatan pada ibu postpartum tidak hanya membantu meningkatkan keberhasilan menyusui, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu serta tumbuh kembang bayi secara optimal.

Referensi

- Acharya, P., & Khanal, V. (2015). The effect of mother's educational status on early initiation of breastfeeding: Further analysis of three consecutive Nepal Demographic and Health Surveys. *BMC Public Health*, 15, 1069. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2405-y>
- Al Ketbi, M. I., Al Noman, S., Al Ali, A., Darwish, E., Al Fahim, M., & Rajah, J. (2018). Knowledge, attitudes, and practices of breastfeeding among women visiting primary healthcare clinics on the island of Abu Dhabi, United Arab Emirates. *International Breastfeeding Journal*, 13(26), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s13006-018-0165->
- Apriyani, N., Kristiyanti, R., & Susiatmi, S. A. (2020). Pengetahuan ibu nifas tentang teknik menyusui dengan kejadian puting susu lecet. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6(1). <https://doi.org/10.48144/jiks.v6i1.17>.
- Aubel, J. (2012). The role and influence of grandmothers on child nutrition: Culturally designated advisors and caregivers. *Maternal & Child Nutrition*, 8(1), 19–35. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00333.x>
- Binns, C., Lee, M., & Low, W. Y. (2016). The long-term public health benefits of breastfeeding. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 28(1), 7–14. <https://doi.org/10.1177/1010539515624964>
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Blyth, R., Creedy, D. K., Dennis, C. L., Moyle, W., Pratt, J., & De Vries, S. M. (2002). Effect of maternal confidence on breastfeeding duration: An application of breastfeeding self-efficacy theory. *Birth*, 29(4), 278–284. <https://doi.org/10.1046/j.1523-536X.2002.00202.x>
- Boyer, K. (2012). Affect, corporeality and the limits of belonging: Breastfeeding in public in the contemporary UK. *Health & Place*, 18(3), 552–560. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.10.017>
- Brown, A., & Lee, M. (2011). An exploration of the attitudes and experiences of mothers in the United Kingdom who chose to breastfeed exclusively for 6 months postpartum. *Breastfeeding Medicine*, 6(4), 197–204. <https://doi.org/10.1089/bfm.2010.0097>.
- Brown, A., Raynor, P., & Lee, M. (2011). Young mothers who choose to breast feed: The importance of being part of a supportive breastfeeding community. *Midwifery*, 27(1), 53–59. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2009.09.004>.

- Chantry, C. J., Dewey, K. G., Pearson, J. M., Wagner, E. A., & Nommsen-Rivers, L. A. (2014). In-hospital formula use increases early breastfeeding cessation among first-time mothers intending to exclusively breastfeed. *The Journal of Pediatrics*, 164(6), 1339–1345.e5. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.12.035>
- Chowdhury, R., Sinha, B., Sankar, M. J., Taneja, S., Bhandari, N., Rollins, N., Bahl, R., & Martines, J. (2015). Breastfeeding and maternal health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Acta Paediatrica*, 104(467), 96–113. <https://doi.org/10.1111/apa.13102>
- Coke, C. J., Davari, M., & Kianian, T. (2021). The effect of breastfeeding education on breastfeeding success: A systematic review. *International Breastfeeding Journal*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13006-021-00385-3>.
- Dinour, L. M., & Szaro, J. M. (2017). Employer-based programs to support breastfeeding among working mothers: A systematic review. *Breastfeeding Medicine*, 12(3), 131–141. <https://doi.org/10.1089/bfm.2016.0182>
- Dennis, C. L., & McQueen, K. (2009). The relationship between infant-feeding outcomes and postpartum depression: A qualitative systematic review. *Pediatrics*, 123(4), e736–e751. <https://doi.org/10.1542/peds.2008-1629>
- Dewey, K. G., Heinig, M. J., Nommsen, L. A., Pearson, J. M., & Lönnerdal, B. (2003). Growth of breast-fed and formula-fed infants from 0 to 18 months: The DARLING Study. *Pediatrics*, 89(6), 1035–1041. <https://doi.org/10.1542/peds.89.6.1035>
- Emmott, E. H., & Mace, R. (2015). Practical support from fathers and grandmothers is associated with lower levels of breastfeeding in the UK Millennium Cohort Study. *PLoS ONE*, 10(7), e0133547. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133547>
- Flaherman, V. J., Schaefer, E. W., Kuzniewicz, M. W., Li, S. X., Walsh, E. M., & Paul, I. M. (2015). Early weight loss nomograms for exclusively breastfed newborns. *Pediatrics*, 135(1), e16–e23. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-1532>
- Geddes, D. T., Kent, J. C., Mitoulas, L. R., & Hartmann, P. E. (2012). Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants. *Early Human Development*, 84(7), 471–477. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2007.12.008>
- Gianni, M. L., Bettinelli, M. E., Manfra, P., Sorrentino, G., Bezze, E., Plevani, L., Cavallaro, G., Raffaelli, G., Crippa, B. L., Colombo, L., & Mosca, F. (2019). Breastfeeding difficulties and risk for early breastfeeding cessation. *Nutrients*, 11(10), 2266. <https://doi.org/10.3390/nu11102266>

- Hector, D., King, L., & Webb, K. (2005). Factors affecting breastfeeding practices: Applying a conceptual framework. *New South Wales Public Health Bulletin*, 16(3–4), 52–55. <https://doi.org/10.1071/NB05013>.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2019). *Wong's essentials of pediatric nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Lau, Y. (2001). The effect of maternal stress and health-related quality of life on breastfeeding outcomes. *Journal of Clinical Nursing*, 10(6), 804–812. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2001.00553.x>
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2020). *Maternity and women's health care* (12th ed.). Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu nifas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kent, J. C., Prime, D. K., & Garbin, C. P. (2012). Principles for maintaining or increasing breast milk production. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 41(1), 114–121. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2011.01313.x>
- Kent, J. C., Gardner, H., & Geddes, D. T. (2015). Breastmilk production in the first 4 weeks after birth of term infants. *Nutrients*, 8(12), 756. <https://doi.org/10.3390/nu8120756>
- Kronborg, H., Væth, M., Olsen, J., Iversen, L., & Harder, I. (2018). Early breastfeeding support: Frequency and efficacy of a breastfeeding intervention. *Maternal & Child Nutrition*, 14(3), e12510. <https://doi.org/10.1111/mcn.12510>.
- Lau, C., & Smith, E. O. (2011). A novel approach to assess oral feeding skills of preterm infants. *Neonatology*, 100(1), 64–70. <https://doi.org/10.1159/000321987>.
- McFadden, A., Gavine, A., Renfrew, M. J., Wade, A., Buchanan, P., Taylor, J. L., Veitch, E., Rennie, A. M., Crowther, S. A., Neiman, S., & MacGillivray, S. (2017). Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2(2), CD001141. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001141.pub5>
- Meedya, S., Fahy, K., & Kable, A. (2010). Factors that positively influence breastfeeding duration to 6 months: A literature review. *Women and Birth*, 23(4), 135–145. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2010.02.002>
- Mgongo, M., Mosha, M. V., Uriyo, J. G., Msuya, S. E., & Stray-Pedersen, B. (2013). Prevalence and predictors of exclusive breastfeeding among women in Kilimanjaro region, Northern Tanzania: A population based cross-sectional study. *International Breastfeeding Journal*, 8(12), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1746-4358-8-12>

- Moritz, M. L., & Ayus, J. C. (2010). Prevention of hypernatremic dehydration in breast-fed infants. *Pediatrics*, 122(3), e702–e709. <https://doi.org/10.1542/peds.2007-1520>.
- Mujenah, M., Wahyutri, E., & Noorma, N. (2023). Hubungan teknik menyusui dengan kejadian puting lecet pada ibu post partum di RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor. *Aspiration of Health Journal*, 1(1), 135–145.
- Noel-Weiss, J., Courant, G., & Woodend, A. K. (2008). Physiological weight loss in the breastfed neonate: A systematic review. *Open Medicine*, 2(4), e99–e110. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3091615/>
- Nommsen-Rivers, L. A., Chantry, C. J., Pearson, J. M., Cohen, R. J., & Dewey, K. G. (2008). Delayed onset of lactation among first-time mothers is related to maternal obesity and factors associated with ineffective breastfeeding. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 92(3), 574–584. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29192>.
- O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression: Current status and future directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 379–407. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612>.
- Otsuka, K., Dennis, C. L., Tatsuoka, H., & Jimba, M. (2014). The relationship between breastfeeding self-efficacy and perceived insufficient milk among Japanese mothers. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 37(5), 546–555. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2008.00277>.
- Pérez-Escamilla, R., Martinez, J. L., & Segura-Pérez, S. (2016). Impact of the Baby-friendly Hospital Initiative on breastfeeding and child health outcomes: A systematic review. *Maternal & Child Nutrition*, 12(3), 402–417. <https://doi.org/10.1111/mcn.12294>.
- Pillitteri, A. (2018). *Maternal and child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Rempel, L. A., & Rempel, J. K. (2011). The breastfeeding team: The role of involved fathers in the breastfeeding family. *Journal of Human Lactation*, 27(2), 115–121. <https://doi.org/10.1177/089033441039004>
- Riordan, J., & Wambach, K. (2019). *Breastfeeding and human lactation* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Rollins, N. C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., Lutter, C. K., Martines, J. C., Piwoz, E. G., Richter, L. M., & Victora, C. G. (2016). Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *The Lancet*, 387(10017), 491–504. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01044-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2)
- Safari, K., Aryankhesal, A., & Ghiasvand, H. (2018). The effect of mother and newborn early skin-to-skin contact on initiation of breastfeeding, newborn temperature and duration of third stage of labor. *International*

- Breastfeeding Journal*, 13(32), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s13006-018-0174-9>.
- Sihite, N. A. R. F., Novayelinda, R., & Lestari, W. (2022). Gambaran insiden bendungan ASI dan upaya yang dilakukan ibu untuk mengatasinya. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v11i1.207>
- Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2016). Postpartum depression: Pathophysiology, treatment, and emerging therapeutics. *Annual Review of Medicine*, 67, 231–245. <https://doi.org/10.1146/annurev-med-070514-013545>
- Thompson, J. F., Roberts, C. L., Currie, M., & Ellwood, D. A. (2016). Prevalence and persistence of health problems after childbirth: Associations with parity and method of birth. *Birth*, 29(2), 83–94. <https://doi.org/10.1046/j.1523-536X.2002.00167.x>
- Titaley, C. R., Dibley, M. J., Agho, K., Roberts, C. L., & Hall, J. (2010). Determinants of neonatal mortality in Indonesia. *BMC Public Health*, 8, 232. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-232>
- UNICEF. (2021). *Infant and young child feeding counselling package*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2021). *Infant and young child feeding*. New York: UNICEF
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)
- Wambach, K., & Spencer, B. (2021). *Breastfeeding and human lactation* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Widström, A. M., Brimdyr, K., Svensson, K., Cadwell, K., & Nissen, E. (2019). Skin-to-skin contact the first hour after birth, underlying implications and clinical practice. *Acta Paediatrica*, 108(7), 1192–1204. <https://doi.org/10.1111/apa.14754>
- World Health Organization. (2023). *Infant and young child feeding*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). *Maternal mental health*. Geneva: WHO. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/seputar-payudara-7>

Glosarium

ASI Eksklusif : Pemberian Air Susu Ibu saja kepada bayi selama 6 bulan pertama tanpa tambahan makanan atau minuman lain kecuali obat dan vitamin sesuai indikasi medis

Bonding Attachment : Ikatan emosional antara ibu dan bayi yang terbentuk melalui kontak dan interaksi selama menyusui.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) : Proses meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir agar bayi mulai menyusu dalam satu jam pertama kehidupan.

Ibu Postpartum : Ibu yang berada pada masa setelah melahirkan hingga organ reproduksi kembali seperti sebelum hamil, biasanya berlangsung sekitar 6 minggu.

Kolostrum : Cairan ASI pertama berwarna kekuningan yang kaya antibodi dan nutrisi penting bagi bayi baru lahir

Perlekatan Menyusui : Posisi dan cara bayi menempel pada payudara ibu saat menyusui agar hisapan efektif dan tidak menimbulkan nyeri.

CHAPTER 4

EDUKASI TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR DAN PERAWATAN PAYUDARA

Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.

A. Pendahuluan

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama dan utama untuk bayi baru lahir. Kandungan nutrisi yang ada dalam ASI sangat lengkap sesuai dengan kebutuhan bayi, dimana kandungan nutrisi dalam ASI mulai dari kolostrum sampai dengan ASI matur kandungannya nutrisinya sesuai dengan kebutuhan bayi. Zat nutrisi bioaktif, makronutrien, dan mikronutrien yang adaptif terhadap kapasitas fisiologis pencernaan neonatus. Secara biomedis, komponen imunologis di dalam ASI bertindak sebagai barier proteksi primer bagi bayi dari risiko infeksi saluran cerna (seperti diare), pneumonia, hingga malnutrisi (Sianturi & Siregar, 2025).

Mengingat kandungan nutrient dalam ASI dan manfaatnya bukan hanya untuk pertumbuhan tetapi juga bisa menjadi perlindungan untuk bayi, maka pemberian ASI merupakan hal yang tidak bisa tergantikan. *World Health Organization (WHO)* dan Kemenkes RI merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif, yaitu hanya memberikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Namun pada kenyataannya pemberian ASI eksklusif belum sepenuhnya terlaksana. Kegagalan dalam pemberian ASI ini tidak hanya memicu morbiditas jangka pendek, melainkan berkorelasi linear terhadap peningkatan prevalensi stunting yang saat ini menjadi fokus restrukturisasi klinis nasional. Berdasarkan data statistik nasional yang merujuk pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), ditemukan fenomena masif di mana sebanyak 67,5% ibu mengalami kegagalan dalam melanjutkan pemberian ASI eksklusif secara dini (Faiqah & Hamidiyanti, 2021). Angka penurunan persistensi menyusui ini terus berjalan secara eksponensial seiring dengan bertambahnya usia kronologis bayi. Capaian persentase paling rendah umumnya tercatat saat bayi mendekati usia enam bulan. Akar masalah dari rendahnya keberhasilan pemberian ASI ini mayoritas bersumber dari defisit pengetahuan maternal yang berdampak langsung pada kesalahan manipulasi praktis saat menyusui.

Bagi kelompok ibu yang baru pertama kali melahirkan (ibu primipara), proses adaptasi laktasi merupakan fase kritis yang dipenuhi tantangan fisik dan psikososial. Kegagalan penempatan posisi tubuh bayi dan kesalahan metode perlekatan memicu

cedera traumatik pada jaringan mukosa payudara, yang secara klinis bermanifestasi sebagai puting lecet, retak, hingga timbulnya peradangan (Azkia, 2024). Akibat rasa nyeri hebat yang dirasakan selama proses pengisapan, ibu cenderung melakukan restriksi atau pembatasan terhadap frekuensi pengeluaran ASI. Pembatasan durasi pengosongan payudara ini memicu retensi sirkulasi limfatik dan vaskular, yang selanjutnya berkembang menjadi pembengkakan kelenjar payudara atau bendungan ASI (*breast engorgement*) (Septiani & Sumiyati, 2022). Komplikasi berantai ini kerap diinterpretasikan secara keliru oleh ibu sebagai tanda ketidakmampuan fisiologis dalam memproduksi ASI, yang pada akhirnya mendorong keputusan pengenalan susu formula terlalu dini (Emilda et al., 2025).

Untuk memutus siklus kegagalan laktasi tersebut, diperlukan suatu strategi edukasi laktasi yang terstruktur, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*). Intervensi edukasi laktasi tidak boleh sekadar diberikan sebagai instruksi lisan singkat di ruang pemulihan pascasalin, melainkan harus dikonseptualisasikan secara berkelanjutan sejak masa antenatal trimester ketiga hingga periode nifas (Sianturi & Siregar, 2025). Dua pilar utama yang terbukti secara klinis mampu meningkatkan angka keberhasilan menyusui adalah pemahaman teknik posisi-perlekatan yang benar serta implementasi perawatan payudara (*breast care*) secara teratur (Lenny et al., 2024; Rifqiyati & Haryani, 2025). Dengan membekali ibu pengetahuan yang adekuat, rasa percaya diri maternal atau efikasi diri menyusui (*breastfeeding self-efficacy*) akan terbentuk, yang menjadi prediktor terkuat bagi tercapainya kesuksesan laktasi yang aman dan nyaman.

B. Fisiologi Laktasi: Landasan Hormonal dan Mekanis

Menyusui adalah rangkaian proses yang dimulai dari pembentukan dan pelepasan ASI hingga saat bayi menerima dan meminumnya. Laktasi merupakan rangkaian dua proses yang unik pada tubuh perempuan yaitu proses produksi ASI dan proses menyusui bayi. Perkembangan payudara sudah mulai sejak janin dalam berusia 18 – 19 minggu dan bentuknya akan semakin membulat saat perempuan mulai menarche. Hormon estrogen dan progesteron berperan penting dalam mematangkan struktur kelenjar susu (alveoli), sedangkan hormon prolaktin berperan dalam merangsang produksi ASI. Selama masa kehamilan, kadar hormon prolaktin dalam tubuh meningkat yang dipicu juga oleh placenta. Namun produksi ASI belum optimal karena kadar estrogen yang tinggi selama kehamilan, menghambat kerja prolaktin untuk menghasilkan ASI.

Proses produksi ASI telah dimulai sejak awal kehamilan. Fase awal ini melibatkan pembentukan laktogen serta peran dari berbagai hormon untuk

mempersiapkan jaringan payudara. Hormon estrogen berperan untuk merangsang perkembangan *ductus lactiferus* sedangkan progesteron merangsang pertumbuhan kelenjar susu sekaligus menahan ASI tidak keluar sebelum waktunya. Selain itu, hormon prolaktin mulai merangsang sel epitel sekretori untuk memproduksi kolostrum yang didukung oleh human Placental Lactogen (hPL) dari placenta yang menstimulasi pertumbuhan payudara. Proses persiapan selama kehamilan terus berlangsung sampai pasca persalinan. Umumnya kadar estrogen dan progesteron akan turun secara drastis pada hari kedua atau ketiga. Hal tersebut menyebabkan lonjakan kadar estrogen dan prolaktin, sehingga proses pembentukan dan pengeluaran ASI mulai berjalan dengan baik (Salsabila, 2023).

Proses laktogenesis secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Laktogenesis I

Menjelang akhir masa kehamilan, tubuh ibu mulai memasuki tahap Laktogenesis I, yaitu fase awal pembentukan ASI. Pada tahap ini, payudara mulai menghasilkan kolostrum, yaitu cairan kental berwarna kuning yang kaya nutrisi. Selain itu, jaringan payudara mengalami perkembangan dengan bertambahnya dan membesarnya lobulus-alveolus sebagai persiapan menyusui. Meskipun kolostrum sudah mulai diproduksi, kadar hormon progesteron yang masih tinggi saat ini bisa menekan produksi ASI secara maksimal. Perlu diketahui, keluarnya kolostrum selama kehamilan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, tidak menentukan seberapa banyak ASI yang akan diproduksi setelah melahirkan.

2. Laktogenesis II

Setelah proses persalinan dan keluarnya plasenta, kadar hormon progesteron, estrogen, dan *Human Placental Lactogen* (HPL) menurun drastis. Namun, hormon prolaktin tetap berada pada tingkat tinggi, yang kemudian memicu produksi ASI dalam jumlah besar. Tahap ini dikenal sebagai fase Laktogenesis II. Pada fase ini, jika payudara distimulasi seperti melalui isapan bayi kadar prolaktin dalam darah akan meningkat, dan lonjakan ini akan terjadi kembali sekitar 45 menit setelah rangsangan. Tiga jam kemudian, kadar prolaktin akan kembali ke tingkat normal jika tidak ada rangsangan lanjutan.

Prolaktin berperan utama dalam merangsang sel-sel di alveoli payudara untuk memproduksi ASI, dan sebagian prolaktin ini juga terkandung dalam ASI. Kadar prolaktin cenderung lebih tinggi saat produksi ASI meningkat, terutama antara pukul 2 hingga 6 pagi. Namun, ketika payudara terasa penuh dan tidak segera dikosongkan, kadar prolaktin bisa menurun. Selain prolaktin, hormon lain seperti insulin, tiroksin, dan kortisol juga terlibat dalam proses pembentukan ASI, meskipun peran mereka tidak sebesar prolaktin. Secara biokimia, tanda-tanda Laktogenesis II biasanya mulai muncul sekitar 30–40 jam setelah melahirkan.

Namun, sebagian besar ibu mulai merasakan payudaranya penuh atau membengkak sekitar hari kedua atau ketiga setelah persalinan.

Hal ini menunjukkan bahwa produksi ASI tidak langsung terjadi begitu bayi lahir. Sebelumnya, bayi akan mengonsumsi kolostrum cairan awal yang diproduksi oleh payudara dan sangat kaya manfaat. Kolostrum mengandung banyak sel darah putih dan antibodi, terutama immunoglobulin A (IgA), yang berfungsi melapisi dinding usus bayi yang masih lemah serta mencegah masuknya kuman. IgA juga membantu mencegah reaksi alergi terhadap makanan. Biasanya, kolostrum akan mulai berkurang dan menghilang dalam dua minggu setelah persalinan, dan akan digantikan sepenuhnya oleh ASI matang.

3. Laktogenesis III

Laktogenesis III adalah fase di mana produksi ASI diatur oleh sistem hormon (endokrin), yang terjadi selama masa kehamilan hingga beberapa hari setelah persalinan. Setelah produksi ASI mulai berjalan dengan stabil, pengaturan beralih ke sistem autokrin, yaitu mekanisme yang bergantung pada seberapa banyak ASI dikeluarkan. Pada tahap ini, semakin sering dan banyak ASI dikeluarkan dari payudara, maka semakin banyak pula ASI yang akan diproduksi. Selain itu, hisapan bayi juga memainkan peran penting dalam merangsang dan mempertahankan produksi ASI selama proses menyusui (Vera Iriani Abdullah, et al., 2023).

C. Edukasi Teknik Menyusui

Edukasi mengenai teknik menyusui merupakan salah satu intervensi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan ibu dalam menyusui. Melalui edukasi, ibu dapat memahami cara menyusui yang benar sehingga mampu meningkatkan keberhasilan pemberian ASI (Nurliawati, 2023).

Pemberian edukasi tentang menyusui dapat meningkatkan lamanya pemberian ASI. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara promosi Kesehatan yaitu melalui konseling atau edukasi Kesehatan mengenai informasi pemberian ASI, manfaat menyusui, mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian ASI, posisi serta Teknik menyusui yang benar, memerah ASI serta menyimpan ASI. Materi tersebut sangat penting diketahui oleh ibu terutama ibu hamil atau ibu post partum. Pemahaman tersebut bisa memberikan motivasi untuk menyusui dengan Teknik yang tepat.

Adapun tujuan Pendidikan Kesehatan adalah terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat dalam membina serta memelihara berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pendidikan Kesehatan untuk ibu post partum bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam menyusui juga berpengaruh terhadap motivasi dan sikap yang positif dalam pemberian ASI. Pendidikan Kesehatan bagi ibu yang menyusui dapat diberikan pada masa hamil, prenatal dan post partum. Pendidikan Kesehatan yang diberikan kepada ibu dapat dilakukan dengan beberapa metode edukasi misalnya, ceramah, demonstrasi, *focus group discussion*. Adapun media edukasi yang biasa digunakan adalah leaflet, poster, booklet, video, lembar balik, dll.

D. Teknis Menyusui yang Benar: Posisi dan Perlekatan

Teknik menyusui yang benar adalah suatu cara memberikan ASI kepada bayi sesuai dengan perlekatan serta posisi ibu dan bayi yang benar. Indikator dalam proses menyusui yang efektif meliputi posisi ibu dan bayi yang benar (*positioning*), perlekatan bayi yang tepat (*latch on*), efektifitas hisapan bayi pada payudara (*effective sucking*) (Agustina, 2022 dalam Nurliawati 2023).

Dalam edukasi posisi menyusui harus memastikan bahwa posisi ibu sudah ergonomis bagi ibu baik dalam posisi duduk tegak bersandar, setengah duduk, maupun berbaring lateral. Ada empat prinsip yang harus diperhatikan saat menyusui menurut Faiqah & Hamidayanti, (2021); Nurliawati, (2023) yaitu:

1. Garis lurus (*Alignment*) yaitu seluruh tubuh bayi, mulai telinga, bahu, hingga pinggul berada dalam satu garis lurus tanpa adanya tekukan atau rotasi pada leher.
2. Menghadap payudara yaitu wajah dan dada bayi harus diposisikan tegak lurus menghadap ke payudara ibu dengan hidung bayi berada tepat didepan putting susu.
3. Tubuh dekat (*closeness*), yaitu ibu harus mendekatkan tubuh bayi sedekat mungkin ke tubuh ibu, sehingga tidak ada jarak ruang kosong yang memaksa bayi meregangkan lehernya.
4. Sokongan total, yaitu ibu harus menyokong tubuh bayi mulai dari kepala, punggung, hingga bokong terutama pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Menurut Azkia, (2024); Faiqah & Hamidiyanti (2021) posisi menyusui terdiri dari:

1. Posisi *Cradle Hold*

Posisi yang paling umum adalah menggunakan cradle hold. Pastikan punggung ibu benar-benar mendukung posisi ini. Jaga bayi diperut ibu, sampai kulit ibu dan kulit bayi bersentuhan. Biarkan tubuh bayi menghadap tubuh ibu, dan letakkan kepala di siku ibu.

2. Posisi *Cross-Cradle Hold*

Kepala bayi terletak antara ibu jari dan jari telunjuk dan kembali berada ditangan ibu, hal ini merupakan posisi yang baik ketika bayi pertama kali belajar untuk menyusui karena memberika kontrol kepada bayi sewaktu membantu bayi mengambil payudara dalam mulutnya.

3. Posisi *Football Hold*

Caranya memegang kepala bayi seperti memegang bola d tangan dengan tubuh bayi pada bayi lengan, kaki kembali kerah ibu dan wajah kearah payudara. Football hold merupakan posisi yang terbaik jika memiliki luka cesaeran ceksoan muka tidak dapat meletakkan bayi diperut. Hal ini juga posisi yang baik untuk perawatan bayi kembar.

4. Posisi *Lying Down*

Posisi ini sangat tepat untuk menyusui pada malam hari, karena pada posisi ini ibu berbaring di samping bayi, ibu langsung menghadap bayi dengan kepala bayi di dekat payudara dn mulut bayi berkerut dengan puting ibu.

5. Posisi *Laid Back Breastfeedin*

Posisi ini memungkinkan ibu berbaring setengah duduk dan meletakkan si Kecil di dada sehingga banyak terjadi skin to skin contact.

Perlekatan (*latch-on*) adalah cara bayi memasukkan puting dan areola ke dalam mulut untuk menyusu. Pelekatan yang benar adalah mulut bayi perlu dilekatkan dengan baik ke payudara ibu sehingga dapat menyusu secara efektif. Jika bayi sudah melekat dengan baik, kita dapat melihat ada gerakan menelan atau dapat mendengar bunyi tegukan ketika bayi menyusu. Pelekatan ini benar-benar aspek terpenting dari menyusui. Tanpa pelekatan yang tepat, bayi tidak akan mendapatkan ASI sesuai kebutuhannya dan payudara tidak akan distimulasi untuk memproduksi lebih banyak. (Astuti & Anggarawati, 2021)

Perlekatan yang tidak tepat terjadi apabila bayi hanya mengisap pada bagian puting saja, yang mengakibatkan penekanan mekanis traumatis dan penurunan efisiensi pengosongan sinus laktiferus (Azkia, 2024). Edukasi klinis harus melatih ibu mengenali tanda perlekatan yang efektif (Faiqah & Hamidiyanti, 2021; Nurliawati, 2023). Tanda-tanda atau indikator perlekatan yang baik adalah CALM.

C – *Chin* (dagu) : posisi menempel erat dan stabil pada payudara ibu.

A – *Areola* : Sebagian besar areola mammae masuk kedalam mulut bayi terutama areola mammae bagian bawah.

L – *Lips* (Bibir): bibir bayi terlipat keluar, terutama bibir bagian bawah

M – *Mouth* (mulut) : mulut bayi terbuka lebar saat menghisap

Apabila perlekatan ini berjalan optimal, proses pengisapan bayi akan menghasilkan tekanan negatif di dalam rongga mulut yang dikombinasikan dengan

pijatan ritmis lidah pada sinus laktiferus di bawah areola. Hal ini menjamin pengosongan payudara secara menyeluruh tanpa menimbulkan sensasi nyeri hebat atau robekan pada epitel puting ibu.

E. Perawatan Payudara (*Breast Care*) Antenatal dan Post Natal

Perawatan payudara (*breast care*) merupakan suatu tindakan untuk membersihkan, menstimulasi dan pemijatan terstruktur pada organ payudara yang bertujuan untuk mempertahankan kebersihan lokal, mendeteksi kelainan anatomi secara dini, serta memicu efisiensi laktasi. Studi klinis membuktikan bahwa pemberian edukasi dan pelatihan *breast care* secara signifikan mentransformasi tingkat pengetahuan dan membentuk perilaku positif maternal secara masif (Lenny et al., 2024).

1. Perawatan Payudara Masa Antenatal (Trimester Akhir)

Persiapan laktasi yang ideal tidak dimulai saat bayi telah lahir, melainkan harus dibangun secara sistematis sejak usia kehamilan memasuki trimester ketiga (usia gestasi 28 minggu). Fokus utama dari intervensi antenatal ini adalah pengondisian anatomi puting dan areola, serta peningkatan efikasi diri (*self-efficacy*) maternal agar terhindar dari kecemasan psikologis pemicu kegagalan ASI (Sianturi & Siregar, 2025).

Menurut Emilda et al. (2025) ; Sianturi & Siregar (2025) langkah-langkah *breast care* antenatal meliputi:

a. Pembersihan Higienis

Membersihkan payudara terutama bagian areola mammae dengan menggunakan kapas atau kasa steril yang telah dibasahi dengan minyak kelapa alami atau *baby oil*. Kapas tersebut ditempelkan(dikmpreskan) di atas puting susu selama beberapa menit untuk melunakkan epitel mati atau sisa sekresi kolostrum kering yang menyumbat muara duktus laktiferus. Setelah melunak, lakukan usapan melingkar hingga bersih.

b. Koreksi Anatomis Puting

Koreksi puting dilakukan pada kasus deteksi dini puting susu datar (*flat nipple*) atau terbenam (*inverted nipple*), ibu dilatih melakukan penarikan puting secara manual atau menggunakan teknik tertentu agar puting menonjol ke luar dan siap diisap oleh mulut neonatus setelah lahir.

c. Proteksi Barrier Kulit

Ibu dilarang menggosok area puting menggunakan sabun mandi antiseptik secara berlebihan atau alkohol, karena senyawa tersebut mengikis

sebum alami, memicu kekeringan jaringan, dan meningkatkan kerentanan lecet saat nifas dimulai.

2. Perawatan Payudara Masa Postnatal (Nifas)

Setelah kelahiran plasenta, penurunan mendadak kadar hormon progesteron memicu pelepasan prolaktin secara masif, yang menyebabkan kongesti vaskular lokal payudara sebagai tanda dimulainya produksi ASI. Perawatan payudara postnatal diaplikasikan secara teratur untuk menjaga patensi duktus laktiferus dan mencegah stasis ASI (Emilda et al., 2025; Lenny et al., 2024).

Menurut Rifqiyati & Haryani (2025), Septiani & Sumiyati (2022) perawatan payudara pada masa nifas adalah sebagai berikut:

a. Kompres hangat

Payudara dikompres menggunakan waslap hangat untuk memicu vasodilatasi lokal, meningkatkan aliran darah kapiler, dan memfasilitasi kelancaran *let-down reflex* (LDR)

b. Pemijatan Masase Terapeutik

Melakukan pengurutan payudara secara sirkular dan sistematis, bergerak dari pangkal payudara menuju ke arah puting susu. Tindakan ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, merangsang kontraksi otot polos kelenjar, serta melunakkan jaringan payudara yang mengeras akibat bendungan ASI.

c. Higiene Akhir

Tindakan diakhiri dengan pembersihan sisa minyak menggunakan waslap bersih dan kompres dingin singkat untuk mengurangi kongesti berlebih serta memberikan efek nyaman pascapemijatan.

F. Intervensi Pijat Oksitosin untuk Mengatasi Menyusui Tidak Efektif

Dalam nomenklatur diagnosis keperawatan Indonesia, kondisi kegagalan atau hambatan proses menyusui dikategorikan sebagai masalah Menyusui Tidak Efektif (Nurliawati et al., 2024; Rifqiyati & Haryani, 2025). Tanda tanda gejala dari masalah tersebut adalah payudara terasa terlalu kencang atau bengkak namun ASI tidak keluar lancar, bayi terus menangis karena lapar, atau timbulnya luka laserasi pada puting susu ibu. Apabila masalah keperawatan tersebut dibiarkan, maka akan memicu kecemasan maternal, risiko infeksi jaringan, dan penurunan total sekresi laktasi. Untuk mengatasinya, dikembangkan intervensi komplementer berbasis neuro-refleks, yaitu Pijat Oksitosin (Nurliawati, 2024).

1. Mekanisme Neurofisiologis Pijat Oksiteosin

Pijat oksitosin merupakan tindakan pemijatan pada area tulang belakang (columna vertebrae) mulai dari regio leher hingga tulang belikat (Nurliawati et al.,

2024). Secara anatomis, pemijatan pada area ini merangsang mekanoreseptor kulit dan serabut saraf sensorik aferen spinal. Sinyal saraf naik melintasi korda spinalis menuju hipotalamus di otak, yang memicu pelepasan hormon oksitosin oleh kelenjar hipofisis posterior ke dalam pembuluh darah.

Peningkatan kadar oksitosin dalam darah langsung menginduksi kontraksi sel-sel otot polos mioepitel yang mengelilingi sel asinus alveoli payudara. Proses kontraksi mekanis ini mempercepat pengosongan ASI yang tersimpan, meningkatkan tekanan intraduktus, dan melancarkan *Let-Down Reflex* (Nurliawati et al., 2024; Rifqiyati & Haryani, 2025). Selain jalur endokrin, pijat oksitosin memicu pelepasan endorfin endogen yang memblokir persepsi nyeri saraf aferen dan menurunkan kadar hormon stres kortisol. Penurunan ketegangan psikis ini menekan sistem saraf simpatis, menghilangkan blokade adrenalin pada jaringan payudara, dan membuka jalur pengaliran ASI secara total.

2. Prosedur Pelaksanaan Pijat Oksitosin

Tindakan pijat oksitosin idealnya dilakukan oleh suami atau anggota keluarga terdekat untuk meningkatkan kedekatan emosional dan rasa aman pada ibu (Rifqiyati & Haryani, 2025). Prinsip umum prosedur pijat oksitosin adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Posisi Ibu

Ibu diposisikan duduk dengan nyaman membungkuk depan di atas kursi atau meja, dengan kepala ditopang oleh bantal yang diletakkan di atas meja di depannya. Payudara dibiarkan menggantung bebas tanpa pakaian atas untuk meminimalkan tekanan duktus.

b. Teknik Manipulasi Masase

Masase menggunakan kedua ibu jari tangan yang dilumuri minyak, posisikan jari di sisi kanan dan kiri tulang belakang, berjarak sekitar 1-2 cm dari tulang yang menonjol.

c. Gerakan Sirkular

Lakukan pemijatan dengan gerakan melingkar kecil-kecil ke arah luar membentuk huruf C, bergerak secara bertahap dari batas leher bawah menuju ke arah tulang belikat. Pemijatan dilakukan dengan ritme konstan, tegas namun lembut sesuai dengan kenyamanan ibu. Prosedur dilaksanakan selama 2-3 menit per sesi.

d. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan pijat oksitosin gabungan dengan *breast care* yang diimplementasikan selama beberapa hari berturut-turut secara signifikan mampu mengubah status menyusui tidak efektif menjadi efektif (Nurliawati et al., 2024; Rifqiyati & Haryani, 2025). Tanda objektif keberhasilan meliputi

payudara kembali melunak pascamenyusui, ASI menetes lancar, bayi menyusu dengan tenang tanpa rewel, serta pola eliminasi urin dan feses bayi menjadi normal dan teratur.

G. Manajemen Komplikasi Laktasi: Bendungan ASI (*Breast Engorgement*)

Bendungan ASI (*breast engorgement*) adalah komplikasi patologis mekanis awal masa nifas yang memiliki insidensi tertinggi, terutama pada kelompok ibu primipara yang tidak mendapatkan paparan informasi laktasi pranatal yang adekuat (Septiani & Sumiyati, 2022). Kondisi ini memicu distress fisik mendalam dan menjadi salah satu faktor penghentian menyusui secara permanen jika tidak dikelola lewat tatalaksana klinis yang tepat.

1. Etiologi dan Patofisiologi Pembengkakan

Bendungan ASI terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara produksi ASI di dalam alveoli dengan proses pengosongan eksternal kelenjar payudara (Wulandari et al., 2023). Patofisiologi kondisi tersebut, menurut Emilda et al. (2025); Septiani & Sumiyati (2022) dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu:

a. Stasis ASI Intraduktus

Secara fisiologis ASI akan terus diproduksi, namun apabila proses ini tidak diimbangi dengan pengosongan payudara, maka akan terjadi bendungan ASI. Hal tersebut bisa disebabkan faktor keterlambatan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), frekuensi menyusui yang kurang dari ketentuan klinis, atau pembatasan durasi menyusui secara kaku.

b. Kongesti Limfatik dan Vaskular

Bendungan ASI di dalam ruang duktus akan mengakibatkan tekanan hidrostatik intraduktus yang sangat tinggi. Tekanan tinggi ini menekan jaringan interstitial sekitar, menyumbat sirkulasi balik vena dan saluran limfatik lokal payudara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya bendungan limfe dan ekstrasvasi cairan plasma ke dalam jaringan interstitial, memicu edema masif yang menyelimuti seluruh lobus payudara.

Secara klinis, manifestasi bendungan ASI bermanifestasi pada hari ke-3 hingga ke-5 nifas, ditandai dengan payudara membengkak hebat, mengeras saat dipalpasi, terasa tegang, mengkilap, disertai nyeri berdenyut yang konstan, bahkan sering memicu demam inflamasi sistemik ringan (Septiani & Sumiyati, 2022; Wulandari et al., 2023). Jika tidak segera diredakan, stasis ASI yang terkontaminasi bakteri flora kulit melalui celah puting lecet akan berkembang menjadi infeksi parenkim payudara yang destruktif, seperti mastitis akut dan abses payudara.

2. Strategi Penatalaksanaan dan Edukasi Kuratif

Tatalaksana klinis bendungan ASI harus diatasi secara mekanis dan edukatif melalui peningkatan keterampilan ibu (Rifqiyati & Haryani, 2025). Materi edukasi yang perlu disampaikan kepada ibu adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Mutlak Perlekatan

Sebelum ibu menyusui, edukator harus mendampingi ibu secara langsung untuk memastikan areola yang bengkak sudah dilunakan terlebih dahulu. Salah satu teknik untuk melunakannya adalah teknik *Reverse Pressure Softening (RPS)*. Caranya adalah dengan menekan area areola ke arah dalam menggunakan jari secara perlahan untuk mendorong cairan edema interstitial mundur ke belakang dasar payudara. Setelah areola melunak, posisikan bayi dengan teknik perlekatan yang benar agar areola bawah masuk maksimal ke mulut bayi, sehingga pengosongan sinus laktiferus berjalan lancar (Faiqah & Hamidiyanti, 2021).

b. Aplikasi Kompres Kombinasi

Sebelum proses menyusui dimulai, lakukan kompres hangat pada payudara untuk memicu dilatasi duktus dan melancarkan aliran ASI. Namun, segera setelah proses menyusui selesai, lakukan kompres dingin pada area payudara yang meradang untuk menurunkan permeabilitas kapiler, menekan edema interstitial, serta memblokir reseptor nyeri lokal (Septiani & Sumiyati, 2022).

c. Evakuasi ASI Kontinu

Payudara yang mengalami bendungan wajib dikosongkan secara konstan (Wulandari et al., 2023). Apabila bayi menolak menyusu karena aliran terlalu deras atau puting terbenam, ibu dilatih untuk melakukan pemerasan ASI secara manual dengan teknik *Marmet* atau menggunakan pompa payudara dengan tekanan rendah yang stabil. Pengosongan total secara mekanis terbukti menurunkan tingkat pembengkakan payudara secara bermakna menuju skala normal (Septiani & Sumiyati, 2022).

H. Simpulan dan Rekomendasi Klinis

1. Kesimpulan

Program pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama merupakan pilar preventif yang mutlak diperlukan untuk menjamin kualitas tumbuh kembang anak serta menekan angka stunting secara nasional. Kendati demikian, pencapaian target laktasi ini sering kali terhambat oleh timbulnya komplikasi mekanis pada masa nifas awal, seperti masalah menyusui tidak efektif dan

bendungan ASI. Berbagai komplikasi fisik ini pada dasarnya bersumber dari defisit pengetahuan ibu mengenai manajemen laktasi teknis yang benar.

Integrasi edukasi terstruktur mengenai teknik menyusui yang benar (penyelarasan posisi dan ketepatan perlekatan areola) serta keterampilan perawatan payudara (*breast care*) terbukti secara ilmiah mampu meminimalkan risiko cedera puting susu, mengeliminasi stasis ASI, serta meningkatkan efikasi diri maternal. Lebih lanjut, pemanfaatan intervensi komplementer berupa pijat oksitosin bertindak sebagai akselerator fisiologis yang memicu kelancaran refleks pengeluaran ASI melalui stimulasi neuroendokrin. Melalui kombinasi perawatan payudara, teknik menyusui yang presisi, dan pijat oksitosin, masalah menyusui tidak efektif dapat diatasi dengan cepat, sehingga menciptakan kenyamanan bagi ibu dan menjamin kecukupan asupan nutrisi bagi neonatus.

2. Rekomendasi Klinis

a. Bagi Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas dan Klinik)

Direkomendasikan untuk menyusun program kelas ibu hamil yang mengintegrasikan materi simulasi teknis menyusui dan demonstrasi *breast care* menggunakan alat peraga (*phantom*) secara berkala sejak pemeriksaan antenatal trimester ketiga (Emilda et al., 2025; Sianturi & Siregar, 2025).

b. Bagi Manajemen Rumah Sakit

Kebijakan rawat gabung (*rooming-in*) pascapersalinan harus disertai dengan sistem pendampingan laktasi berkelanjutan oleh perawat atau bidan untuk mengoreksi posisi dan perlekatan secara langsung di samping tempat tidur pasien (Azkia, 2024; Nurliawati, 2023).

c. Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan dan Peneliti

Diharapkan terus mengembangkan media edukasi laktasi yang interaktif dan aplikatif serta menyebarluaskan protokol intervensi komplementer pijat oksitosin berbasis keluarga sebagai bagian dari asuhan keperawatan maternitas yang komprehensif di masyarakat (Lenny et al., 2024; Nurliawati et al., 2024).

Referensi

- Azkia, N. (2024). Edukasi teknik menyusui yang baik dan benar pada ibu primipara di Rumah Sakit Swasta X Kota Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, 6(2), 586-600.
- Emilda, S., Yuanita, V., & Marini, Y. (2025). Edukasi teknik perawatan payudara pada masa kehamilan dan menyusui di PMB Misni Herawati Palembang. *Jurnal Lantera Ilmiah Pengabdian Masyarakat (JLIPM)*, 2(2), 297-303.
- Faiqah, S., & Hamidiyanti, B. Y. F. (2021). Edukasi posisi dan perlekatan pada saat menyusui dalam upaya meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 3(1), 1419-1425.
- Lenny, Supriadi, & Fajrillah. (2024). Pengaruh edukasi perawatan payudara terhadap pengetahuan dan sikap ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Mamboro. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2022-2027.
- Nurliawati, E. (2023). Intervensi edukasi dan pendampingan teknik menyusui pada ibu post partum: Studi kasus. *Jurnal JKFT: Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 8(2), 1029-1040.
- Nurliawati, E., Sambas, E. K., & Suprpti, B. (2024). Intervensi pijat oksitosin pada ibu post partum: Studi kasus. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 7(2), 1331-1339.
- Rifqiyati, D. A., & Haryani, S. (2025). Gambaran pengelolaan menyusui tidak efektif dengan pijat oksitosin dan perawatan payudara pada ibu post partum spontan di RSUD Gondo Suwarno Ungaran. *Jurnal Scientific Journal of Nursing / Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 11(1), 2585-2592.
- Septiani, R., & Sumiyati. (2022). Efektivitas perawatan payudara (breast care) terhadap pembengkakan payudara (breast engorgement) pada ibu menyusui. *MJ (Midwifery Journal)*, 2(2), 66-73.
- Sianturi, E., & Siregar, M. (2025). Edukasi perawatan payudara dalam upaya meningkatkan efikasi diri menyusui pada ibu hamil trimester akhir. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)*, 9(3), 721-731.
- Wulandari, R., Suarni, S., Hidayati, A., Yuliarta, M., Sari, W. M. E., Pertiwi, N. P., Azmarizah, Juliantika, W., & Afriyani, L. D. (2023). Literature review: Pengaruh perawatan payudara terhadap bendungan ASI. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo*, 2(2), 1-9.

Glosarium

ASI = Air Susu Ibu

CALM = *Chin, Areola, Lips and Mouth*

LDR = *Let-down Reflex*

RPS= *Reverse Pressure Softening*

CHAPTER 5

INTERVENSI KEPERAWATAN PADA BENDUNGAN ASI DAN PUTING LECET

Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Bendungan ASI (*breast engorgement*) dan puting lecet (*sore/cracked nipples*) merupakan masalah laktasi yang sering terjadi pada ibu postpartum, terutama pada minggu pertama setelah persalinan. Bendungan ASI terjadi akibat peningkatan produksi ASI yang tidak diimbangi pengeluaran ASI secara optimal sehingga menyebabkan payudara terasa penuh, bengkak, tegang, dan nyeri. Sementara itu, puting lecet umumnya disebabkan oleh teknik menyusui yang tidak tepat, terutama kesalahan pelekatan bayi (*latch-on*) pada areola payudara. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan ibu, menghambat proses menyusui, dan meningkatkan risiko penghentian pemberian ASI lebih dini apabila tidak ditangani dengan baik. (Lathifah, F., & Ekayanthi, N.W.D., (2023).

Secara global, masalah laktasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan ibu postpartum. Data beberapa penelitian menunjukkan bahwa bendungan ASI dan puting lecet merupakan keluhan yang cukup sering ditemukan pada masa awal menyusui. Laporan penelitian menyebutkan bahwa masalah menyusui yang sering dialami ibu nifas meliputi puting lecet, bendungan ASI, dan mastitis yang berdampak terhadap keberlanjutan pemberian ASI. Di Indonesia, keluhan ini masih banyak ditemukan pada pelayanan nifas, khususnya pada ibu primipara yang belum memiliki pengalaman menyusui. (Damanik, S., Nasution, Y.E., & Rosa, E. (2025).

Bendungan ASI dan puting lecet memiliki dampak besar terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Nyeri pada payudara dan puting menyebabkan ibu merasa tidak nyaman saat menyusui sehingga frekuensi menyusui menjadi berkurang, pengosongan payudara tidak optimal, dan bayi mengalami kesulitan mendapatkan ASI yang cukup. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, ibu dapat mengalami penurunan motivasi menyusui bahkan penghentian ASI eksklusif sebelum enam bulan. (Marlina, Y., Widiasih, R., & Maryati, I. (2023).

Perawat dan bidan memiliki peran penting dalam penanganan serta pencegahan komplikasi laktasi melalui edukasi teknik menyusui yang benar,

pendampingan ibu postpartum, evaluasi pelekatan bayi, perawatan payudara (*breast care*), serta dukungan emosional kepada ibu menyusui. Intervensi tenaga kesehatan yang tepat dapat membantu ibu mengatasi masalah laktasi sejak dini sehingga mencegah terjadinya komplikasi seperti mastitis maupun kegagalan menyusui. (Susanti, T. (2025).

Urgensi penerapan intervensi keperawatan berbasis *evidence-based practice* menjadi sangat penting dalam penanganan bendungan ASI dan puting lecet. Hasil penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa intervensi seperti edukasi teknik menyusui, *breast care*, pijat payudara (misalnya pijat Oketani), kompres hangat–dingin, serta menyusui *on demand* terbukti membantu mengurangi bendungan ASI dan mempercepat pemulihan puting lecet. Oleh karena itu, intervensi berbasis bukti ilmiah perlu diterapkan secara konsisten dalam pelayanan postpartum guna meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. (Permatasari D., Ristiyana, S., & Aditia, D.S. (2021)

1. Definisi Masa Nifas dan Proses Laktasi

Masa nifas (*Postpartum period/puerperium*) adalah periode pemulihan fisiologis ibu setelah persalinan yang berlangsung selama kurang lebih 6 minggu (42 hari), dimulai sejak plasenta lahir hingga organ reproduksi kembali mendekati kondisi sebelum hamil. Pada periode ini terjadi perubahan anatomis, hormonal, psikologis, dan adaptasi peran ibu, termasuk proses menyusui. Masa nifas menjadi fase kritis dalam keberhasilan ibu mengalami transisi fisiologis menuju produksi dan pengeluaran ASI secara optimal. Adaptasi ibu terhadap perubahan ini memerlukan dukungan tenaga kesehatan, terutama perawat maternitas, untuk mencegah komplikasi menyusui dan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Cunningham, F. G., et al. (2022). McGraw-Hill. Amir, L. H., et al. (2021)

Proses laktasi merupakan mekanisme fisiologis pembentukan, sekresi, dan pengeluaran Air Susu Ibu (ASI) yang dikendalikan adanya interaksi hormon, terutama prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin yang berperan dalam produksi ASI di alveoli payudara, sedangkan hormon oksitosin memicu refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*) melalui kontraksi sel mioepitel. Laktogenesis terdiri dari beberapa tahap, yaitu laktogenesis I selama kehamilan, laktogenesis II setelah persalinan, dan galaktopoiesis yang mempertahankan produksi ASI berdasarkan prinsip *supply and demand*. Frekuensi menyusui yang adekuat dan pelekatan yang benar sangat menentukan kelancaran proses laktasi serta mencegah masalah payudara seperti bendungan ASI dan puting lecet. (McCarter-Spaulding, D. (2022), World Health Organization. (2023) .

2. Pentingnya Keberhasilan Menyusui terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi

Keberhasilan menyusui, khususnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. ASI merupakan sumber nutrisi terbaik yang mengandung zat gizi lengkap, antibodi, enzim, hormon, serta faktor imunologis yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Keberhasilan menyusui dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknik menyusui, dukungan keluarga, kesiapan psikologis ibu, dan dukungan tenaga kesehatan. Rendahnya keberhasilan menyusui dapat berdampak pada meningkatnya risiko masalah gizi dan infeksi pada bayi. (Puspasari J, et al (2024)

Bagi ibu, menyusui memberikan manfaat fisiologis dan psikologis. Menyusui membantu involusi uterus melalui stimulasi hormon oksitosin, mengurangi risiko perdarahan postpartum, serta dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara, kanker ovarium, diabetes tipe 2, dan depresi postpartum. Selain manfaat biologis, menyusui juga memperkuat *bonding attachment* antara ibu dan bayi sehingga meningkatkan kesejahteraan emosional keduanya. Namun, hambatan seperti bendungan ASI dan puting lecet dapat mengganggu keberhasilan proses menyusui apabila tidak dilakukan intervensi dini. (World Health Organization. (2023). Amir, L. H., et al. (2021).

Bagi bayi, keberhasilan menyusui memberikan manfaat besar terhadap sistem imun dan tumbuh kembang. ASI membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi terhadap penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan gangguan pencernaan. Selain itu, bayi yang memperoleh ASI eksklusif memiliki pertumbuhan fisik dan perkembangan neurologis yang lebih optimal dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI secara adekuat. Pemberian ASI juga berkontribusi terhadap pembentukan ikatan emosional (*bonding attachment*) antara ibu dan bayi sejak dini. (Kusuma, Nur Intan, Khofiyah Nidatul (2023).

Keberhasilan menyusui juga berpengaruh terhadap pencapaian program kesehatan masyarakat, terutama keberhasilan ASI eksklusif. Di Indonesia, angka keberhasilan menyusui masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu mengenai manajemen laktasi, teknik menyusui yang tidak tepat, serta kurang optimalnya dukungan tenaga kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang manajemen laktasi dan dukungan tenaga kesehatan memiliki hubungan signifikan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. (Uzlifatul Jannah, et all. 2025).

Peran perawat sangat penting dalam mendukung keberhasilan menyusui melalui edukasi teknik menyusui yang benar, pelaksanaan *Inisiasi Menyusu Dini*

(IMD), konseling laktasi, serta pendampingan selama masa postpartum. Intervensi tenaga kesehatan berbasis *evidence-based practice* terbukti mampu meningkatkan keberhasilan menyusui dan mencegah masalah laktasi seperti bendungan ASI dan puting lecet. Oleh karena itu, keberhasilan menyusui harus menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi. (Nuraini Fauziah, 2022)

3. Masalah Laktasi yang Paling Sering Terjadi: Bendungan ASI dan Puting Lecet

Masalah laktasi merupakan hambatan yang sering dialami ibu postpartum, terutama pada minggu pertama setelah persalinan ketika proses adaptasi menyusui sedang berlangsung. Dua masalah laktasi yang paling sering terjadi adalah bendungan ASI (*breast engorgement*) dan puting lecet (*sore/cracked nipples*). Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, nyeri, serta mengganggu keberhasilan pemberian ASI eksklusif apabila tidak ditangani secara tepat. Masalah laktasi umumnya berkaitan dengan kesalahan teknik menyusui, frekuensi menyusui yang tidak adekuat, serta kurang optimalnya pengosongan payudara. (Lathifah, F., & Ekayanthi, N.W.D. (2023).

a. Bendungan ASI (*Breast Engorgement*)

Bendungan ASI adalah kondisi pembengkakan pada payudara akibat peningkatan produksi ASI yang tidak diimbangi dengan pengeluaran ASI secara optimal. Kondisi ini biasanya terjadi pada hari ke-3 sampai ke-7 postpartum ketika produksi ASI meningkat. Payudara tampak membesar, terasa keras, tegang, nyeri, dan terkadang disertai peningkatan suhu tubuh ringan sehingga bayi mengalami kesulitan melakukan pelekatan saat menyusui. Bendungan ASI dapat disebabkan oleh keterlambatan IMD, pengosongan payudara yang tidak sempurna, frekuensi menyusui yang kurang, posisi menyusui yang tidak tepat, atau kelainan puting seperti puting datar dan terbenam. (Deng, X., et al. (2021), Safitriana, D., et al. (2024).

Apabila bendungan ASI tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan hambatan pengeluaran ASI, bayi sulit menyusui karena payudara terlalu tegang, bahkan meningkatkan risiko komplikasi seperti mastitis dan abses payudara. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi menyusui, posisi menyusui, dan keadaan puting susu memiliki hubungan signifikan dengan kejadian bendungan ASI pada ibu nifas. Oleh karena itu, ibu dianjurkan melakukan menyusui *on demand*, pengosongan payudara secara adekuat, serta melakukan perawatan payudara (*breast care*) untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. (Kuryani, T., dkk. (2025). Permatasari, D., Ristiyana, S., & Aditia, D.S. (2021))

b. Puting Lecet (*Sore/Cracked Nipples*)

Puting lecet merupakan salah satu masalah menyusui yang paling sering dialami ibu postpartum dan umumnya terjadi akibat teknik menyusui yang tidak benar, terutama kesalahan pelekatan bayi pada payudara (*incorrect latch-on*). Kondisi ini ditandai dengan rasa nyeri saat menyusui, kemerahan, luka, retakan, bahkan perdarahan ringan pada puting susu. Puting lecet sering menyebabkan ibu takut atau enggan menyusui karena rasa sakit yang muncul selama proses menyusui. (Agisti Winda Sari, Tri Susanti, 2025)

Puting lecet (*cracked nipple/nipple trauma*) merupakan trauma pada jaringan puting berupa kemerahan, lecet, retakan (*fissure*), hingga luka terbuka akibat pelekatan bayi yang tidak tepat. Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penyebab utama puting lecet adalah posisi dan teknik menyusui yang salah sehingga menimbulkan trauma mekanik pada puting. Selain itu, penggunaan pompa ASI yang tidak sesuai dan infeksi jamur juga menjadi faktor risiko tambahan. (Douglas, P. (2022). Nakamura, M., & Asaka, Y. (2022).)

Faktor yang berhubungan dengan kejadian puting lecet meliputi cara bayi menghisap puting, posisi menyusui yang salah, kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan payudara, serta frekuensi menyusui yang tidak efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan teknik menyusui yang kurang tepat memiliki risiko lebih besar mengalami puting lecet dibandingkan ibu dengan pelekatan menyusui yang baik. Penatalaksanaan yang dianjurkan meliputi edukasi teknik menyusui yang benar, *breast care*, menjaga kebersihan puting, dan pemberian terapi topikal seperti ASI perah atau minyak zaitun pada beberapa kasus. (Sukarni, & Lestari, D.N. (2025).

Puting lecet yang tidak ditangani dapat berdampak pada penurunan frekuensi menyusui, bendungan ASI sekunder, hingga kegagalan pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu, tenaga kesehatan terutama perawat dan bidan perlu melakukan deteksi dini, edukasi, dan pendampingan selama masa nifas agar ibu mampu mempertahankan proses menyusui secara optimal dan nyaman. (Cahyani, V.M., dkk. (2025))

4. Dampak Klinis Bendungan ASI dan Puting Lecet

a. Dampak Klinis Bendungan ASI (*Breast Engorgement*)

Bendungan ASI jika berlangsung terus-menerus, bendungan ASI dapat menyebabkan ketidaknyamanan berat yang mengganggu aktivitas ibu dan proses menyusui. Salah satu dampak klinis utama bendungan ASI adalah hambatan proses menyusui efektif. Payudara yang terlalu penuh dan tegang menyebabkan bayi sulit melekat dengan baik pada areola sehingga hisapan bayi menjadi tidak efektif. Akibatnya, pengeluaran ASI semakin terhambat, bayi

tidak memperoleh ASI secara optimal, dan ibu dapat mengalami penurunan kepercayaan diri dalam menyusui. Kondisi ini sering berujung pada penurunan frekuensi menyusui dan meningkatkan risiko kegagalan ASI eksklusif. (Permatasari, D., Ristiyana, S., & Aditia, D.S. (2021))

Apabila bendungan ASI tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius seperti mastitis (peradangan jaringan payudara) dan abses payudara. Stagnasi ASI yang berkepanjangan dapat memicu inflamasi bahkan infeksi bakteri, ditandai dengan demam tinggi, nyeri hebat, kemerahan pada payudara, serta gangguan kondisi umum ibu. Komplikasi ini tidak hanya mengganggu kesehatan ibu tetapi juga dapat menyebabkan penghentian menyusui dini, (Permatasari, D., Ristiyana, S., & Aditia, D.S. (2021))

Penelitian menunjukkan bahwa breast care efektif menurunkan nyeri, pembengkakan payudara, dan memperlancar pengeluaran ASI pada ibu postpartum dengan bendungan ASI. Intervensi dilakukan melalui pijatan ringan payudara, kompres hangat sebelum menyusui, dan pengosongan payudara secara teratur. Hasil penelitian memperlihatkan adanya penurunan skor bendungan ASI serta peningkatan kenyamanan ibu postpartum. (R,Afrina,er all 2024)

b. Dampak Klinis Puting Lecet (*Sore/Cracked Nipples*)

Dampak klinis awal yang paling sering muncul dari puting lecet adalah nyeri saat menyusui, rasa perih, dan sensasi terbakar pada area puting. Nyeri ini sering menyebabkan ibu merasa takut atau enggan menyusui sehingga mengurangi frekuensi pemberian ASI kepada bayi. Secara klinis, puting lecet juga berdampak pada ketidakefektifan proses laktasi. Nyeri yang dialami ibu dapat menyebabkan posisi menyusui menjadi tidak optimal dan bayi tidak memperoleh pelekatan yang baik. Akibatnya, bayi menerima ASI dalam jumlah kurang adekuat, mengalami gangguan kepuasan menyusu, serta berisiko mengalami penurunan berat badan atau kurangnya asupan nutrisi pada awal kehidupan. Selain itu, puting lecet dapat menyebabkan ibu menghentikan menyusui sebelum waktunya sehingga memengaruhi keberhasilan ASI eksklusif. (Gustina, F., & Herawati, I. (2025) Sulymbona, N., dkk. (2021))

Bila tidak ditangani secara tepat, puting lecet dapat meningkatkan risiko infeksi pada jaringan puting dan payudara, bahkan menjadi faktor predisposisi terjadinya bendungan ASI sekunder dan mastitis. Luka terbuka pada puting dapat menjadi pintu masuk mikroorganisme, terutama apabila kebersihan payudara tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini dan intervensi segera berupa koreksi teknik menyusui, *breast care*, serta edukasi

perawatan puting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. (Putri, N.M., & Ardhiyanti, Y. (2022) Afrina R. et all (2024))

B. INTERVENSI KEPERAWATAN PADA BENDUNGAN ASI DAN PUTING LECET

1. Intervensi Keperawatan Pada Bendungan ASI (*Breast Engorgement*)

Bendungan ASI (*breast engorgement*) merupakan kondisi pembengkakan payudara akibat penumpukan ASI yang tidak dikeluarkan secara optimal, umumnya terjadi pada hari ke-3 hingga ke-7 postpartum. Intervensi keperawatan pada bendungan ASI bertujuan untuk mengurangi nyeri, memperlancar pengeluaran ASI, meningkatkan kenyamanan ibu, mencegah komplikasi seperti mastitis, serta mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Berdasarkan penelitian lima tahun terakhir, intervensi keperawatan yang efektif meliputi edukasi teknik menyusui, *breast care*, kompres hangat–dingin, pijat laktasi, serta dukungan menyusui berkelanjutan. (Netty Ami Ruhama Fortuna Sihite. et all (2022))

a. Edukasi Teknik Menyusui yang Benar

Edukasi teknik menyusui menjadi intervensi utama pada bendungan ASI karena sebagian besar kasus dipicu oleh pelekatan (*latch-on*) yang tidak tepat dan pengosongan payudara yang tidak adekuat. Perawat perlu mengajarkan posisi menyusui yang benar, memastikan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi, serta menganjurkan ibu menyusui secara on demand atau sesering mungkin untuk mencegah penumpukan ASI. Penelitian menunjukkan bahwa posisi menyusui dan frekuensi menyusui memiliki hubungan signifikan dengan kejadian bendungan ASI pada ibu nifas. (Tri Kuryani. Et all 2024) Siswatiningsih, O., Syarah, M., & Lisca, S.M. (2023))

b. *Breast Care* (Perawatan Payudara)

Breast care merupakan intervensi keperawatan yang dilakukan untuk memperlancar aliran ASI, mengurangi pembengkakan, dan meningkatkan kenyamanan ibu. Tindakan ini meliputi pembersihan payudara, pijatan ringan pada area payudara, stimulasi pengeluaran ASI, serta pengosongan payudara secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan penerapan *breast care* efektif membantu menurunkan bendungan ASI serta memperbaiki kelancaran proses menyusui pada ibu postpartum. (Sulfiana, Kautzar, A.M., & Taherong, F. (2024). Sihite, N.A.R.F., Novayelinda, R., & Lestari, W. (2022))

c. Kompres Hangat dan Kompres Dingin

Kompres hangat sebelum menyusui membantu melancarkan aliran ASI dengan meningkatkan vasodilatasi dan relaksasi jaringan payudara, sedangkan kompres dingin setelah menyusui membantu mengurangi edema, nyeri, dan

inflamasi. Intervensi ini sering direkomendasikan sebagai terapi nonfarmakologis pada bendungan ASI karena mudah dilakukan, aman, dan efektif meningkatkan kenyamanan ibu menyusui. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi kompres hangat dengan intervensi pijat payudara memberikan hasil yang lebih baik dalam mengurangi gejala bendungan ASI. (Kusumawati, Y., Ciptiasrini, U., & Izza, L.N. (2025) Sulfiana, dkk. (2024))

d. Pijat Laktasi / Pijat Oketani

Pijat laktasi, termasuk teknik *pijat Oketani*, merupakan intervensi nonfarmakologis yang terbukti membantu mengurangi bendungan ASI. Teknik ini dilakukan melalui pijatan lembut pada area payudara untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi sumbatan saluran ASI, dan mempercepat pengeluaran ASI. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan nyeri, pelunakan payudara, serta peningkatan kelancaran ASI setelah dilakukan pijat laktasi secara rutin pada ibu postpartum dengan bendungan ASI. (Sesti, I., & Yulita, N. (2025). Kusumawati, Y., dkk. (2025))

e. Dukungan dan Konseling Menyusui

Dukungan emosional dan konseling laktasi dari perawat atau bidan sangat penting dalam keberhasilan intervensi bendungan ASI. Perawat berperan dalam memberikan edukasi, motivasi, pemantauan teknik menyusui, serta membantu ibu mengatasi kecemasan yang muncul akibat nyeri dan kesulitan menyusui. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepercayaan diri ibu dan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. (Sihite, N.A.R.F., dkk. (2022), Sulfiana, dkk. (2024)).

2. Intervensi Keperawatan pada Puting Lecet (*Sore/Cracked Nipples*)

Puting lecet (*sore/cracked nipples*) merupakan salah satu masalah laktasi yang paling sering dialami ibu postpartum, terutama pada minggu pertama menyusui. Kondisi ini ditandai dengan nyeri, kemerahan, iritasi, retakan, hingga luka pada puting susu yang umumnya disebabkan oleh teknik pelekatan bayi (*latch-on*) yang tidak tepat. Intervensi keperawatan pada puting lecet bertujuan untuk mengurangi nyeri, mempercepat penyembuhan jaringan puting, mempertahankan keberlangsungan menyusui, serta mencegah komplikasi seperti bendungan ASI dan mastitis. Berdasarkan jurnal lima tahun terakhir, intervensi yang efektif meliputi edukasi teknik menyusui, *breast care*, perawatan topikal, konseling laktasi, dan dukungan psikologis ibu.

a.

Edukasi Teknik Menyusui yang Benar

Edukasi teknik menyusui merupakan intervensi utama pada puting lecet karena sebagian besar kasus terjadi akibat kesalahan posisi dan pelekatan bayi saat menyusui. Perawat perlu mengajarkan posisi menyusui yang nyaman, memastikan mulut bayi membuka lebar, dagu menempel pada payudara, serta sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Teknik pelekatan yang tepat terbukti mengurangi gesekan pada puting dan mempercepat proses penyembuhan luka. Penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan teknik menyusui yang baik memiliki risiko lebih rendah mengalami puting lecet dibandingkan ibu dengan teknik menyusui yang tidak tepat.(Sulymbona, N., dkk. (2021) Marlina, Y., Widiasih, R., & Maryati, I. (2023))

b. *Breast Care* (Perawatan Payudara)

Breast care dilakukan untuk menjaga kebersihan payudara, memperbaiki sirkulasi darah, serta mencegah kerusakan jaringan puting lebih lanjut. Intervensi ini meliputi pembersihan puting secara lembut, menjaga kelembapan alami kulit, serta evaluasi kondisi puting sebelum dan sesudah menyusui. Perawat juga perlu mengajarkan ibu untuk menghindari penggunaan sabun atau bahan iritatif pada puting karena dapat memperburuk kekeringan dan lecet. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melakukan *breast care* secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami puting lecet dan gangguan menyusui.(Sukarni, & Lestari, D.N. (2025). Susanti, T. (2025).

c. Pemberian ASI Topikal pada Puting Lecet

Salah satu intervensi nonfarmakologis yang direkomendasikan adalah penggunaan ASI perah sebagai terapi topikal pada puting lecet. ASI mengandung faktor antiinflamasi, antibakteri, dan zat penyembuh jaringan yang membantu mempercepat regenerasi kulit puting. Cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan beberapa tetes ASI pada area puting setelah menyusui dan membiarkannya mengering secara alami. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ASI topikal efektif mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan puting lecet pada ibu postpartum.(Rahmawati, D., & Kurniasari, E. (2022), Sulymbona, N., dkk.(2021)

d. Terapi Topikal dengan *Olive Oil* (Minyak Zaitun)

Selain ASI topikal, beberapa penelitian melaporkan bahwa penggunaan minyak zaitun (*olive oil*) dapat membantu mempercepat penyembuhan puting lecet karena memiliki sifat antiinflamasi dan pelembap alami. Penggunaan minyak zaitun dilakukan dengan mengoleskan tipis pada area puting setelah menyusui untuk membantu memperbaiki kerusakan jaringan kulit dan mengurangi rasa nyeri. Studi kasus kebidanan menunjukkan adanya perbaikan

kondisi puting setelah pemberian terapi ini secara rutin pada ibu postpartum.(Putri, N.M., & Ardhiyanti, Y. (2022)).

3. Konseling dan Dukungan Menyusui

Konseling laktasi dan dukungan emosional dari perawat atau bidan merupakan bagian penting dari intervensi keperawatan pada puting lecet. Rasa nyeri saat menyusui sering membuat ibu mengalami kecemasan, stres, bahkan keinginan menghentikan pemberian ASI. Perawat berperan memberikan motivasi, evaluasi teknik menyusui, pemantauan perkembangan luka, serta dukungan psikologis agar ibu tetap percaya diri dalam menyusui. Dukungan tenaga kesehatan terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui dan mencegah penghentian ASI eksklusif dini.(Melia, R., Arif, A., & Anggraini, A. (2023), Marlina, Y., dkk. (2023)).

C. Hambatan dalam Melakukan Intervensi Bendungan ASI dan Puting Lecet

Intervensi keperawatan pada bendungan ASI dan puting lecet bertujuan untuk mengurangi nyeri, memperbaiki proses menyusui, dan mencegah komplikasi laktasi. Namun, dalam praktik klinis terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan intervensi tidak berjalan optimal. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor ibu, bayi, tenaga kesehatan, lingkungan keluarga, maupun sistem pelayanan kesehatan sehingga berdampak pada keterlambatan penanganan masalah laktasi. Lathifah, F., & Ekayanthi, N.W.D. (2023).

1. Kurangnya Pengetahuan Ibu tentang Teknik Menyusui

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman ibu mengenai teknik menyusui yang benar menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan intervensi bendungan ASI dan puting lecet. Banyak ibu postpartum belum memahami posisi menyusui, pelekatan (*latch-on*), cara mengosongkan payudara, maupun tanda awal bendungan ASI. Akibatnya, edukasi yang telah diberikan tenaga kesehatan sering tidak diterapkan secara tepat di rumah sehingga kondisi bendungan ASI dan puting lecet berulang atau memburuk. Penelitian tahun 2021–2022 menemukan adanya hubungan signifikan antara teknik menyusui yang salah dengan kejadian puting lecet pada ibu nifas. (Sulymbona, N., dkk. (2021).)

2. Nyeri dan Ketidaknyamanan Ibu saat Menyusui

Nyeri akibat bendungan ASI dan puting lecet menjadi hambatan besar dalam keberhasilan intervensi. Ibu yang mengalami nyeri cenderung takut menyusui, mengurangi frekuensi menyusui, atau menghentikan *breast care* karena rasa tidak nyaman. Pada bendungan ASI, payudara yang keras dan tegang

menyebabkan bayi sulit melekat dengan baik, sedangkan pada puting lecet rasa sakit membuat ibu enggan memberikan ASI secara langsung. Penelitian menunjukkan bahwa nyeri yang tidak segera ditangani meningkatkan risiko kegagalan ASI eksklusif dan memperberat masalah laktasi. (Permatasari, D., Ristiyana, S., & Aditia, D.S. (2021), Sihite, N.A.R.F., dkk. (2022)).

3. Faktor Anatomis Payudara dan Kondisi Fisik Ibu

Hambatan lain dalam intervensi adalah kondisi anatomis seperti puting terbenam (*inverted nipple*), puting datar, payudara yang terlalu bengkak, atau produksi ASI berlebih. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa puting terbenam dan posisi menyusui yang tidak tepat berhubungan signifikan dengan bendungan ASI. Pada kondisi ini, bayi mengalami kesulitan melakukan pelekatan sehingga intervensi seperti edukasi teknik menyusui membutuhkan pendampingan lebih intensif dan waktu yang lebih lama. (Damanik, S., Nasution, Y.E., & Rosa, E. (2025). Kuryani, T., dkk. (2025)).

4. Kurangnya Dukungan Keluarga dan Lingkungan

Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kurangnya dukungan keluarga menjadi hambatan penting dalam keberhasilan intervensi bendungan ASI dan puting lecet. Sebagian ibu masih mendapatkan informasi yang keliru, misalnya pembatasan frekuensi menyusui atau pemberian susu formula dini ketika ibu mengalami nyeri. Dukungan emosional, bantuan perawatan bayi, dan motivasi dari suami maupun keluarga terbukti meningkatkan keberhasilan penerapan intervensi seperti menyusui *on demand*, kompres hangat, *breast care*, dan koreksi teknik menyusui. Faktor budaya dan persepsi masyarakat juga memengaruhi keberhasilan penanganan masalah laktasi. (Lisna, Uly, N., & Alim, A. (2025)).

5. Keterbatasan Edukasi dan Pendampingan Tenaga Kesehatan

Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah keterbatasan waktu edukasi, kurang optimalnya konseling laktasi, serta minimnya tindak lanjut setelah ibu pulang dari fasilitas kesehatan. Banyak ibu nifas belum mendapatkan demonstrasi langsung mengenai posisi menyusui, cara memerah ASI, maupun teknik perawatan payudara dan puting. Akibatnya, intervensi keperawatan yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan tidak berjalan optimal di rumah. Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan tenaga kesehatan yang konsisten dapat meningkatkan keberhasilan intervensi laktasi dan mencegah komplikasi bendungan ASI maupun puting lecet. (Lathifah, F., & Ekayanthi, N.W.D. (2023), Sihite, N.A.R.F., dkk. (2022))

D. Kesimpulan

Intervensi keperawatan pada bendungan ASI dan puting lecet bertujuan untuk mengurangi nyeri, memperlancar proses menyusui, mencegah komplikasi laktasi, serta meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif pada ibu postpartum. Berdasarkan hasil penelitian 5 tahun terakhir, intervensi yang efektif meliputi edukasi teknik menyusui yang benar, *breast care* (perawatan payudara), kompres hangat–dingin, pijat laktasi/pijat Oketani, penggunaan ASI topikal atau *olive oil* pada puting lecet, serta konseling dan dukungan menyusui. Keberhasilan intervensi dipengaruhi oleh pengetahuan ibu, dukungan keluarga, kondisi fisik ibu, dan pendampingan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan yang komprehensif dan berbasis *evidence-based practice* diperlukan untuk mendukung kenyamanan ibu, keberlangsungan menyusui, dan kesehatan ibu serta bayi.

Referensi

- Agisti Winda Sari, Tri Susanti,(2025) Management Asuhan Kebidan Pada Ibu Nifas Dengan Puting Susu Lecet Jurnal Kesehatan Wira Buana Volume 9 no 2,September2025.
- Amir .L.H.,et al (2021) Breast and nipple pain in breastfeeding women: diagnosis and management. *The BMJ*, 374, 1628.
- Afrina R. et all (2024) Aplikasi Breast Care Terhadap Ketidaknyamanan Pasca Partum Ibu Dengan Bendungan ASI, Vol.2, No.1 Januari 2024 Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan .
- Cahyani, V.M., dkk. (2025). *Gambaran Perilaku Ibu Menyusui dalam Mengatasi Permasalahan Puting Lecet*. Jurnal Keperawatan, 13(1)
- Cunningham,F.G., et al. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Damanik, S., Nasution, Y.E., & Rosa, E. (2025). *Breast Milk Retention Caused by Inverted Nipples and Breastfeeding Techniques for Postpartum Mothers*. Jurnal Kebidanan Malahayati, 11(10).
- Douglas,P. (2022). Lactation-related nipple pain and damage. *Women's Health*,18,1–14.
- Deng, X., et al. (2021). Maternal risk factors for lactation mastitis. *Western Journal of Nursing Research*, 43(9), 859–867.
- Gustina, F., & Herawati, I. (2025). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pendidikan Ibu dalam Teknik Menyusui dengan Keadaan Puting Susu Lecet*. **Jurnal Ners**, 9(2), 2440–2444
- Kuryani, T., dkk. (2025). *Hubungan Posisi Menyusui, Frekuensi Menyusui, Keadaan Puting Susu dengan Bendungan ASI pada Ibu Nifas*. Jurnal Kesehatan dan Pembangunan.
- Kusuma,Nur Intan,Khofiyah Nidatul (2022) Practical support for breastfeeding mothers in achieving exclusive breastfeeding: A scoping review. Vol.13 No 3 Jurnal Kedokteran & Kesehatan Indonesia.<https://doi.org/10.20885/JKKI.Vol13.Iss3.art11>
- Kusumawati, Y., Ciptiasrini, U., & Izza, L.N. (2025). *Efektivitas Pijat Oketani dan Kompres Hangat terhadap Bendungan ASI pada Ibu Menyusui di RSUD Malingping Tahun 2025*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(3).
- Lathifah, F., & Ekayanthi, N.W.D. (2023). *Laporan Asuhan Kebidanan Post Partum dengan Puting Susu Lecet dan Bendungan ASI*. Jurnal Kesehatan Siliwangi, 3(3), 694–698. DOI: 10.34011/jks.v3i3.1335.

- Lisna, Uly, N., & Alim, A. (2025). *Faktor Sosial Budaya, Psikologis, dan Intervensi terhadap Praktik Pemberian ASI Eksklusif: Tinjauan Literatur*. Edisi 17 Volume 1(2025)Bina Generasi Jurnal Kesehatan.
- McCarter-Spaulding, D. (2022). Lactation and breastfeeding support in postpartum nursing care. *Journal of Human Lactation*, 38(2), 210–218.
- Marlina, Y., Widiasih, R., & Maryati, I. (2023). *Edukasi Kesehatan Teknik Menyusui Menggunakan Media Video dan Media Leaflet terhadap Pencegahan Puting Lecet pada Ibu Postpartum*. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 3892–3899. DOI 10.31539/joting.v5i2.8386.
- Melia, R., Arif, A., & Anggraini, A. (2023). *Hubungan Peran Tenaga Kesehatan dengan Keberhasilan Menyusui pada Ibu Postpartum*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3).
- Nakamura, M., & Asaka, Y. (2022). Nipple trauma associated with breastfeeding. *Journal of Human Lactation*, 38(4), 715–726.
- Netty Ami Ruhama Fortuna Sihite. et all (2022)) *Gambaran Insiden Bendungan ASI Dan Upaya Yang Dilakukan Ibu Untuk Mengatasinya Health Care : Jurnal Kesehatan* 11 (1) Juni 2022 (145-152)
- Nuraini Fauziah,(2022) *Keberhasilan Dukungan Tenaga Kesehatan saat Perawatan Pasca Persalinan Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Jurnal Sains dan Teknologi Kesehatan Volume 4, Nomor 1, Desember 2022, pp. 15-21*
- Permatasari, D., Ristiyana, S., & Aditia, D.S. (2021). *Penatalaksanaan Pijat Oketani pada Bendungan ASI di BPM Ana Maria Way Kanan Tahun 2021*. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 11(1).
- Puspasari J,et all (2024) *Self-efficacy pada Ibu Postpartum dalam Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif: Scoping Review*. *Jurnal PGI Cikini Vol. 5, No. 2, Juli 2024, pp. 192 -204*
- Putri, N.M., & Ardhiyanti, Y. (2022). *Midwifery Care for Postpartum Mothers with Cracked Nipples Using Olive Oil*. *Jurnal Kebidanan Terkini*, 2(1), 37–43.
- Rahmawati, D., & Kurniasari, E. (2022). *Efektivitas ASI Topikal terhadap Penyembuhan Puting Lecet pada Ibu Nifas*. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1).
- Safitriana, D., et al. (2024). Management of breast and nipple problems in breastfeeding mothers. *DPPHJ Journal*, 5(1), 15–24.
- Sihite, N.A.R.F., Novayelinda, R., & Lestari, W. (2022). *Gambaran Insiden Bendungan ASI dan Upaya yang Dilakukan Ibu untuk Mengatasinya*. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 11(1).

- Sesti, I., & Yulita, N. (2025). *Penerapan Pijat Laktasi sebagai Strategi Non-Farmakologis dalam Penanganan Bendungan ASI*. JKEMS–Jurnal Kesehatan Masyarakat, 4(1).
- Siswatiningsih, O., Syarah, M., & Lisca, S.M. (2023). *Hubungan antara Posisi Menyusui, Frekuensi Menyusui dan Perilaku Pemberian ASI terhadap Bendungan ASI*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(5), 1542–1554.
- Sukarni, & Lestari, D.N. (2025). *Hubungan Cara Menghisap Puting dan Cara Merawat Payudara dengan Kejadian Puting Lecet*. Jurnal Maternitas Aisyah. 6(3)
- Sulfiana, Kautzar, A.M., & Taherong, F. (2024). *Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal pada Ny. "N" dengan Bendungan ASI di Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar*. Jurnal Midwifery, 6(1)
- Sulymbona, N., dkk. (2021). *Hubungan Cara Pemberian ASI dengan Kejadian Masalah pada Puting Lecet*. Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada, 12(1), 97–106.
- Susanti, T. (2025). *Management Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas dengan Puting Susu Lecet*. Jurnal Kesehatan Wira Buana, 9(2).
- Tri Kuryani et all (2024) Hubungan Posisi Menyusui Frekuensi Menyusui, Keadaan Puting Susu Dengan Bendungan ASI Pada Ibu Nifas Di Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024. [Vol 15 No 2 \(2025\)](#): Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan
- Uzlifatul Jannah, et all. (2025) Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Tentang Manajemen Laktasi pada Ibu Menyusui terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif, South Asean Journal of Social Studies Vol. 5, No. 1, 2025.
- World Health Organization. (2023). *Breastfeeding and maternal health*.



CHAPTER 6



DUKUNGAN KELUARGA DALAM KEBERHASILAN ASI EKSKLUSIF

Dr. Ns. Tutik Rahayu, Mkep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif memiliki makna biologis yang jauh melampaui fungsi pemenuhan kebutuhan gizi dasar bayi. Pada enam bulan pertama kehidupan, ASI memang menyediakan keseimbangan zat gizi makro dan mikro yang esensial untuk pertumbuhan, (Brockway, 2024). Namun pada saat yang sama juga menjadi sarana transfer komponen imunologis maternal yang berperan dalam pembentukan sistem pertahanan tubuh bayi yang masih dalam tahap maturasi. Dengan kata lain, proses menyusui bukan hanya aktivitas nutrisi, tetapi juga proses biologis yang mentransmisikan perlindungan imun dari ibu kepada anaknya. (Macura et al., 2026).

Berbagai komponen bioaktif dalam ASI, seperti imunoglobulin (terutama sekretory IgA), laktoferin, lisozim, sel imun, serta oligosakarida spesifik, bekerja secara sinergis dalam menghambat kolonisasi dan proliferasi patogen pada mukosa saluran cerna maupun pernapasan bayi (Macura et al., 2026). Komponen tersebut tidak hanya bersifat protektif pasif, tetapi juga memiliki fungsi regulatif terhadap respons imun, termasuk dalam pembentukan toleransi imunologis dan keseimbangan mikrobiota usus awal kehidupan (Brockway, 2024).

Kajian imunologi mutakhir menunjukkan bahwa kandungan bioaktif dalam ASI berkontribusi pada aktivasi dan modulasi respons imun bawaan (innate immunity) maupun imun adaptif, sehingga bayi yang memperoleh ASI eksklusif cenderung memiliki sistem imun yang lebih responsif dan terlatih dibandingkan bayi yang tidak disusui secara eksklusif (Andres et al., 2023). Mekanisme kompleks ini menjelaskan mengapa pemberian ASI eksklusif secara konsisten dikaitkan dengan penurunan kejadian infeksi saluran cerna dan infeksi saluran pernapasan pada awal kehidupan. Lebih jauh, literatur imunologi juga menegaskan bahwa efek protektif tersebut tidak berhenti pada periode neonatal, tetapi berimplikasi terhadap kesehatan jangka panjang melalui proses pemrograman imunologis sejak dini (Kerketta et al., 2026).

Organisasi Kesehatan Dunia dan United Nations Children's Fund menegaskan bahwa pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan merupakan strategi utama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal (Hossain & Mahrshahi, 2022). Setelah usia enam bulan, bayi mulai

diperkenalkan dengan makanan pendamping yang adekuat, namun proses menyusui tetap dianjurkan untuk dilanjutkan hingga usia dua tahun atau lebih sebagai bagian dari praktik pemberian makan yang responsif dan berkelanjutan (Weiler et al., 2025).

Rekomendasi ini didasarkan pada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi bayi pada awal kehidupan, tetapi juga memberikan perlindungan imunologis yang signifikan. Bayi yang memperoleh ASI eksklusif memiliki risiko lebih rendah mengalami infeksi saluran cerna, pneumonia, malnutrisi, serta kematian pada tahun pertama kehidupan dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI secara optimal (Perrella et al., 2021). Dengan demikian, praktik ASI eksklusif dipandang sebagai intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dan berbiaya rendah dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas bayi secara global.

Meskipun praktik ASI eksklusif diakui sebagai strategi penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas bayi, cakupan pemberiannya di banyak negara, termasuk Indonesia, masih di bawah target nasional dan global. Keberhasilan ASI eksklusif dipengaruhi oleh beragam faktor, tidak hanya kesiapan biologis dan pengetahuan ibu, tetapi juga kondisi psikososial dan dukungan lingkungan di sekitar ibu (Naufal et al., 2023). Bukti dari berbagai studi menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dukungan praktis dari keluarga termasuk dukungan emosional, informasi, dan bantuan konkret dari suami, ibu, atau anggota keluarga lainnya berkontribusi positif terhadap keberlanjutan praktik menyusui dan memperkuat kepercayaan diri ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif hingga usia enam bulan (Fadjriah et al., 2021). Selain itu, dukungan sosial dari orang terdekat juga berhubungan dengan durasi menyusui melalui peningkatan keyakinan ibu terhadap kemampuan menyusui dan menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pemberian ASI (Lyons et al., 2023).

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan determinan penting dalam mempertahankan praktik ASI eksklusif. Hasil penelitian di Indonesia menemukan bahwa bentuk-bentuk dukungan keluarga, meliputi dukungan emosional, informasional, instrumental, dan evaluatif, berhubungan secara signifikan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui (Fadjriah et al., 2021). Selain itu, ulasan literatur internasional menempatkan dukungan sosial, termasuk dari anggota keluarga dekat, sebagai salah satu faktor fasilitator utama keberhasilan ASI eksklusif (Sabilla et al., 2025). Temuan lain juga menunjukkan bahwa dukungan sosial memainkan peran penting dalam memperkuat self-efficacy ibu menyusui, yang pada gilirannya berkaitan dengan durasi dan keberlanjutan ASI eksklusif (Özcan, 2025).

Dalam konteks keperawatan maternitas, dukungan keluarga berperan dalam memperkuat kemampuan adaptasi ibu terhadap tantangan menyusui, meningkatkan self-efficacy, serta mengurangi stres postpartum. Oleh karena itu, eksplorasi evidens berbasis penelitian terkini mengenai peran dukungan keluarga menjadi penting untuk memperkuat intervensi praktik keperawatan.

B. Konsep Dasar Pemberian ASI Eksklusif

1. Pengertian ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah praktik pemberian hanya ASI kepada bayi sejak lahir hingga usia enam bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat, vitamin, atau mineral yang diresepkan oleh tenaga kesehatan (E-issn et al., 2025). Definisi ini menegaskan bahwa selama periode enam bulan pertama kehidupan, kebutuhan nutrisi dan cairan bayi sepenuhnya dapat dipenuhi oleh ASI (Osman et al., 2023).

Secara biologis, ASI mengandung komposisi zat gizi yang dinamis dan menyesuaikan dengan usia serta kebutuhan bayi. Kandungan makronutrien seperti protein whey yang mudah dicerna, lemak esensial, serta laktosa sebagai sumber energi utama mendukung pertumbuhan optimal (Yang & Szeto, 2023). Selain itu, ASI kaya akan komponen imunologis seperti imunoglobulin A (IgA), laktoferin, dan sel-sel imun aktif yang berperan dalam melindungi bayi dari infeksi (Cristóbal-cañadas et al., 2025).

Dengan demikian, ASI eksklusif tidak hanya dipahami sebagai praktik pemberian nutrisi, tetapi juga sebagai intervensi kesehatan preventif yang mendukung kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang bayi.

2. Rekomendasi Global tentang ASI

Organisasi kesehatan global secara konsisten merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan, dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI yang adekuat hingga usia dua tahun atau lebih. Rekomendasi ini ditegaskan kembali dalam pedoman terkini WHO dan UNICEF sebagai bagian dari strategi global peningkatan kesehatan ibu dan anak (Meek & Noble, 2022).

Target global yang ditetapkan dalam Global Nutrition Targets 2025 dan diperkuat dalam laporan WHO–UNICEF terbaru menekankan peningkatan cakupan ASI eksklusif minimal 50% pada bayi usia 0–6 bulan (Esmaeel et al., 2025). Namun demikian, capaian di berbagai negara masih belum merata, sehingga intervensi berbasis keluarga dan komunitas tetap menjadi prioritas kebijakan kesehatan masyarakat (Tomori, 2023).

Pendekatan promosi ASI saat ini tidak hanya berfokus pada ibu, tetapi juga pada sistem dukungan keluarga, fasilitas kesehatan ramah menyusui, serta kebijakan perlindungan maternitas di tempat kerja

3. Mekanisme Fisiologis Laktasi

Proses laktasi melibatkan interaksi kompleks antara sistem hormonal dan stimulasi mekanik melalui hisapan bayi. Setelah persalinan, penurunan kadar hormon progesteron memicu aktivasi hormon prolaktin yang berperan dalam produksi ASI di alveoli payudara. Prolaktin diproduksi oleh hipofisis anterior dan meningkat setiap kali terjadi stimulasi puting oleh bayi (Wati et al., 2023). Sementara itu, refleks pengeluaran ASI (let-down reflex) dikendalikan oleh hormon oksitosin yang dilepaskan oleh hipofisis posterior. Oksitosin menyebabkan kontraksi sel mioepitel di sekitar alveoli sehingga ASI terdorong menuju duktus laktiferus dan keluar melalui puting (Kamikawa & Seko, 2020).

Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan efektivitas pelekatan bayi. Hisapan yang adekuat tidak hanya meningkatkan produksi ASI melalui mekanisme supply-demand, tetapi juga mempertahankan kontinuitas laktasi (Pujiastuti & Winarni, 2025). Faktor psikologis seperti stres dan kecemasan ibu dapat memengaruhi refleks oksitosin, sehingga dukungan emosional memiliki peran penting dalam mempertahankan kelancaran menyusui (Matsunaga et al., 2026).

4. Manfaat ASI Eksklusif bagi Bayi dan Ibu

a. Manfaat bagi Bayi

Bukti ilmiah terbaru menunjukkan bahwa ASI eksklusif secara signifikan menurunkan risiko infeksi saluran cerna dan infeksi saluran pernapasan pada bayi (Hossain & Mahrshahi, 2022). Kandungan antibodi dan faktor antiinflamasi dalam ASI berfungsi sebagai perlindungan imunologis alami, terutama pada enam bulan pertama kehidupan ketika sistem imun bayi belum matang sempurna (Gómez et al., 2021). Selain itu, praktik ASI eksklusif berkontribusi terhadap penurunan risiko malnutrisi dan stunting, serta dikaitkan dengan perkembangan kognitif yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (P. N. Journal, 2026)

b. Manfaat bagi Ibu

Bagi ibu, menyusui memberikan manfaat fisiologis dan jangka panjang. Pelepasan oksitosin selama menyusui membantu kontraksi uterus sehingga mempercepat involusi dan mengurangi risiko perdarahan postpartum. Dalam jangka panjang, praktik menyusui dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara dan kanker ovarium, serta membantu pengaturan jarak kehamilan melalui mekanisme amenore laktasi (WHO, 2021). Secara psikologis, menyusui

juga memperkuat ikatan emosional ibu dan bayi serta meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menjalankan peran keibuannya.

C. Dukungan Keluarga dalam Keberhasilan ASI Eksklusif

Dukungan keluarga dalam konteks menyusui dipahami sebagai keterlibatan aktif anggota keluarga terutama suami dan orang tua dalam memberikan bantuan emosional, praktis, informasi, dan penguatan psikologis kepada ibu selama periode menyusui (Meher, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya dipengaruhi oleh motivasi ibu, tetapi sangat ditentukan oleh lingkungan sosial terdekatnya, khususnya keluarga inti. Dalam kajian kesehatan maternal modern, dukungan keluarga diposisikan sebagai determinan interpersonal yang berperan dalam membentuk keputusan, ketahanan, dan keberlanjutan perilaku menyusui (Priscilla & Afiyanti, 2021).

1. Dukungan Emosional (Emotional Support)

Dukungan emosional merujuk pada ekspresi empati, perhatian, dan penerimaan terhadap ibu menyusui. Bentuk dukungan ini mencakup kesediaan mendengarkan keluhan ibu, memberikan rasa tenang, serta menunjukkan keyakinan bahwa ibu mampu menyusui bayinya secara optimal. Studi sistematis menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional dari pasangan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mempertahankan ASI eksklusif hingga enam bulan dibandingkan ibu yang kurang mendapatkan dukungan (Margaretha et al., 2025).

Hasil riset menunjukan bahwa persepsi ibu terhadap dukungan emosional dari suami berhubungan signifikan dengan peningkatan kepercayaan diri menyusui dan penurunan stres postpartum. Kondisi emosional yang stabil berkontribusi terhadap kelancaran refleks oksitosin, sehingga secara tidak langsung mendukung proses pengeluaran ASI (Davidson & Ollerton, 2020).

2. Dukungan Instrumental (Instrumental Support)

Dukungan instrumental merupakan bantuan konkret yang diberikan kepada ibu dalam bentuk tindakan nyata, seperti membantu pekerjaan rumah, merawat bayi saat ibu beristirahat, atau menyediakan kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Keterlibatan praktis ini terbukti mengurangi beban fisik dan kelelahan ibu pada masa postpartum awal (B. Journal et al., 2025).

Sebuah studi menunjukkan bahwa ibu yang menerima bantuan domestik secara konsisten dari anggota keluarga memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan praktik ASI eksklusif selama enam bulan. Dukungan

instrumental membantu ibu memfokuskan energi pada proses menyusui, terutama pada fase adaptasi awal laktasi (Hu, 2025).

3. Dukungan Informasional (Informational Support)

Dukungan informasional mencakup pemberian pengetahuan, arahan, atau saran terkait praktik menyusui yang benar. Informasi yang diberikan keluarga dapat memperkuat keyakinan ibu, terutama bila selaras dengan rekomendasi tenaga kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi menyusui yang melibatkan pasangan meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pentingnya ASI eksklusif dan mengurangi kecenderungan pemberian makanan tambahan dini (Esteves et al., 2025).

Namun demikian, literatur juga mencatat bahwa informasi yang keliru dari keluarga dapat menjadi hambatan serius. Studi di Indonesia menemukan bahwa kepercayaan tradisional tentang kolostrum dan pemberian makanan prelakteal masih memengaruhi keputusan menyusui pada minggu pertama kehidupan bayi. Oleh karena itu, kualitas informasi yang diberikan keluarga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan ASI eksklusif (Badanta, 2025).

4. Dukungan Penghargaan (Appraisal Support)

Dukungan penghargaan merujuk pada bentuk penguatan verbal maupun nonverbal yang membantu ibu menilai dirinya secara positif. Validasi atas usaha ibu, pujian atas konsistensi menyusui, serta pengakuan terhadap perannya sebagai ibu menyusui berkontribusi dalam meningkatkan self-efficacy menyusui (Self-efficacy & Study, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ibu yang merasa dihargai dan diyakini mampu oleh keluarganya memiliki tingkat keberlanjutan menyusui yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang sering menerima komentar negatif tentang kecukupan ASI (Ogbo et al., 2020). Penguatan positif ini berperan dalam membangun ketahanan psikologis ibu ketika menghadapi tantangan seperti puting lecet, bayi rewel, atau kekhawatiran produksi ASI.

D. Aktor Kunci dalam Dinamika Dukungan Keluarga terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif,

1. Peran Suami dalam Dukungan ASI Eksklusif

Dukungan suami memainkan peran sentral dalam keberhasilan praktik ASI eksklusif, karena pasangan secara langsung berinteraksi dengan ibu selama periode postpartum dan dapat memengaruhi keputusan serta perilaku menyusui. Hasil riset menunjukkan bahwa keterlibatan suami berkorelasi erat dengan praktik ASI eksklusif; ibu yang mendapatkan dukungan kuat dari suami memiliki

tingkat keberhasilan ASI eksklusif yang lebih tinggi dibandingkan yang kurang mendapat dukungan pasangan (Stang et al., 2021).

Keterlibatan emosional suami dapat menciptakan rasa aman dan dukungan psikologis yang kuat, yang pada akhirnya membantu ibu tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan menyusui. Selain itu, suami yang aktif mendukung melalui pembagian tugas domestik seperti membantu pekerjaan rumah dan merawat anggota keluarga lain membebaskan ibu dari beban fisik sehingga ia bisa berkonsentrasi lebih optimal pada proses menyusui. (Kurt et al., 2024). Dukungan suami yang efektif juga mencakup sikap positif terhadap menyusui di depan umum dan penolakan terhadap stigma sosial, yang dapat memfasilitasi rasa percaya diri ibu dalam praktik ASI eksklusif.

Peran suami tidak hanya bersifat emosional dan instrumental, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan dalam keluarga terkait pemberian susu formula atau alternatif lain. Suami yang memahami manfaat ASI eksklusif cenderung mendorong keputusan keluarga yang mendukung pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama, sehingga menurunkan insiden pemberian prelakteal atau susu formula dini. Hal ini menegaskan pentingnya peranan suami sebagai partner aktif dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif (Nankabirwa et al., 2022).

2. Peran Nenek atau Orang Tua Ibu dalam Dukungan ASI Eksklusif

Peran nenek, baik dari pihak ibu maupun mertua, sering memberikan dampak yang kompleks terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Sebagai sosok yang memiliki pengalaman dan sering menjadi sumber pedoman dalam keluarga, nenek sering kali menjadi sumber dukungan kuat bagi ibu menyusui. Keterlibatan mereka dapat berupa bantuan praktis dalam merawat bayi dan anggota keluarga lain, serta penyediaan pengetahuan tradisional tentang pengasuhan anak. Namun, peran ini bersifat ganda karena tradisi dan persepsi budaya yang diwariskan dapat juga menjadi hambatan (Sosseh et al., 2023).

Misalnya, dalam konteks inter-generational influence, nenek sering memegang keyakinan tradisional seperti perlunya membuang kolostrum atau memberikan makanan tambahan sebelum usia enam bulan, yang bertentangan dengan rekomendasi ASI eksklusif. Studi internasional menunjukkan bahwa meskipun nenek sering menyediakan dukungan sosial, pengetahuan mereka tentang praktik menyusui yang benar mungkin masih terbatas, sehingga berpotensi memberikan tekanan atau informasi yang kurang mendukung keberhasilan ASI eksklusif (Helena & Angelo, 2020).

Konflik generasi menjadi isu penting ketika nilai dan informasi kesehatan modern bertabrakan dengan praktik tradisional. Interaksi antara ibu dan nenek

sebagai figur pendukung dapat memicu dilema keputusan, terutama ketika nenek menyarankan praktik prelakteal berdasarkan tradisi lokal yang kurang valid secara ilmiah. Oleh karena itu, memahami dinamika budaya dan komunikasi antar generasi penting dalam merumuskan intervensi keluarga yang efektif untuk mendukung ASI eksklusif.

3. Peran Anggota Keluarga Lainnya

Selain suami dan nenek, anggota keluarga lain seperti saudara kandung, orang tua lainnya, dan kerabat dekat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi ASI eksklusif. Studi empiris menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterlibatan keluarga secara keseluruhan, termasuk saudara dan care giver lain, berkaitan positif dengan persepsi ibu terhadap dukungan yang diterimanya serta self-efficacy menyusui. Ketika pengetahuan anggota keluarga terhadap kesehatan dan nutrisi bayi meningkat, mereka cenderung memberikan dukungan praktis dan informasi yang benar, sehingga membantu ibu mempertahankan praktik ASI eksklusif lebih lama (Faraj et al., 2023).

Lingkungan rumah yang mendukung, termasuk anggota keluarga yang bersikap positif, memberikan bantuan tugas rumah tangga, dan memahami tantangan menyusui, dapat mengurangi beban emosional dan fisik ibu. Hal ini meningkatkan kemampuan ibu untuk mengatasi tantangan laktasi dini dan mempertahankan rutinitas menyusui eksklusif. Dukungan keluarga yang bersifat kolektif bukan hanya satu individu telah ditemukan berkorelasi dengan peningkatan self-efficacy ibu dalam menyusui serta keteraturan praktik ASI eksklusif (Amekpor et al., 2025).

Peran anggota keluarga lainnya juga terlihat dalam penyediaan informasi yang relevan serta advokasi terhadap praktik ASI eksklusif di lingkungan sosial yang lebih luas. Dukungan semacam ini turut membantu ibu dalam menghadapi tekanan sosial, termasuk saran dari komunitas yang mungkin kurang mendukung praktik ASI eksklusif (Shittu et al., 2024). Oleh karena itu, intervensi kesehatan yang ingin meningkatkan ASI eksklusif sebaiknya melibatkan seluruh unit keluarga sebagai partner strategis dalam promosi dan edukasi menyusui.

E. Mekanisme Psikobiologis: Bagaimana Dukungan Mempengaruhi Produksi ASI

Produksi dan pengeluaran ASI bukan hanya proses mekanis dari kelenjar payudara, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara hormon, sistem saraf, dan kondisi psikologis ibu. Dua hormon utama yang terlibat adalah prolaktin, yang merangsang sintesis ASI, dan oksitosin, yang memicu refleks *let-down* atau

pengeluaran ASI (Ni et al., 2021). Refleks ini dipicu oleh rangsangan puting dan juga dipengaruhi oleh kondisi emosional ibu; ketika ibu merasa tenang dan didukung, respon hormonal ini menjadi lebih optimal, sementara stres dapat menghambatnya. Secara fisiologis, rangsangan puting saat bayi menyusu atau saat ibu dalam keadaan rileks mampu memicu lonjakan oksitosin yang secara langsung membuka jalan keluarnya ASI dari alveoli ke kanalisasi payudara. Selain itu, oksitosin memiliki efek sekunder berupa perasaan tenang dan ikatan emosional antara ibu dan bayi, yang mendukung kelangsungan menyusui (Yukinaga & Miyamichi, 2025).

Dukungan emosional dari keluarga termasuk suami dan anggota lain memainkan peran penting dalam modulasi hormon ini. Ketika ibu menerima dukungan sosial yang kuat, tingkat stres dan kecemasan menurun, yang pada gilirannya menurunkan sekresi hormon kortisol—marker fisiologis utama stress (Ben-david et al., 2025). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi pada ibu menyusui berkorelasi dengan konsentrasi kortisol yang lebih tinggi dalam ASI, sekaligus berdampak negatif terhadap kadar prolaktin, hormone yang penting untuk sintesis ASI. Interaksi antara cortisol dan prolaktin ini menunjukkan bahwa stres kronis dapat mengurangi kelancaran produksi ASI melalui imbal balik hormonal yang kompleks (Hasiec & Misztal, 2018).

Penurunan kadar kortisol akibat dukungan emosional bukan hanya berdampak pada hormon tetapi juga pada proses fisiologis refleks *let-down*. Stres yang tinggi dapat menghambat pelepasan oksitosin karena respons stres memicu aktivasi sumbu HPA (*hypothalamic-pituitary-adrenal*), sehingga penurunan stres akibat dukungan keluarga dapat meningkatkan pelepasan oksitosin. Studi fisiologi menunjukkan bahwa respon tubuh terhadap stimulasi menyusui mencakup penurunan tekanan darah, relaksasi otot, dan peningkatan oksitosin, yang secara kolektif memperkuat refleks *let-down* sehingga ASI dapat keluar lebih efektif. Dukungan emosional, misalnya melalui kehadiran suami yang tenang dan afirmatif, membantu ibu berada dalam kondisi yang lebih kondusif untuk proses hormonal ini. (Fikri et al., 2023). Aspek psikologis seperti *self-efficacy* ibu menyusui juga dipengaruhi oleh hormonal tersebut. Ketika oksitosin dilepaskan melalui interaksi positif antara ibu dan keluarga, rasa keyakinan ibu terhadap kemampuannya untuk menyusui juga meningkat. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi psikologis ibu, termasuk stres, kecemasan, dan dukungan sosial, berhubungan erat dengan hasil laktasi seperti onset *laktogenesis II* (produksi susu yang signifikan beberapa hari setelah kelahiran) dan durasi ASI eksklusif. Stres yang tidak terkelola dapat menyebabkan keterlambatan *laktogenesis II*, persepsi ASI tidak mencukupi, dan akhirnya penghentian menyusui sebelum waktu yang direkomendasikan (Josefson, 2023).

Secara keseluruhan, mekanisme psikobiologis di balik produksi ASI mengindikasikan bahwa hormon oksitosin dan prolaktin bekerja dalam suatu lingkungan neuroendokrin yang sangat sensitif terhadap kondisi psikologis ibu. Dukungan keluarga, terutama dukungan emosional dan sosial yang kuat, berkontribusi pada penurunan hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan respon oksitosin serta prolaktin, sehingga menciptakan refleks *letdown* yang lebih efektif dan memaksimalkan produksi serta pemeliharaan ASI eksklusif.

F. Dimensi Psikososial dalam Dinamika Dukungan

1. Self-Efficacy Menyusui

Self-efficacy menyusui merujuk pada keyakinan ibu terhadap kemampuannya dalam memberikan ASI secara efektif dan berkelanjutan. Konsep ini berakar dari teori *self-efficacy* yang terkenal, yaitu keyakinan individu terhadap kapasitasnya dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yang sangat berpengaruh pada perilaku kesehatan termasuk pemberian ASI eksklusif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat *breastfeeding self-efficacy* ibu berkorelasi kuat dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif; ibu dengan tingkat keyakinan diri yang tinggi lebih mungkin meneruskan ASI eksklusif hingga usia enam bulan dibandingkan ibu dengan efikasi diri rendah (Hu, 2025).

Dukungan keluarga termasuk dukungan emosional, informasi, dan bantuan praktis telah terbukti mendukung peningkatan *self-efficacy* ibu dalam menyusui. Ketika keluarga memberikan dorongan positif dan informasi yang akurat, ibu cenderung merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan menyusui, seperti bayi yang tidak konsisten menyusu atau rasa nyeri pada puting payudara. Hasil studi menunjukkan bahwa ibu yang merasakan dukungan kuat dari keluarga memiliki tingkat efikasi diri yang lebih tinggi dan dengan demikian peluang keberhasilan ASI eksklusif meningkat secara signifikan (Ebeveyn et al., 2025).

Secara psikologis, *self-efficacy* membantu ibu mengembangkan strategi koping ketika menghadapi hambatan laktasi. Ibu dengan *breastfeeding self-efficacy* yang tinggi menunjukkan kemauan yang lebih besar untuk mencari informasi tambahan, mencoba teknik menyusui yang berbeda, dan mempertahankan rutinitas menyusui meskipun mengalami tantangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan durasi ASI eksklusif, tetapi juga menopang kesejahteraan psikologis ibu postpartum, sehingga mengurangi risiko stres dan putus asa di minggu-minggu awal setelah kelahiran.

2. Persepsi Kecukupan ASI

Selain keyakinan diri ibu, persepsi tentang kecukupan ASI menjadi faktor psikososial penting yang memengaruhi perilaku menyusui. Banyak ibu berhenti memberikan ASI eksklusif bukan karena produksi ASI benar-benar rendah, tetapi karena mereka merasakan atau percaya bahwa ASI yang mereka hasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Penelitian meta-analisis menunjukkan bahwa persepsi ASI tidak cukup secara konsisten dikaitkan dengan penurunan kemungkinan pemberian ASI eksklusif; ibu yang memiliki persepsi kekurangan ASI memiliki risiko lebih tinggi untuk memperkenalkan makanan tambahan atau susu formula dini dibandingkan ibu yang tidak memiliki persepsi tersebut (Zeng et al., 2024).

Persepsi kecukupan ASI sering dipengaruhi oleh pengalaman subjektif ibu, tekanan keluarga, serta interpretasi terhadap perilaku bayi seperti frekuensi isapan atau ekspresi bayi yang tampak lapar. Ketika keluarga, terutama anggota yang tidak memahami fisiologi menyusui, memberi saran untuk “menambahkan susu” karena bayi sering menangis atau tampak belum kenyang, hal ini dapat memperkuat persepsi negatif tentang produksi ASI. Interaksi sosial semacam ini kadang menciptakan siklus di mana ibu kehilangan kepercayaan diri dan semakin cepat memperkenalkan suplemen selain ASI.

Studi literatur juga menegaskan bahwa persepsi kecukupan ASI berkorelasi dengan *breastfeeding self-efficacy*; ibu yang memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuannya menyusui cenderung memiliki persepsi yang lebih positif tentang kecukupan ASI, dan ini berkontribusi terhadap keberlanjutan praktik ASI eksklusif. Sebaliknya, rendahnya efikasi diri sering memperkuat persepsi insufisiensi, yang telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama berhentinya ASI eksklusif sebelum usia enam bulan (Djuwitaningsih et al., 2025).

G. Dinamika Konflik dan Hambatan Dukungan dalam Pemberian ASI Eksklusif

Meskipun dukungan keluarga berperan penting dalam keberhasilan ASI eksklusif, banyak konflik dan hambatan yang sering mengintervensi proses ini. Salah satu faktor utama adalah tekanan budaya untuk memberikan makanan tambahan dini. Dalam banyak komunitas tradisional, terdapat keyakinan bahwa bayi perlu makanan selain ASI, seperti air, madu, atau makanan fermentasi sebelum usia enam bulan. Ketergantungan pada praktik budaya ini sering kali berasal dari pengalaman generasi sebelumnya dan sulit diubah hanya dengan edukasi singkat. Studi di Asia Tenggara menunjukkan bahwa meskipun ibu memiliki pengetahuan yang baik tentang manfaat ASI eksklusif, tekanan sosial budaya dari keluarga besar untuk

memberikan makanan tambahan tetap menjadi tantangan besar dalam mempertahankan ASI eksklusif (C. Study & Herman, 2025).

Konflik lain yang sering terjadi adalah ketegangan antara peran ibu sebagai pekerja dan tuntutan keluarga untuk menyusui. Kembali bekerja, terutama tanpa dukungan cuti yang memadai atau fasilitas menyusui di tempat kerja, sering memaksa ibu menghentikan ASI eksklusif lebih awal daripada yang direkomendasikan. Temuan riset longitudinal menunjukkan bahwa ibu yang tidak mendapatkan cuti melahirkan yang layak atau akses ruang menyusui di tempat kerja memiliki tingkat pemberian ASI eksklusif yang jauh lebih rendah dibanding ibu yang mendapatkan dukungan kebijakan kerja yang ramah menyusui (E-issn et al., 2025).

Selain itu, kurangnya edukasi keluarga tentang praktik menyusui yang tepat juga dapat menjadi hambatan signifikan. Keluarga yang kurang memahami mekanisme dan manfaat ASI eksklusif dapat secara tidak sadar memberikan tekanan untuk mempercepat pemberian makanan tambahan, atau menginterpretasikan perilaku bayi yang normal sebagai tanda ASI tidak cukup. Penelitian terbaru dari konteks komunitas menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga yang rendah tentang nutrisi bayi dan fisiologi laktasi berkorelasi dengan rendahnya dukungan keluarga terhadap praktik ASI eksklusif, terutama ketika keluarga besar ikut campur dalam keputusan menyusui (Abdalla et al., 2024).

Selain faktor budaya dan edukasi, paparan promosi susu formula secara agresif oleh industri makanan bayi sering menciptakan persepsi bahwa formula merupakan alternatif yang setara atau bahkan “lebih baik” daripada ASI. Banyak ibu dan keluarga menghadapi iklan bahan komersial ini di media sosial, televisi, dan bahkan di fasilitas kesehatan. Penelitian global menunjukkan bahwa eksposur terhadap iklan formula berkaitan dengan tingkat pemberian formula yang lebih tinggi dan penurunan durasi ASI eksklusif, meskipun bukti medis secara konsisten menegaskan bahwa ASI eksklusif hingga enam bulan menawarkan manfaat kesehatan yang tidak tertandingi (Wang et al., 2024).

Hambatan-hambatan ini perlu dilihat dalam konteks intervensi sistemik yang lebih luas. Kebijakan rumah sakit, seperti penerapan sepenuhnya prinsip *Baby-Friendly Hospital Initiative* (BFHI), memiliki peran penting dalam mengatasi konflik ini melalui dukungan menyusui di fase awal postpartum. Fasilitas kesehatan yang menerapkan langkah-langkah BFHI, termasuk inisiasi menyusui dini dan pelatihan staf medis tentang konseling laktasi, terbukti meningkatkan angka ASI eksklusif.⁶

Intervensi lain yang berperan dalam menekan hambatan budaya dan edukasi adalah edukasi antenatal yang mencakup seluruh keluarga, bukan sekadar ibu. Program edukasi yang melibatkan pasangan dan anggota keluarga besar terbukti

memperbaiki pengetahuan tentang manfaat ASI eksklusif serta mengurangi tekanan untuk memberikan makanan tambahan terlalu dini.

Selain itu, konseling laktasi berbasis keluarga selama kunjungan postnatal intensif membantu ibu dan keluarga memahami tanda-tanda ASI yang cukup, teknik menyusui yang benar, dan bagaimana mengatasi tantangan laktasi dini. Studi intervensi menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan konseling laktasi ditambah dukungan keluarga memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan ASI eksklusif dibanding mereka yang hanya mendapatkan konseling individual tanpa keterlibatan keluarga.

H. Faktor Sosial Budaya dan Konteks Lokal dalam Pemberian ASI Eksklusif

Dalam banyak komunitas, kepercayaan tentang kolostrum memainkan peran penting dalam praktik awal menyusui. Meskipun kolostrum merupakan cairan pertama yang kaya zat antiinfeksi dan nutrisi esensial, beberapa budaya tradisional memandangnya sebagai “susu kotor” yang harus dibuang sebelum memberikan ASI “yang sebenarnya”. Penelitian kualitatif di berbagai wilayah Asia dan Afrika menunjukkan bahwa mitos negatif terhadap kolostrum masih berkontribusi pada penundaan menyusui pertama kali dan praktik prelakteal feeding, terutama di komunitas rural dimana tradisi turun-temurun kuat mengakar (Aslam et al., 2024).

Selain itu, pantangan makanan bagi ibu menyusui merupakan aspek budaya yang sering memengaruhi kesehatan ibu dan produksi ASI. Banyak budaya memiliki daftar makanan yang dianggap “haram” atau “membahayakan ASI”, misalnya pantangan terhadap makanan pedas, dingin, atau lauk tertentu yang diyakini dapat menyebabkan “ASI kurang berkualitas”. Penelitian etnografi kesehatan di Asia Tenggara menemukan bahwa kepatuhan terhadap pantangan makanan ini dapat berdampak pada asupan nutrisi ibu, yang secara tidak langsung memengaruhi kuantitas dan kualitas ASI (Smith et al., 2022).

Praktik prelakteal feeding memberi bayi cairan selain ASI dalam hari pertama setelah lahir masih umum di sejumlah komunitas, walaupun bukti medis menganjurkan ASI eksklusif sejak lahir. Studi lintas negara mengungkapkan bahwa prelakteal feeding sering dipraktikkan karena keyakinan bahwa bayi perlu “pembersih perut” atau “energi tambahan”. Temuan survei global menunjukkan bahwa prelakteal feeding lebih sering terjadi di setting negara berkembang ketimbang negara maju, dan prevalensinya lebih tinggi di area rural dibandingkan urban, mencerminkan perbedaan dalam pengetahuan kesehatan ibu dan akses informasi edukatif (Sako, 2022).

Budaya patriarki juga menjadi faktor penting dalam keputusan menyusui. Dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, ibu sering kali memiliki kontrol terbatas atas pilihan gizi dan perawatan kesehatannya, termasuk durasi dan intensitas menyusui. Studi dari Afrika timur dan Asia menunjukkan bahwa ketika suami atau kepala keluarga memiliki pandangan yang kuat terhadap pemberian susu formula atau praktik prelakteal, ibu sering merasa tekanan sosial untuk menyesuaikan praktik menyusui sesuai kehendak keluarga besar. Dalam konteks berbeda, di beberapa negara maju dengan budaya gender egaliter, keputusan menyusui lebih banyak dilakukan secara kolektif antara ibu dan pasangan, dan dukungan institusional juga lebih terstruktur (A. Q. Study, 2023).

Perbandingan negara berkembang dengan negara maju mengungkapkan bahwa meskipun tantangan budaya seperti kepercayaan pada kolostrum atau pantangan makanan masih dijumpai di kedua setting, prevalensinya jauh lebih tinggi di negara berkembang. Hal ini berkaitan dengan perbedaan tingkat pendidikan kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta paparan terhadap program edukasi menyusui. Pedoman WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa program komunikasi risiko dan edukasi antenatal yang komprehensif dapat mengurangi dampak budaya negatif terhadap praktik ASI eksklusif di negara berkembang (Sosseh et al., 2023).

Selain itu, perbedaan urban dengan rural juga tampak jelas. Di daerah urban, ibu cenderung memiliki akses lebih mudah terhadap informasi kesehatan melalui fasilitas kesehatan, media sosial, dan kelompok dukungan masyarakat, sehingga mitos tradisional cenderung tereduksi. Sebaliknya, di komunitas rural, faktor budaya lokal dan norma sosial sering kali tetap menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan menyusui. Studi komparatif memperlihatkan bahwa prevalensi prelakteal feeding dan resistensi budaya terhadap kolostrum lebih tinggi pada populasi rural dibanding urban.

I. Intervensi Berbasis Keluarga untuk Meningkatkan ASI Eksklusif

Intervensi berbasis keluarga fokus pada keterlibatan suami, pasangan, dan anggota keluarga lain dalam proses edukasi dan dukungan menyusui, dengan tujuan memperkuat lingkungan sosial ibu sehingga praktik ASI eksklusif lebih mungkin dipertahankan. Organisasi kesehatan global seperti World Health Organization dan UNICEF menekankan pendekatan *family-centered* dalam strategi peningkatan ASI eksklusif, termasuk melalui integrasi intervensi keluarga ke dalam *Baby Friendly Hospital Initiative* (BFHI). Studi evaluasi implementasi BFHI

menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan pendekatan keluarga secara konsisten meningkatkan dukungan laktasi prenatal dan postnatal, serta angka pemberian ASI eksklusif hingga enam bulan (Zakarija-grkovi et al., 2018).

1. Edukasi Antenatal Berbasis Pasangan

Edukasi menyusui yang melibatkan pasangan sejak masa antenatal telah terbukti lebih efektif dibanding edukasi yang hanya ditujukan kepada ibu saja. Penelitian kuantitatif dalam konteks low- and middle-income countries menemukan bahwa pasangan yang terlibat aktif dalam sesi edukasi antenatal menunjukkan peningkatan pemahaman tentang manfaat ASI eksklusif, yang kemudian berkontribusi pada keputusan keluarga untuk mendukung ibu dalam praktik menyusui eksklusif. Edukasi berbasis pasangan juga dapat memodifikasi norma keluarga terhadap prelakteal feeding dan pemberian susu formula dini (Abageda, 2024).

2. Konseling Laktasi Family-Centered

Konseling laktasi yang bersifat *family-centered* tidak hanya memberikan informasi teknis kepada ibu, tetapi mengajak anggota keluarga seperti suami dan orang tua untuk memahami teknik menyusui, tanda-tanda ASI yang cukup, serta cara membantu ibu menghadapi tantangan awal laktasi. Sebuah uji coba terkontrol random menunjukkan bahwa ibu dan keluarganya yang mendapatkan konseling laktasi bersama memiliki skor *breastfeeding self-efficacy* yang lebih tinggi dan durasi ASI eksklusif yang lebih panjang dibanding kelompok kontrol yang hanya menerima konseling individual tanpa partisipasi keluarga (Arezi et al., 2024).

3. Home Visit Berbasis Keluarga

Kunjungan rumah (*home visit*) oleh tenaga kesehatan atau konselor laktasi yang melibatkan seluruh keluarga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hambatan menyusui secara langsung di lingkungan rumah dan mengatasi mitos budaya yang mungkin menghambat ASI eksklusif. Studi kohort di komunitas menunjukkan bahwa home visit dengan pendekatan keluarga secara signifikan meningkatkan keberlanjutan ASI eksklusif pada bulan-bulan pertama postpartum, terutama di daerah rural yang akses layanan kesehatannya terbatas (Badanta, 2025).

4. Father-Inclusive Breastfeeding Education

Intervensi edukasi yang secara khusus menyasar peran ayah (*father-inclusive*) telah menunjukkan hasil positif dalam mendukung ibu menyusui. Pendekatan ini biasanya melibatkan sesi edukasi formal tentang peran suami dalam mendukung menyusui, termasuk teknik dukungan emosional, pengelolaan tugas domestik, dan cara berkomunikasi yang efektif. Meta-analisis terbaru

menyimpulkan bahwa edukasi menyusui yang melibatkan ayah secara signifikan meningkatkan durasi ASI eksklusif dan menurunkan tingkat penghentian dini ASI dibanding pendekatan edukasi standar yang hanya fokus pada ibu (Louie, 2025).

Ketika digabungkan, intervensi-intervensi ini menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu, tetapi juga memodifikasi lingkungan sosial melalui peningkatan dukungan keluarga secara sistemik. Pendekatan *family-centered* ini kemudian menjadi katalis penting dalam implementasi kebijakan kesehatan maternal yang berkelanjutan, terutama di wilayah dengan hambatan budaya yang kuat terhadap praktik ASI eksklusif.

J. Implikasi untuk Praktik Keperawatan Maternitas

Pada keperawatan maternitas, perawat bukan sekadar caregiver, tetapi fasilitator utama dukungan keluarga dalam meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Perawat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan ibu dan keluarganya, serta memandu diskusi keluarga untuk menguatkan dukungan terhadap ibu menyusui. Intervensi yang dipimpin perawat, seperti *theory-based nursing interventions*, telah terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan ASI eksklusif, terutama ketika pendekatannya mencakup dukungan emosional, edukasi dan tindak lanjut teknis menyusui. Studi intervensi menunjukkan bahwa program keperawatan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan jumlah ibu yang eksklusif menyusui setelah masa puerperium dibanding kelompok kontrol biasa.

Pengkajian dukungan keluarga harus menjadi bagian integral dari pengkajian keperawatan antenatal. Keperawatan yang efektif tidak hanya mengevaluasi kondisi fisik ibu, tetapi juga mengidentifikasi tingkat dukungan sosial yang ibu terima dari pasangan dan keluarga. Hal ini karena motivasi menyusui ibu sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga sejak hamil trimester III, termasuk hubungan keluarga dengan motivasi menyusui ibu. Penelitian korelasional terbaru menunjukkan hubungan signifikan antara dukungan keluarga dan motivasi menyusui pada ibu hamil trimester akhir. Perawat dapat menggunakan hasil pengkajian ini untuk merancang strategi edukasi yang lebih spesifik bagi keluarga inti sebelum ibu melahirkan.

Selama masa postpartum, perawat perlu mengintegrasikan intervensi berbasis keluarga ke dalam asuhan rutin. Ini bisa berupa konseling keluarga terpadu yang melibatkan suami/anggota keluarga lain untuk belajar teknik menyusui, mengenali tanda-tanda ASI cukup, serta memecahkan hambatan praktis seperti posisi menyusui dan pelekatan bayi. Intervensi yang diterapkan perawat tidak hanya

berfokus pada ibu, tetapi juga mendorong keluarga dekat untuk ikut serta dalam proses pendidikan dan pemberdayaan, sehingga pengalaman menyusui menjadi proses kolektif yang lebih kuat.

Penting pula bagi perawat untuk memberikan edukasi yang sistematis tentang mitos menyusui kepada ibu dan keluarga. Mitos seperti “ASI kurang bila bayi sering menangis” atau trauma pengalaman generasi sebelumnya dapat melemahkan kepercayaan ibu pada produksi ASI. Perawat harus mampu menyampaikan informasi yang akurat tentang fisiologi ASI, kolostrum, dan tanda ASI cukup secara jelas. Edukasi ini membantu meluruskan salah kaprah yang sering diwariskan secara lintas generasi, serta memperkuat keyakinan keluarga sebagai *support system* utama untuk ibu menyusui.

Ketika perawat menggabungkan pendekatan edukatif dengan keterlibatan keluarga—baik melalui diskusi antenatal, sesi konseling postpartum, maupun kunjungan rumah—praktik keperawatan tidak hanya meningkatkan keterampilan ibu, tetapi juga memperkuat jaringan dukungan sosial yang kritical bagi keberhasilan ASI eksklusif. Hal ini sesuai dengan bukti bahwa intervensi keperawatan seperti home visits, follow-up telepon, dan *antenatal education* adalah sebagian dari praktik dukungan menyusui yang paling sering dan efektif dilakukan oleh perawat dan bidan

Referensi

- Abageda, M. (2024). *Effect of Male Partner - Targeted Breastfeeding Education and Support Interventions on Optimal Breastfeeding Practices in Central Ethiopia: A Cluster Randomized Controlled Trial*. <https://doi.org/10.1111/mcn.13764>
- Abdalla, M., Zein, M. M., Sherif, A., Essam, B., & Mahmoud, H. (2024). *Nutrition and diet myths , knowledge and practice during pregnancy and lactation among a sample of Egyptian pregnant women : a cross-sectional study*. 3, 1–9.
- Amekpor, F., Osei-mensah, C., Adjieteh, N. A., Dok-yen, E. N., & Salamu, M. B. (2025). *Exploring Psycho-Social Factors In fl uencing Exclusive Breastfeeding: Lived Experiences of First Time Mothers at Salaga Municipal Hospital , Savannah Region in Ghana*. 70(January), 1–6. <https://doi.org/10.3389/ijph.2025.1607542>
- Andres, S. F., Scottoline, B., & Good, M. (2023). Seminars in Perinatology Shaping infant development from the inside out : Bioactive factors in human milk. *Seminars in Perinatology*, 47(1), 151690. <https://doi.org/10.1016/j.semperi.2022.151690>
- Arezi, E., Maleki, A., & Jafari, E. (2024). Heliyon Investigating the influence of family-oriented counselling on breastfeeding continuity in mothers experiencing distractions: A randomized controlled trial. *Heliyon*, 10(9), e30687. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30687>
- Aslam, M. Z., Johnson, J., & Baig, M. (2024). *No Title*. 1–17.
- Badanta, B. (2025). *Cultural beliefs and practices behaviors : a Scoping Review about women ' s breastfeeding The World Alliance for Breastfeeding Action , led by the United Nations Children ' s Fund*. 1–29.
- Ben-david, H., Miller, K. J., & Miller, K. J. (2025). Resilience mediates the relationship between social support and anxiety in postpartum mothers. *Clinical Psychologist*, 29(2), 119–130. <https://doi.org/10.1080/13284207.2025.2462842>
- Brockway, M. (2024). *The role of antibiotic exposure and the effects of breastmilk and human milk feeding on the developing infant gut microbiome*. June, 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1408246>
- Cristóbal-cañadas, D., Parrón-carrillo, R., & Parrón-carreño, T. (2025). *Exosomes in Breast Milk: Their Impact on the Intestinal Microbiota of the Newborn and Therapeutic Perspectives for High-Risk Neonates*. 1–11.
- Davidson, E. L., & Ollerton, R. L. (2020). Partner behaviours improving breastfeeding outcomes: An integrative review. *Women and Birth*, 33(1), e15–e23. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2019.05.010>

- Djuwitaningsih, S., Deswani, D., Lestari, A. D., Sulastri, T., Riasmini, M., & Pangastuti, T. E. (2025). *Maternal self-efficacy: perspectives on formula milk and insufficient breast milk in Koja District Health Center, Indonesia*. 13, 127–131. <https://doi.org/10.4081/hls.2025>
- E-issn, I., Annan, E., Ani-amponsah, M., & Yeboah, E. (2025). *Has been issued since 2014*. 12(May), 158–166. <https://doi.org/10.13187/jare.2025.2.158>
- Ebeveyn, A., Doğum, Ö., Sosyal, S., Algısı, D., & ilişki, A. (2025). *The Relationship Between Mothers ' Parenting Self-efficacy and Perception of Postpartum Social Support: A Descriptive Correlational Study*. 5(3), 240–249. <https://doi.org/10.4274/MNM.2025.24274>
- Esmaeel, S. E., Alobaidan, R. K., Alenezi, D. F. K., Alanezi, H. H. G., Alruwili, L. H. A., Alsel, B. A., Hamid, O. A., Hassan, S., Hashim, A., Bayomy, H. E., & Fawzy, M. S. (2025). *Barriers to breastfeeding among mothers in the northern border region of Saudi Arabia: A cross-sectional study*. 11(6), 749–760.
- Esteves, G., Sandow, A., Segbedji, C., Adoley, A., Rafael, A., Escamilla, P., Aryeetey, R., & Fiedler, A. H. (2025). *Support or Interference: Relational Influences on Mother ' s Exclusive Breastfeeding Practices in Ghana*. 1–13. <https://doi.org/10.1111/mcn.70080>
- Fadjriah, R. N., Krisnasari, S., & Gugu, Y. (2021). *Relationship between Family Social Support and Exclusive Breastfeeding Behavior at Talise Health Center, Indonesia*. 9, 312–316.
- Faraj, K., Bouchefra, S., El, S., & Elbaraka, Y. (2023). Early breastfeeding initiation : Exploring rates and determinants among postpartum women in Eastern Morocco. *Scientific African*, 21(September), e01883. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01883>
- Fikri, L. H., As, S., Hatta, M., Syamsuddin, S., Prasetya, H., & Maddeppungeng, M. (2023). *Mother ' s attitude to breastfeeding and its effect on oxytocin levels in mothers: a review article*. 12(2), 2330–2337. <https://doi.org/10.15562/bmj.v12i2.4574>
- Gómez, L., Verd, S., Cardo, E., Servera, M., Filgueira, A., Ponce-taylor, J., & Mulet, M. (2021). *Perinatal psychological interventions to promote breastfeeding: a narrative review*. 1–16.
- Hasić, M., & Misztal, T. (2018). *Review Article Adaptive Modifications of Maternal Hypothalamic-Pituitary- Adrenal Axis Activity during Lactation and Salsolinol as a New Player in this Phenomenon*. 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/3786038>
- Helena, B., & Angelo, D. B. (2020). *Knowledge, attitudes and practices of grandmothers related to breastfeeding: a meta-synthesis*. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3097.3214>

- Hossain, S., & Mahrshahi, S. (2022). *Exclusive Breastfeeding and Childhood Morbidity: A Narrative Review*.
- Hu, L. (2025). *Association Between Family Support and Breastfeeding Efficacy in a Cross- - Sectional Study*. <https://doi.org/10.1002/nop2.70210>
- Josefson, C. C. (2023). *Chronic Stress Decreases Lactation Performance*. 3, 557–568.
- Journal, B., Addy, T., Nabors, L., King, K., Vidourek, R., Hixon, D. P., & Sanyaolu, O. (2025). *The role of support on breastfeeding exclusivity and duration among African migrant mothers in the United States*. 9.
- Journal, P. N. (2026). *Exclusive breastfeeding duration and its influence on preventing childhood stunting*. 12, 11–16.
- Kamikawa, A., & Seko, J. (2020). *Physiological and pharmacological evaluation of oxytocin-induced milk ejection in mice*. 69(September 2019), 345–353. <https://doi.org/10.1538/expanim.19-0126>
- Kerketta, S., Sethy, P., & Swain, S. (2026). *Breastfeeding and risk of hospitalisation in children under five years — a systematic review and meta-analysis*. February, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fped.2026.1748152>
- Kurt, H., Merve, A., Demirsoz, M., & Kucukoglu, S. (2024). Development and psychometric evaluation of the paternal support scale of breastfeeding ☆. *Journal of Pediatric Nursing*, 75, 149–157. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.12.004>
- Louie, T. H. S. C. J. C. Y. (2025). Impact of Paternal Breastfeeding Interventions on Exclusive Breastfeeding Rates and Attitudes of Fathers Towards Breastfeeding: A Systematic Review. *Current Nutrition Reports*. <https://doi.org/10.1007/s13668-024-00603-2>
- Lyons, G. C., Kay, M. C., Duke, N. N., Bian, A., Schildcrout, J. S., Perrin, E. M., Rothman, R. L., Yin, H. S., Sanders, L. M., Flower, K. B., Delamater, A. M., & Heerman, W. J. (2023). Social Support and Breastfeeding Outcomes Among a Racially and Ethnically Diverse Population. *American Journal of Preventive Medicine*, 64(3), 352–360. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.10.002>
- Macura, B., Kiecka, A., & Szczepanik, M. (2026). *Novel immunomodulatory factors in human milk: implications for infant immunity*. 1–19.
- Margaretha, T., Manshanden, N., Hendrix, Y. M. G. A., Velzel, J., Pampus, M. G. Van, Margaretha, T., Manshanden, N., & Hendrix, Y. M. G. A. (2025). *Exploring the relationship between breastfeeding and psychological well-being after traumatic childbirth: a secondary analysis of the PERCEIVE study data*. 8942. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2025.2588223>
- Matsunaga, M., Kikusui, T., Mogi, K., Nagasawa, M., Ooyama, R., & Myowa, M. (2026). *Breastfeeding dynamically changes endogenous oxytocin levels and*

emotion recognition in mothers. May.
<https://doi.org/10.1098/rsbl.2020.0139/439038/rsbl.2020.0139.pdf>

- Meek, J. Y., & Noble, L. (2022). *Policy Statement: Breastfeeding and the Use of Human Milk.* 150(1), 1–15.
- Meher, C. (2024). *Cultural Influences of Early Food Introduction on Exclusive Breastfeeding Rates in the Nias Islands , Cultural Influences of Early Food Introduction on Exclusive Breastfeeding Rates in the Nias Islands , Indonesia.* 2390. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S478448>
- Nankabirwa, V., Flaherman, V. J., Co, R., Ginsburg, A. S., & Sa, A. B. De. (2022). *Early infant growth impairment in the setting of frequent exclusive breast feeding: considering therapeutic options.* 7–8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-010118>
- Naufal, F. F., Indita, H. R., & Muniroh, L. (2023). *The Relationship between Maternal Knowledge and Family Support with Exclusive Breastfeeding Hubungan Pengetahuan Ibu dan Dukungan Keluarga dengan Pemberian ASI.* 7(3), 442–448. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i3.2023.442>
- Ni, Y., Chen, Q., Cai, J., Xiao, L., & Zhang, J. (2021). Molecular and Cellular Endocrinology Three lactation-related hormones: Regulation of hypothalamus-pituitary axis and function on lactation. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 520(November 2020), 111084. <https://doi.org/10.1016/j.mce.2020.111084>
- Ogbo, F. A., Akombi, B. J., Ahmed, K. Y., Rwabilimbo, A. G., Ogbo, A. O., Uwaibi, N. E., & Ezech, O. K. (2020). *Breastfeeding in the Community — How Can Partners / Fathers Help ? A Systematic Review.*
- Osman, S., Ahmed, M., Ibrahim, R., Abdelgader, A., Abdelgader, M., Ibrahim, H., Hamid, A., Mansor, D., Abdalla, M., Ali, A., Ali, S., & Mohamed, M. (2023). Exclusive breastfeeding : Impact on infant health. *Clinical Nutrition Open Science*, 51, 44–51. <https://doi.org/10.1016/j.nutos.2023.08.003>
- Özcan, E. (2025). *Investigation of factors associated with mindful breastfeeding in breastfeeding women through structural equation modeling.*
- Perrella, S., Gridneva, Z., Lai, C. T., Stinson, L., George, A., Bilston-john, S., & Geddes, D. (2021). Seminars in Perinatology Human milk composition promotes optimal infant growth , development and health. *Seminars in Perinatology*, 45(2), 151380. <https://doi.org/10.1016/j.semperi.2020.151380>
- Priscilla, V., & Afiyanti, Y. (2021). *A Qualitative Systematic Review of Family Support for a Successful Breastfeeding Experience among Adolescent Mothers.* 9, 775–783.
- Pujiastuti, N., & Winarni, S. (2025). *Back Acupressure , Baby Positioning and Latching*

, and Breast Massage Increase Breast Milk Production : A Controlled Clinical Trial. 59(77).

- Sabilla, M., Bahri, S., Ariasih, R. A., Khairunisa, N., Ayu, R., & Sartika, D. (2025). *Social support , breastfeeding self-efficacy , and duration of exclusive breastfeeding in Indonesia : A partial least square analysis*. 101–107.
- Sako, S. (2022). Heliyon Prelacteal feeding practice and associated factors among mothers of children less than two years of age in Ethiopia : A multilevel analysis. *Heliyon*, 8(4), e09339. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09339>
- Self-efficacy, B., & Study, S. R. (2023). *AUTOEFICACIA EN LA LACTANCIA MATERNA Y APOYO SOCIAL : UN*.
- Shittu, F., King, C., Rautiainen, S., Iuliano, A., Bakare, A., Colbourn, T., Bakare, D., Salako, J., Hamish, R., Falade, A. G., Burgess, R. A., Shittu, F., King, C., Rautiainen, S., Iuliano, A., Bakare, A. A., Colbourn, T., Bakare, D., Salako, J., ... Burgess, R. A. (2024). Exploring the feeding practices of mothers of under-five children and how household members influence exclusive breastfeeding in Jigawa State , Nigeria – A qualitative study. *Global Public Health*, 1692, 1–12. <https://doi.org/10.1080/17441692.2024.2426135>
- Smith, T. J., Tan, X., Arnold, C. D., & Hess, S. Y. (2022). *Traditional prenatal and postpartum food restrictions among women in northern Lao PDR*. July 2021, 1–14. <https://doi.org/10.1111/mcn.13273>
- Sosseh, S. A. L., Barrow, A., & Lu, Z. J. (2023). Cultural beliefs , attitudes and perceptions of lactating mothers on exclusive breastfeeding in The Gambia : an ethnographic study. *BMC Women's Health*, 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02163-z>
- Stang, S., Abdullah, T., & Marwang, S. (2021). *The Influence of Collaborative Model between the Role of Husbands and Healthcare Workers on Mother ' s Behavior in Giving Exclusive Breastfeeding*. 9, 794–797.
- Study, A. Q. (2023). *Barriers to Exclusive Breastfeeding for Mothers in Tswelopele Municipality, Free State Province , South Africa* : 1–19.
- Study, C., & Herman, H. (2025). *Evaluating the autonomy of mother in infant feeding decision : A case study*. 11, 126–130.
- Tomori, C. (2023). *Global lessons for strengthening breastfeeding as a key pillar of food security*. August, 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1256390>
- Wang, Y., Zhang, H., Chang, S., Yang, G., Wang, W., Lv, X., Lin, Z., Zhang, S., Xiao, A. Y., Narayan, A., & Tang, K. (2024). The characteristics of formula milk marketing on health system : a qualitative study from Beijing and Jinan in China. *BMC Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20298-y>
- Wati, L. R., Sargowo, D., Nurseta, T., Zuhriyah, L., & Rahardjo, B. (2023). *Correlations*

Among Maternal and Infant Factors , Lead Exposure , and Serum Prolactin Levels During Lactation : A Cross-sectional Study in Indonesia. 422–430.

- Weiler, H. A., Cooper, M., Bertinato, J., Hopperton, K. E., Mccrea, J., Rana, H., Bonvalot, Y., Loukine, L., Nicholson, C., & Brule, S. (2025). Adherence to Introduction of Iron-Rich Solid Foods Recommendations for Infants : An Analysis of Canadian Community Health Survey Data Using Cycles 2015 – 2018. *The Journal of Nutrition*, 155(5), 1485–1497. <https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2024.12.026>
- Yang, C., & Szeto, I. M. (2023). *Functional proteins in breast milk and their correlation with the development of the infant gut microbiota : a study of mother-infant pairs.* September, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1239501>
- Yukinaga, H., & Miyamichi, K. (2025). Oxytocin and neuroscience of lactation : Insights from the molecular genetic approach. *Neuroscience Research*, 216(January 2024), 104873. <https://doi.org/10.1016/j.neures.2025.01.002>
- Zakarija-grkovi, I., Boban, M., Anamarija, Ć., & Burmaz, T. (2018). *Compliance With WHO / UNICEF BFHI Standards in Croatia After Implementation of the BFHI.* <https://doi.org/10.1177/0890334417703367>
- Zeng, J., Zheng, Q., Wang, Q., Liu, G., Liu, X., Lin, H., & Guo, B. (2024). *Father support breastfeeding self-efficacy positively affects exclusive breastfeeding at 6 weeks postpartum and its influencing factors in Southeast China : a multi-centre , cross- sectional study.* 1–12.



CHAPTER 7



EVALUASI KEBERHASILAN DUKUNGAN MENYUSUI PADA IBU POSTPARTUM

Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Masa postpartum merupakan waktu yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemberian ASI. Pada fase ini, ibu mengalami proses adaptasi fisiologis dan psikologis yang dapat memengaruhi proses laktasi. Dukungan menyusui yang baik pada periode ini sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pemberian ASI eksklusif. Keberhasilan dan keberlanjutan pemberian ASI telah terbukti signifikan membantu penurunan angka morbiditas dan mortalitas bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu melalui mekanisme protektif terhadap infeksi, perdarahan postpartum, dan resiko terjadinya penyakit kronis di kemudian hari (Victora et al., 2016; Meek et al., 2022).

Organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF menekankan pentingnya pelaksanaan IMD dalam satu jam pertama kehidupan serta pemberian ASI eksklusif selama enam bulan sebagai indikator utama keberhasilan praktik menyusui. Hal ini merupakan standar terbaik nutrisi bagi bayi (UNICEF, 2022; WHO, 2023). Implementasi praktik ini juga menjadi bagian dari strategi global dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak.

Namun, keberhasilan menyusui dipengaruhi oleh berbagai tantangan. Faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu, dukungan keluarga yang terbatas terutama dari pasangan dan keluarga, adanya permasalahan seperti puting lecet atau produksi ASI yang tidak cukup, serta kurang optimalnya peran dari tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan konseling, menjadi hambatan utama dalam praktik menyusui. Selain itu, pengaruh sosial budaya dan mitos tentang pemberian ASI juga sangat memengaruhi keputusan ibu dalam menyusui.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap dukungan menyusui merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan maternitas. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir yaitu keberhasilan pemberian ASI eksklusif, tetapi juga mencakup proses, kualitas dukungan, serta faktor yang mempengaruhi keberlanjutan menyusui. Organisasi global seperti WHO dan UNICEF melalui program *Baby-*

Friendly Hospital Initiative (BFHI) menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi praktik menyusui harus dilakukan secara sistematis menggunakan indikator yang terukur dan berbasis evidence. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan menilai keberhasilan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan klinis dan pengembangan intervensi keperawatan.

B. Konsep Dukungan Menyusui pada Ibu Postpartum

1. Definisi Dukungan Menyusui

Dukungan menyusui merupakan berbagai macam bantuan yang diberikan kepada ibu postpartum untuk membantu proses menyusui baik secara emosional, informasional, maupun praktis. Dukungan menyusui menjadi elemen penting dalam keberhasilan praktik menyusui pada ibu postpartum. Dukungan ini dapat berasal dari tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan sosial lainnya. Dukungan menyusui menjadi bagian dari teori dukungan sosial (*social support theory*), yang berfokus pada interaksi sosial yang positif sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis individu, termasuk dalam konteks praktik menyusui (Stein Elger et al., 2025).

Dalam praktiknya, dukungan menyusui dapat berasal dari berbagai sumber, baik formal seperti tenaga kesehatan maupun informal seperti keluarga, pasangan dan lingkungan sosial. Dukungan ini terbukti memiliki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, karena mampu meningkatkan kepercayaan diri ibu (*breastfeeding self-efficacy*), mengurangi stress ibu, serta membantu ibu dalam mengatasi berbagai hambatan selama masa periode postpartum. Dukungan menyusui dikategorikan menjadi empat jenis utama, yaitu dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penghargaan (*appraisal support*) (Ulya, 2023; Maleki & Mirzaei, 2025).

2. Jenis Dukungan Menyusui

a. Dukungan emosional

Dukungan emosional yang diberikan kepada ibu selama proses menyusui meliputi ekspresi empati, perhatian, kasih sayang, serta dorongan psikologis. Dukungan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kenyamanan emosional dan mengurangi kecemasan ibu, yang secara langsung dapat mempengaruhi hormon laktasi seperti oksitosin. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dukungan emosional dari pasangan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan ASI eksklusif dibandingkan jenis dukungan lainnya. Selain itu, ibu yang mendapatkan dukungan emosional yang baik cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk

mempertahankan keberlanjutan proses menyusui, karena merasa dihargai, dipahami, dan tidak menghadapi proses menyusui secara sendirian (Priscilla et al., 2021; Carin et al., 2025).

b. Dukungan informasional

Dukungan informasional dapat berupa pemberian edukasi, informasi, dan bimbingan tentang teknik menyusui yang benar, manfaat ASI, serta cara mengatasi masalah dalam menyusui. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan melalui edukasi antenatal maupun postnatal. Berbagai studi menjelaskan bahwa ibu yang memperoleh edukasi menyusui secara memadai cenderung lebih siap memulai dan mempertahankan praktik ASI eksklusif, karena membantu ibu memahami praktik yang benar serta mengurangi kesalahpahaman tentang menyusui (Maleki & Mirzaei, 2025). Selain itu, dukungan informasional juga berperan dalam meningkatkan kemampuan ibu dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan, sehingga memperkuat komitmen ibu dalam memberikan ASI eksklusif (Gao et al., 2026).

c. Dukungan instrumental

Dukungan instrumental Adalah bentuk bantuan nyata atau praktis yang diberikan kepada ibu, misalnya membantu pekerjaan rumah tangga, menyediakan asupan nutrisi yang cukup, serta membantu ibu dalam proses menyusui maupun perawatan bayi baru lahir. Walaupun dukungan ini berperan penting dalam mengurangi beban fisik ibu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dukungan instrumental terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak selalu signifikan jika tidak disertai dengan dukungan emosional yang kuat (Carin et al., 2025). Meski demikian, dukungan instrumental tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan proses menyusui jangka panjang, terutama pada ibu bekerja atau ibu yang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif. Keberhasilan ASI eksklusif pada ibu bekerja tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi dipengaruhi juga oleh dukungan dan bantuan dari keluarga atau pengasuh dalam merawat bayi. Dukungan pengasuh menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja, karena durasi cuti melahirkan yang umumnya lebih singkat dibandingkan dengan periode yang direkomendasikan untuk pemberian ASI eksklusif (6 bulan). Saat ibu kembali bekerja, pengasuh memiliki peran besar penting dalam memastikan bayi tetap mendapatkan ASI, terutama melalui pemberian ASI perah (Ulya, 2023).

d. Dukungan penghargaan (appraisal)

Dukungan penghargaan dapat berupa pemberian umpan balik yang positif, penguatan, serta validasi terhadap usaha ibu dalam proses menyusui. Jenis dukungan ini berperan penting dalam meningkatkan rasa percaya diri dan persepsi kemampuan ibu dalam proses menyusui atau pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang memperoleh dukungan penghargaan cenderung memiliki tingkat *self-efficacy* yang lebih tinggi dan lebih mampu mempertahankan praktik menyusui meskipun menghadapi berbagai hambatan (Priscilla et al., 2021).

C. Indikator Keberhasilan Menyusui

Evaluasi terhadap keberhasilan dukungan menyusui pada ibu postpartum dilakukan secara komprehensif dengan menilai kondisi ibu, bayi, keluarga, serta sistem pelayanan kesehatan yang mendukung proses laktasi. Pendekatan evaluasi yang multidimensional diperlukan karena keberhasilan menyusui dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor lingkungan seperti pelayanan kesehatan. Menurut WHO, keberhasilan menyusui tidak hanya dinilai dari pemberian ASI saja, tetapi juga dari keberlanjutan ASI eksklusif, kualitas proses menyusui, serta dukungan yang diterima ibu selama periode postpartum (WHO & UNICEF, 2018).

1. Indikator pada Ibu

Ibu merupakan pusat utama dalam proses menyusui sehingga evaluasi terhadap ibu merupakan komponen penting dalam menilai keberhasilan dukungan menyusui. Indikator yang dinilai pada ibu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta kondisi fisik dan psikologis.

a. Pengetahuan Ibu

Pengetahuan ibu mengenai menyusui merupakan fondasi penting dalam keberhasilan praktik menyusui. Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan menyusui dan mampu mempertahankan pemberian ASI eksklusif dalam jangka waktu yang lebih lama. Evaluasi pengetahuan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman ibu dalam memahami konsep dasar menyusui dan manajemen laktasi. Pengetahuan yang perlu dievaluasi meliputi:

- 1) Manfaat ASI bagi ibu dan bayi
- 2) Teknik menyusui yang benar
- 3) Cara memerah dan menyimpan ASI
- 4) Tanda kecukupan ASI pada bayi

5) Penanganan masalah umum dalam menyusui

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi menyusui yang diberikan sejak periode antenatal hingga periode postnatal memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan keberhasilan ASI eksklusif. Ibu yang memiliki pengetahuan menyusui yang baik cenderung memiliki peluang lebih besar dalam mempertahankan pemberian ASI eksklusif dibandingkan ibu dengan Tingkat pengetahuan yang lebih rendah (Mogre et al., 2016). Selain itu, pengetahuan ibu juga berperan dalam membentuk sikap positif terhadap menyusui dan mengurangi ketergantungan pada susu formula. Kurangnya pengetahuan seringkali menyebabkan ibu menghentikan proses menyusui lebih awal karena menganggap produksi ASI tidak mencukupi atau bayi terus menangis akibat merasa lapar.

b. Keterampilan Menyusui

Keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada niat ibu, tetapi juga keterampilan dalam menyusui. Evaluasi keterampilan menyusui dilakukan untuk melihat kemampuan ibu dalam melakukan praktik menyusui secara baik dan benar. Keterampilan yang dinilai meliputi:

- 1) Keterampilan memposisikan bayi dengan baik dan benar
- 2) Kemampuan melakukan perlekatan efektif (*latch on*)
- 3) Perawatan kebersihan payudara
- 4) Kemampuan memerah ASI secara manual maupun menggunakan pompa ASI

Perlekatan yang benar sangat penting untuk mencegah beberapa masalah dalam menyusui seperti puting lecet, bendungan ASI pada payudara, dan mastitis. Bayi dengan perlekatan yang baik akan mendapatkan ASI lebih optimal serta pengosongan payudara menjadi lebih efektif. Dukungan yang diberikan oleh tenaga kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan keberhasilan menyusui dan mempertahankan keberlanjutan pemberian ASI (Chambers et al., 2023). Evaluasi keterampilan ibu dalam menyusui biasanya dilakukan melalui observasi langsung selama proses menyusui dengan menggunakan lembar observasi posisi dan perlekatan.

c. Breastfeeding Self-Efficacy

Breastfeeding self-efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan diri ibu terhadap kemampuannya dalam menyusui. Konsep ini dikembangkan oleh Cindy-Lee Dennis berdasarkan teori sosial kognitif Bandura. Ibu yang memiliki tingkat *self-efficacy* lebih tinggi cenderung mampu berpikir positif sehingga dapat mengatasi hambatan dalam menyusui, lebih percaya diri, dan dapat memberikan ASI eksklusif. Evaluasi *breastfeeding self-efficacy* penting

dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis ibu karena sangat memengaruhi keberhasilan menyusui. Ibu yang memiliki kepercayaan diri rendah atau merasa tidak yakin terhadap produksi ASI-nya, seringkali lebih mudah menghentikan pemberian ASI. Menurut Dennis (2003), skor *Breastfeeding Self-Efficacy Scale* yang tinggi berkorelasi positif dengan durasi menyusui yang lebih panjang dan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu, dukungan emosional dan motivasional dari keluarga maupun tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu postpartum.

d. Kondisi Fisik dan Psikologis

Faktor kondisi fisik dan psikologis ibu postpartum menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan dukungan menyusui. Menyusui yang efektif seharusnya dilakukan dengan nyaman tanpa menimbulkan komplikasi serius pada ibu. Evaluasi kondisi fisik ibu meliputi:

- 1) Tidak ada bendungan produksi ASI
- 2) Tidak ada mastitis
- 3) Puting tidak mengalami lecet
- 4) Produksi ASI cukup
- 5) Tidak terdapat nyeri yang berlebihan pada payudara

Selain kondisi fisik, evaluasi kondisi psikologis ibu juga sangat penting. Ibu postpartum cenderung rentan mengalami kecemasan, kelelahan, stres, bahkan *postpartum blues* dimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*). Kondisi psikologis yang kurang baik dapat menyebabkan penurunan hormon oksitosin sehingga pengeluaran ASI menjadi terhambat. Penelitian oleh Pope & Mazmanian (2016) menunjukkan bahwa ibu postpartum dengan tingkat stress yang tinggi memiliki risiko lebih besar mengalami kegagalan pemberian ASI eksklusif dibandingkan ibu dengan kondisi psikologis yang stabil. Oleh karena itu, dukungan emosional menjadi komponen penting dalam evaluasi keberhasilan proses menyusui.

2. Indikator pada Bayi

Keberhasilan menyusui juga dapat dinilai dari kondisi bayi. Bayi yang mendapatkan ASI secara adekuat akan menunjukkan tumbuh kembang yang lebih baik. Indikator penilaian pada bayi meliputi:

- a. Bayi tampak puas setelah menyusui
- b. Frekuensi menyusui 8–12 kali per hari
- c. Berat badan meningkat sesuai usia
- d. Eliminasi adekuat
- e. Bayi aktif dan tidak mengalami dehidrasi

Bayi yang memperoleh ASI dalam jumlah cukup umumnya tampak tenang setelah menyusui, tidur dengan baik, buang air kecil minimal 6 kali per hari atau lebih pada bayi baru lahir, serta mengalami peningkatan berat badan sesuai kurva pertumbuhan. Evaluasi berat badan bayi merupakan indikator objektif yang dapat menilai kecukupan asupan ASI. Penurunan berat badan yang signifikan atau tidak adanya peningkatan berat badan dapat menunjukkan adanya masalah pada proses menyusui, seperti perlekatan yang kurang tepat atau produksi ASI yang tidak mencukupi. Menurut *American Academy of Pediatrics* (AAP), pemantauan berat badan bayi, frekuensi pengeluaran urin dan feses bayi, serta perilaku bayi setelah menyusui merupakan cara yang sederhana namun efektif untuk mengevaluasi kecukupan ASI dan keberhasilan menyusui pada periode neonatal (Chen et al., 2011; Hardanahalli et al., 2016; Joshi et al., 2017; Jain et al., 2025).

3. Indikator Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Keluarga, terutama suami, memiliki peran penting dalam memberikan bantuan fisik, emosional, dan motivasional kepada ibu postpartum. Keluarga memberikan dukungan yang efektif pada ibu postpartum apabila:

- a. Membantu memenuhi kebutuhan ibu postpartum
- b. Memberikan motivasi untuk menyusui
- c. Tidak mendukung pemberian susu formula tanpa adanya indikasi medis
- d. Membantu penyimpanan ASI perah
- e. Memberikan dukungan emosional

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan pasangan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Ibu yang mendapatkan dukungan positif dari pasangan biasanya cenderung lebih percaya diri dan mampu menyusui dalam jangka panjang (Rempel et al., 2017). Selain pasangan, pengasuh bayi dan anggota keluarga lain juga dapat memengaruhi keberhasilan menyusui karena lingkungan keluarga yang mendukung akan membantu mengurangi stres ibu dan meningkatkan kenyamanan selama proses menyusui.

4. Indikator Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan dukungan menyusui juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi sejak persalinan hingga masa nifas. Sistem pelayanan yang mendukung proses menyusui akan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Indikator pelayanan kesehatan antara lain:

- a. Penerapan *rooming in*
- b. Konseling laktasi rutin

- c. Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- d. Penerapan *Baby-Friendly Hospital Initiative* (BFHI)
- e. *Follow up* pada periode postpartum

Program BFHI yang dikembangkan oleh WHO dan UNICEF terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan menyusui melalui penerapan "*Ten Steps to Successful Breastfeeding*". Berbagai penelitian *systematic review* menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan BFHI memiliki angka IMD dan ASI eksklusif lebih tinggi dibandingkan fasilitas kesehatan yang tidak menerapkan BFHI (Von Seehausen et al., 2023; Fan et al., 2025; Habte et al., 2025). Selain itu, konseling laktasi yang dilakukan secara berkelanjutan pada periode postpartum efektif membantu ibu dalam mengatasi hambatan menyusui, meningkatkan *breastfeeding self-efficacy*, dan mencegah penghentian ASI secara dini (Yuniarini et al., 2021; Beyene et al., 2025).



Gambar 7. 1 *Ten Steps to Successful Breastfeeding*

D. Metode Evaluasi Dukungan Menyusui

Evaluasi dilakukan secara sistematis melalui pendekatan proses keperawatan yang mencakup pengkajian (*assessment*), penggunaan instrumen evaluasi yang standar, observasi langsung, serta wawancara dan konseling. Menurut World Health Organization, evaluasi menyusui yang dilakukan sejak awal dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, terutama pada minggu pertama pasca persalinan yang merupakan periode paling rentan terhadap kegagalan menyusui. Pendekatan evaluasi yang komprehensif memungkinkan tenaga kesehatan mendeteksi masalah menyusui lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara cepat dan tepat (WHO, 2018).

1. Pengkajian (*Assessment*)

Pengkajian merupakan langkah awal dalam mengevaluasi dukungan menyusui yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi ibu, bayi, serta lingkungan yang mendukung. Tujuan dari pengkajian yaitu untuk mengidentifikasi faktor risiko, hambatan menyusui, dan kebutuhan intervensi laktasi secara individual. Pengkajian meliputi:

a. Riwayat menyusui

Riwayat menyusui sangat penting dikaji untuk memperoleh informasi tentang pengalaman ibu sebelumnya terkait keberhasilan maupun kegagalan menyusui. Ibu yang pernah mengalami masalah laktasi seperti bendungan ASI, mastitis, atau penghentian ASI secara dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami hambatan menyusui pada periode postpartum berikutnya. Pengkajian riwayat menyusui meliputi:

- 1) pengalaman pemberian ASI eksklusif sebelumnya
- 2) lama atau durasi menyusui
- 3) penggunaan susu formula
- 4) riwayat masalah laktasi
- 5) pengalaman mendapatkan konseling menyusui.

Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menyusui sebelumnya dapat mempengaruhi *breastfeeding self-efficacy* dan keberhasilan menyusui pada ibu postpartum. Ibu yang memiliki pengalaman menyusui yang positif cenderung mempunyai tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam memberikan ASI eksklusif (Güneş et al., 2023).

b. Pengetahuan ibu

Pengetahuan ibu tentang manfaat ASI, teknik menyusui, indikator kecukupan ASI, serta manajemen laktasi merupakan aspek penting yang perlu dievaluasi. Pengetahuan yang memadai dapat membantu ibu dalam

mengambil keputusan yang tepat terkait praktik menyusui serta dapat menurunkan risiko penghentian ASI secara dini. Evaluasi pengetahuan dilakukan melalui:

- 1) wawancara,
- 2) kuesioner,
- 3) diskusi edukatif,
- 4) observasi praktik menyusui.

Penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pengetahuan yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk berhasil mempertahankan ASI eksklusif dibandingkan ibu dengan Tingkat pengetahuan yang rendah (Nukpezah et al., 2018; Dukuzumuremyi et al., 2020).

c. Dukungan keluarga

Dukungan dari keluarga, khususnya pasangan, merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses menyusui. Pengkajian dilakukan untuk menilai sejauh mana keluarga memberikan dukungan kepada ibu postpartum baik secara emosional, informasional, maupun bantuan praktis. Aspek yang dinilai meliputi:

- 1) keterlibatan pasangan,
- 2) bantuan dalam perawatan bayi,
- 3) dukungan emosional,
- 4) sikap keluarga terhadap pemberian ASI eksklusif,
- 5) pengaruh budaya dan lingkungan.

Penelitian Rempel et al. (2017) menunjukkan bahwa dukungan pasangan secara signifikan dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan kepercayaan diri ibu dalam menyusui.

d. Kondisi fisik ibu dan bayi

Pengkajian fisik pada ibu dan bayi bertujuan mendeteksi masalah yang dapat menghambat keberhasilan menyusui. Pengkajian pada ibu meliputi:

- 1) kondisi payudara,
- 2) bentuk puting,
- 3) bendungan ASI,
- 4) mastitis,
- 5) nyeri saat menyusui.

Sedangkan pengkajian pada bayi meliputi:

- 1) kemampuan menghisap,
- 2) refleks rooting dan sucking,
- 3) berat badan,
- 4) frekuensi eliminasi,

5) tanda dehidrasi.

Pemantauan berat badan bayi dan frekuensi eliminasi merupakan cara sederhana namun efektif dalam mengevaluasi kecukupan ASI dan keberhasilan menyusui pada periode neonatal. Bayi yang mendapatkan asupan ASI yang cukup umumnya menunjukkan peningkatan berat badan yang sesuai, frekuensi buang air kecil dan buang air besar yang normal, serta tampak puas setelah menyusu (Chen et al., 2011; Hardanahalli et al., 2016).

2. Instrumen Evaluasi

Pada praktik klinis, evaluasi proses menyusui dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen standar yang telah tervalidasi untuk membantu tenaga kesehatan menilai efektivitas menyusui secara objektif. Penggunaan instrumen evaluasi ini dapat meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi masalah laktasi serta membantu menentukan kebutuhan intervensi lebih lanjut. Beberapa instrumen yang sering digunakan meliputi:

a. *LATCH Assessment Tool*

LATCH Assessment Tool merupakan salah satu instrumen yang paling sering digunakan dalam evaluasi menyusui pada periode awal postpartum. Instrumen ini dikembangkan untuk menilai efektivitas proses menyusui berdasarkan lima komponen utama, yaitu:

- 1) *Latch* (perlekatan)
- 2) *Audible swallowing* (suara menelan)
- 3) *Type of nipple* (bentuk puting)
- 4) *Comfort* (kenyamanan payudara dan puting)
- 5) *Hold* (posisi dan bantuan memegang bayi)

Setiap komponen akan diberi skor 0–2 sehingga total skor maksimal adalah 10. Skor yang tinggi menunjukkan proses menyusui yang lebih efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *LATCH Assessment Tool* merupakan instrumen yang efektif untuk mengevaluasi keberhasilan menyusui pada periode postpartum karena mampu menilai efektivitas proses menyusui sekaligus mengidentifikasi secara dini ibu yang berisiko mengalami hambatan laktasi sehingga intervensi yang sesuai dapat segera diberikan. Penelitian Astutik et al., (2024) menunjukkan bahwa skor LATCH efektif dalam memprediksi keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan kebutuhan dukungan laktasi tambahan. Instrumen ini memiliki validitas yang baik dalam menilai kualitas perlekatan bayi, kemampuan menghisap, kenyamanan ibu, serta efektivitas transfer ASI. Selain itu, penelitian Shah et al. (2021) menunjukkan bahwa skor LATCH >6 saat ibu pulang dari rumah sakit berhubungan signifikan dengan keberhasilan ASI eksklusif dan peningkatan berat badan bayi pada usia 6 minggu postpartum.

b. Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES)

Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan diri ibu dalam menyusui. Instrumen ini dikembangkan oleh Dennis (2003) berdasarkan teori sosial kognitif Bandura. BSES menilai keyakinan ibu terhadap kemampuannya dalam:

- 1) melakukan teknik menyusui,
- 2) mempertahankan ASI eksklusif,
- 3) mengatasi hambatan dalam menyusui,
- 4) memberikan ASI dalam berbagai situasi.

Kepercayaan diri ibu merupakan faktor psikologis yang sangat memengaruhi keberhasilan menyusui. Ibu dengan skor BSES yang tinggi cenderung lebih mampu mempertahankan pemberian ASI eksklusif dibandingkan ibu dengan skor rendah. Penelitian Güneş et al., (2023) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara skor BSES, skor LATCH, dan peningkatan berat badan bayi selama 6 bulan pertama kehidupan. Semakin tinggi *breastfeeding self-efficacy*, maka semakin baik keberhasilan menyusui dan pertumbuhan bayi. Penelitian validasi BSES di berbagai negara juga menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi dalam mengevaluasi tingkat kepercayaan diri ibu menyusui (Chipojola et al., 2020).

c. Breastfeeding Assessment Tools

Breastfeeding Assessment Tools merupakan instrumen penilaian menyusui yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dan ibu dalam menilai apakah proses menyusui berlangsung secara efektif dan aman. Instrumen ini digunakan dalam pelayanan maternitas, kesehatan komunitas, serta perawatan neonatal dengan pendekatan observasi sederhana namun komprehensif terhadap kondisi ibu dan bayi selama proses menyusui. Penilaian ini menggunakan beberapa indikator umum untuk mengevaluasi keberhasilan menyusui, seperti kemampuan bayi melekat pada payudara, efektivitas hisapan, frekuensi menyusui, perubahan berat badan bayi, jumlah urin dan feses, perilaku bayi setelah menyusui, serta kondisi payudara dan puting ibu. Penilaian dilakukan bersama ibu oleh bidan, perawat, atau tenaga kesehatan sehingga ibu juga dapat memahami tanda-tanda bahwa bayinya mendapatkan ASI secara adekuat.

Dalam implementasinya, UNICEF menyediakan beberapa jenis *Breastfeeding Assessment Tool* sesuai konteks pelayanan, yaitu alat penilaian untuk pelayanan maternitas, kunjungan kesehatan komunitas (*health visiting*), dan perawatan neonatal. Apabila selama proses penilaian ditemukan indikator

yang belum terpenuhi, tenaga kesehatan dianjurkan untuk melakukan observasi menyusui secara langsung guna mengidentifikasi masalah laktasi secara lebih mendalam. Pendekatan ini dapat membantu deteksi dini kesulitan menyusui sehingga intervensi dapat segera diberikan sebelum terjadi penghentian ASI secara dini.

Breastfeeding Assessment Tools tidak hanya sebagai alat evaluasi klinis, tetapi juga mendukung implementasi *Baby-Friendly Hospital Initiative* (BFHI) yang dikembangkan oleh WHO dan UNICEF. Penggunaan instrumen ini membantu tenaga kesehatan melakukan pemantauan menyusui secara terstandar dan konsisten sesuai prinsip "*Ten Steps to Successful Breastfeeding*".

Penelitian Jain et al. (2025) menunjukkan bahwa *UNICEF Breastfeeding Assessment Tool* memiliki korelasi positif dengan sistem penilaian *LATCH* dalam mengidentifikasi kecukupan menyusui pada periode neonatal awal. Instrumen ini dinilai praktis karena dapat digunakan melalui observasi sederhana seperti tingkat kewaspadaan bayi, frekuensi eliminasi, pola menyusui, dan perilaku bayi setelah menyusui, sehingga efektif untuk mendeteksi dini masalah menyusui pada ibu dan bayi.

3. Observasi Langsung

Metode observasi langsung merupakan metode utama dalam evaluasi menyusui karena memungkinkan tenaga kesehatan menilai keterampilan menyusui ibu secara objektif. Observasi meliputi:

a. Posisi Menyusui

Posisi menyusui yang benar dapat membantu bayi melekat secara optimal dan mencegah nyeri pada payudara ibu. Evaluasi dilakukan terhadap:

- 1) posisi kepala bayi,
- 2) keselarasan tubuh bayi,
- 3) kenyamanan ibu,

Posisi menyusui yang tidak tepat dapat menyebabkan perlekatan yang kurang baik, pemberian ASI yang tidak optimal, serta meningkatkan risiko puting lecet dan bendungan ASI.

b. Perlekatan Bayi

Perlekatan (*latch on*) merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas proses menyusui. Bayi dikatakan memiliki perlekatan yang baik apabila:

- 1) mulut bayi terbuka lebar,
- 2) sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi,
- 3) dagu bayi menempel pada payudara,

4) hisapan berlangsung efektif dan ritmis.

Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi *latch* secara dini dapat membantu mengidentifikasi masalah menyusui lebih awal sehingga intervensi laktasi dapat segera diberikan untuk mencegah komplikasi menyusui dan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Ibu dengan skor LATCH yang baik pada periode awal postpartum memiliki kemungkinan lebih besar untuk mempertahankan ASI eksklusif hingga 6 minggu postpartum dibandingkan ibu dengan skor yang rendah (Sowjanya & Venugopalan, 2018). Selain itu, penggunaan penilaian LATCH secara sistematis yang disertai konseling menyusui terbukti efektif dalam mendeteksi kesulitan menyusui, memperbaiki teknik perlekatan, serta meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif baik selama perawatan maupun setelah ibu pulang dari rumah sakit (Boora et al., 2026).

c. Respons Bayi Saat Menyusu

Respons bayi mencerminkan kecukupan pemberian ASI dan efektivitas proses menyusui. Evaluasi terhadap respons bayi dapat dilakukan melalui:

- 1) kemampuan bayi menghisap,
- 2) suara menelan saat menyusu,
- 3) bayi tampak puas setelah menyusu,
- 4) frekuensi menyusu yang adekuat.

4. Wawancara dan Konseling

Wawancara dan konseling digunakan untuk menggali pengalaman subjektif ibu selama proses menyusui. Evaluasi ini penting karena keberhasilan menyusui tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Wawancara dilakukan untuk menggali:

a. Persepsi Ibu

Banyak ibu menghentikan proses menyusui karena merasa produksi ASI tidak mencukupi, meskipun secara fisiologis produksi ASI adekuat. Oleh karena itu, persepsi ibu terhadap proses menyusui perlu dievaluasi secara mendalam.

b. Hambatan yang Dialami

Hambatan dalam menyusui dapat berupa:

- 1) nyeri payudara,
- 2) kelelahan,
- 3) stres,
- 4) kurangnya dukungan keluarga,
- 5) kesulitan bayi melekat pada payudara,
- 6) tuntutan pekerjaan.

Melalui wawancara, tenaga kesehatan dapat menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individual ibu.

c. Tingkat Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri ibu pada masa postpartum sangat memengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Konseling yang suportif terbukti dapat meningkatkan *breastfeeding self-efficacy* dan membantu ibu mempertahankan proses menyusui dalam jangka waktu yang lebih lama. Penelitian menunjukkan bahwa konseling laktasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan keberhasilan menyusui dan mengurangi risiko penghentian ASI secara dini pada periode awal postpartum.

E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Dukungan Menyusui pada Ibu Postpartum

Tenaga kesehatan, khususnya perawat maternitas, memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan menyusui pada ibu postpartum melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada masa postpartum, ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis maupun psikologis yang dapat memengaruhi keberhasilan proses laktasi, sehingga diperlukan pendampingan profesional yang berkesinambungan. Dukungan tenaga kesehatan terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan keberhasilan IMD, peningkatan angka pemberian ASI eksklusif, serta keberlanjutan proses menyusui hingga enam bulan pertama kehidupan bayi (Walsh et al., 2023).

Perawat maternitas sebagai bagian integral dari tim pelayanan kesehatan ibu dan anak memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi, konseling, monitoring, dan evaluasi praktik menyusui berbasis bukti (*evidence-based practice*). Peran ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis menyusui, tetapi juga mencakup dukungan psikososial, pemberdayaan ibu, serta penguatan lingkungan yang mendukung keberhasilan laktasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan program WHO dan UNICEF melalui *Baby-Friendly Hospital Initiative* (BFHI), yang menekankan pentingnya perlindungan, promosi, dan dukungan menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan maternitas.

1. Edukasi Teknik Menyusui yang Benar

Edukasi merupakan salah satu intervensi utama yang dilakukan tenaga kesehatan dalam meningkatkan keberhasilan menyusui. Perawat maternitas bertanggung jawab memberikan informasi kepada ibu mengenai posisi menyusui, teknik perlekatan (*latch-on*), frekuensi menyusui, tanda kecukupan ASI, serta manajemen laktasi dasar. Edukasi yang diberikan sejak masa antenatal hingga postpartum terbukti meningkatkan kepercayaan diri ibu (*breastfeeding*

self-efficacy) serta menurunkan risiko penghentian ASI secara dini. Menurut pedoman BFHI, tenaga kesehatan harus mampu membantu ibu mengenali tanda kesiapan bayi untuk menyusui, mendukung kontak kulit dengan kulit (*skin-to-skin contact*), serta memfasilitasi inisiasi menyusui dini dalam satu jam pertama setelah persalinan. Praktik ini berperan dalam merangsang produksi hormon oksitosin dan prolaktin sehingga membantu keberhasilan laktogenesis awal. Selain itu, edukasi menyusui yang dilakukan secara konsisten oleh tenaga kesehatan terbukti dapat meningkatkan angka keberhasilan pemberian ASI eksklusif secara signifikan, terutama apabila dilakukan melalui pendekatan individual dan berkelanjutan selama masa postpartum (Shaban et al., 2026).

2. Deteksi Dini Masalah Laktasi

Perawat maternitas juga memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah laktasi yang dapat menghambat keberhasilan menyusui. Permasalahan yang sering ditemukan meliputi puting lecet, bendungan ASI, mastitis, produksi ASI yang tidak adekuat, serta kesalahan posisi dan perlekatan bayi. Apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat, kondisi tersebut dapat menyebabkan nyeri, stres, dan penghentian menyusui lebih awal. Deteksi dini dilakukan melalui pengkajian menyeluruh terhadap kondisi ibu dan bayi, observasi proses menyusui, serta penggunaan instrumen penilaian seperti *LATCH Assessment Tool*. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi hambatan menyusui secara lebih cepat dan memberikan intervensi yang sesuai. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi masalah laktasi secara dini berkontribusi terhadap peningkatan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan kepuasan ibu terhadap pelayanan maternitas (Fan et al., 2025).

3. Konseling Menyusui

Konseling menyusui merupakan proses komunikasi terapeutik yang bertujuan membantu ibu untuk memahami kondisi yang dialami, meningkatkan motivasi ibu, dan membangun kepercayaan dan keyakinan diri ibu dalam menyusui. Berbeda dengan edukasi yang bersifat memberikan informasi satu arah, konseling lebih banyak menekankan pada interaksi interpersonal, empati, dan penguatan psikologis ibu postpartum. Perawat maternitas perlu menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik dalam memberikan konseling menyusui, terutama pada ibu yang mengalami kecemasan, kelelahan, atau kesulitan menyusui. Dukungan emosional yang diberikan oleh tenaga kesehatan terbukti efektif meningkatkan keberhasilan ibu dalam menyusui dan mengurangi risiko penghentian ASI eksklusif secara dini. Konseling menyusui juga memiliki peran penting dalam meluruskan berbagai mitos dan persepsi negatif tentang

ASI yang masih berkembang di masyarakat. Dengan konseling yang tepat, ibu dapat lebih memahami manfaat ASI dan memiliki kemampuan dalam mengatasi hambatan selama proses menyusui (Chambers et al., 2023; Whelan et al., 2025).

4. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Menyusui

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan maternitas untuk memastikan keberhasilan praktik menyusui secara berkelanjutan. Perawat maternitas melakukan pemantauan terhadap frekuensi menyusui, peningkatan berat badan bayi, kecukupan ASI, kondisi payudara ibu, serta kemampuan ibu dalam melakukan teknik menyusui secara mandiri. Evaluasi menyusui tidak hanya berfokus pada keberhasilan pemberian ASI eksklusif, tetapi juga mencakup pengalaman ibu selama menyusui, tingkat kenyamanan, serta keberhasilan adaptasi ibu terhadap peran maternal. Pendekatan evaluasi yang komprehensif memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi lanjutan secara tepat apabila ditemukan masalah selama proses laktasi. Implementasi monitoring yang terintegrasi dalam BFHI terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui di berbagai fasilitas kesehatan maternitas melalui pendekatan "*Ten Steps to Successful Breastfeeding*". Program ini menekankan pentingnya kompetensi tenaga kesehatan dalam mendukung ibu sejak persalinan hingga masa pemulangan dari rumah sakit (Walsh et al., 2023).

Referensi

- Astutik, R. Y., Nining Istighosah, & Retno Palupi Yonni Siwi. (2024). Breastfeeding Behavior and LATCH Score in Postpartum Mothers days 1-7 with Overweight and Obesity. *Journal Of Nursing Practice*, 7(2), 472–480. <https://doi.org/10.30994/jnp.v7i2.604>
- Beyene, B. N., Wako, W. G., Moti, D., Edin, A., & Debela, D. E. (2025). Postnatal counseling promotes early initiation and exclusive breastfeeding: A randomized controlled trial. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1473086. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1473086>
- Boora, M. R., Kori, S., Shiragur, S., Chhabra, E., Patil, M. M., & Umerjekar, S. (2026). LATCH Score for the Identification and Correction of Breastfeeding Problems: A Prospective Observational Study. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.101912>
- Carin, V., Stefani, M., & Fadlina, A. (2025). Instrumental and Emotional Support in Breastfeeding Fathers and Exclusive Breastfeeding Success. *Indonesian Journal of Human Nutrition*, 11(2), 205–216. <https://doi.org/10.21776/ub.ijhn.2024.011.02.8>
- Chambers, A., Emmott, E., Myers, S., & Page, A. (2023). Emotional and informational social support from health visitors and breastfeeding outcomes in the UK. *International Breastfeeding Journal*, 18(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s13006-023-00551-7>
- Chen, C.-F., Hsu, M.-C., Shen, C.-H., Wang, C.-L., Chang, S.-C., Wu, K.-G., Wu, S.-C., & Chen, S.-J. (2011). Influence of Breast-feeding on Weight Loss, Jaundice, and Waste Elimination in Neonates. *Pediatrics & Neonatology*, 52(2), 85–92. <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2011.02.010>
- Chipojola, R., Chiu, H.-Y., Huda, M. H., Lin, Y.-M., & Kuo, S.-Y. (2020). Effectiveness of theory-based educational interventions on breastfeeding self-efficacy and exclusive breastfeeding: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 109, 103675. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103675>
- Dennis, C. (2003). The Breastfeeding Self-Efficacy Scale: Psychometric Assessment of the Short Form. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 32(6), 734–744. <https://doi.org/10.1177/0884217503258459>
- Dukuzumuremyi, J. P. C., Acheampong, K., Abesig, J., & Luo, J. (2020). Knowledge, attitude, and practice of exclusive breastfeeding among mothers in East Africa: A systematic review. *International Breastfeeding Journal*, 15(1), 70. <https://doi.org/10.1186/s13006-020-00313-9>
- Fan, Y. W., Fan, H. S. L., Shing, J. S. Y., Ip, H. L., Fong, D. Y. T., & Lok, K. Y. W. (2025). Impact of baby-friendly hospital initiatives on breastfeeding outcomes:

- Systematic review and meta-analysis. *Women and Birth*, 38(2), 101881. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2025.101881>
- Gao, J., Wang, W., Wei, B., Ling, Q., & Hu, W. (2026). Psychometric evaluation of the Chinese version of the exclusive breastfeeding social support scale: A cross-sectional study. *International Breastfeeding Journal*, 21(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s13006-026-00814-z>
- Güneş, A. O., Karadağ, N., & Karatekin, G. (2023). The Effect of Breastfeeding Self-Efficacy on Infants' Weights and Breastfeeding Outcomes. *Turkish Archives of Pediatrics*, 58(6), 588–593. <https://doi.org/10.5152/TurkArchPediater.2023.23113>
- Habte, M. B., Abdulahi, M., Plusquin, M., & Cosemans, C. (2025). Effectiveness of Baby-Friendly Hospital Initiative on Early Initiation and Exclusive Breastfeeding Practice: Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*, 17(14), 2283. <https://doi.org/10.3390/nu17142283>
- Hardanahalli, R., Banerjee, R., Srikanth, J., Pd, P., & Reddy, I. (2016). Breast feeding assessment in early neonatal period. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 455–458. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20160431>
- Jain, J., Hemrajani, S. K., Sharma, S. S., Gurjar, V., & Banveer, P. (2025). Assessment Tool by UNICEF and LATCH Scoring System for Identification of Inadequacy of Breastfeeding in Early Neonatal Period: An Observational Cross-sectional Comparative Study. *Journal of Neonatology*, 39(1), 42–50. <https://doi.org/10.1177/09732179241239808>
- Joshi, R., John, B., & Negi, V. (2017). Pattern of weight loss in breastfed neonates in initial 72 h of life. *Journal of Clinical Neonatology*, 6(2), 85. https://doi.org/10.4103/jcn.JCN_68_16
- Maleki, N., & Mirzaei, K. (2025). Breastfeeding Mothers' Informational Support Needs: A Qualitative Study in Iran. *Journal of Qualitative Research in Health Sciences*, 14, 1412. <https://doi.org/10.34172/jqr.1412>
- Meek, J. Y., Noble, L., & Section on Breastfeeding. (2022). Policy Statement: Breastfeeding and the Use of Human Milk. *Pediatrics*, 150(1), e2022057988. <https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988>
- Mogre, V., Dery, M., & Gaa, P. K. (2016). Knowledge, attitudes and determinants of exclusive breastfeeding practice among Ghanaian rural lactating mothers. *International Breastfeeding Journal*, 11(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13006-016-0071-z>
- Nukpezah, R. N., Nuvor, S. V., & Ninnoni, J. (2018). Knowledge and practice of exclusive breastfeeding among mothers in the tamale metropolis of Ghana. *Reproductive Health*, 15(1), 140. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0579-3>

- Pope, C. J., & Mazmanian, D. (2016). Breastfeeding and Postpartum Depression: An Overview and Methodological Recommendations for Future Research. *Depression Research and Treatment*, 2016, 1–9. <https://doi.org/10.1155/2016/4765310>
- Priscilla, V., Afiyanti, Y., & Juliastuti, D. (2021). A Qualitative Systematic Review of Family Support for a Successful Breastfeeding Experience among Adolescent Mothers. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(F), 775–783. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7431>
- Rempel, L. A., Rempel, J. K., & Moore, K. C. J. (2017). Relationships between types of father breastfeeding support and breastfeeding outcomes. *Maternal & Child Nutrition*, 13(3), e12337. <https://doi.org/10.1111/mcn.12337>
- Shaban, A. S., Hassan, S. I., & El-nemer, A. (2026). Impact of nurse-focused Baby-Friendly Hospital Initiative training program on mothers' breastfeeding practices at hospital discharge: A quasi-experimental study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 26(1), 418. <https://doi.org/10.1186/s12884-026-08993-7>
- Shah, M. H., Roshan, R., Parikh, T., Sathe, S., Vaidya, U., & Pandit, A. (2021). LATCH Score at Discharge: A Predictor of Weight Gain and Exclusive Breastfeeding at 6 Weeks in Term Healthy Babies. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 72(2). <https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000002927>
- Sowjanya, S. V. N. S., & Venugopalan, L. (2018). LATCH Score as a Predictor of Exclusive Breastfeeding at 6 Weeks Postpartum: A Prospective Cohort Study. *Breastfeeding Medicine*, 13(6), 444–449. <https://doi.org/10.1089/bfm.2017.0142>
- Stein Elger, R., Foti, T. R., Reid, C. N., Pacheco Garrillo, M., Afolabi, A., Kaur Ratta, A., Fryer, K., & Marshall, J. (2025). The role of social support in shaping maternal experiences during the postpartum hospital stay: A qualitative study. *Women's Health*, 21, 17455057251385367. <https://doi.org/10.1177/17455057251385367>
- Ulya, R. A. N. A. (2023). Dukungan Sosial untuk Mendukung Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Indonesia. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 541–552. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.541-552>
- UNICEF. (2022). *Infant and young child feeding*. <https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding/>
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)

- Von Seehausen, M. P., Oliveira, M. I. C. D., Leal, M. D. C., Domingues, R. M. S. M., & Boccolini, C. S. (2023). Baby-Friendly Hospital Initiative and exclusive breastfeeding during hospital stay. *Revista de Saúde Pública*, 57(1), 28. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004283>
- Walsh, A., Pieterse, P., Mishra, N., Chirwa, E., Chikalipo, M., Msowoya, C., Keating, C., & Matthews, A. (2023). Improving breastfeeding support through the implementation of the Baby-Friendly Hospital and Community Initiatives: A scoping review. *International Breastfeeding Journal*, 18(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s13006-023-00556-2>
- Whelan, C., O'Brien, D., & Hyde, A. (2025). Breastfeeding with primary low milk supply: A phenomenological exploration of mothers' lived experiences of postnatal breastfeeding support. *International Breastfeeding Journal*, 20(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s13006-025-00699-4>
- WHO. (2018). *Implementation guidance: Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513807>
- WHO. (2019). *Ten steps to successful breastfeeding*. <https://www.who.int/multi-media/details/ten-steps-to-successful-breastfeeding>
- WHO. (2023). *Infant and young child feeding*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>
- WHO & UNICEF. (2018). *Implementation guidance: Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: The revised Baby-friendly Hospital Initiative 2018*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513807>
- Yuniarini, W. R., Herini, E. S., & Wahab, A. (2021). Postpartum lactation counseling and exclusive breastfeeding: Analysis of the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey. *Paediatrica Indonesiana*, 61(1), 25–33. <https://doi.org/10.14238/pi61.1.2021.25-33>

PROFIL PENULIS



Vika Tri Zelharsandy, S.Tr.Keb., M.Keb.

Lahir di Palembang, 17 April 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan, STIKES Mitra Adiguna Palembang yang lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di STIKES Abdurahman Palembang yang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa nifas (postpartum), Terapi non Konvensional Ibu dan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan dalam ruang lingkup kesehatan khususnya kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: vikaharsandy@gmail.com
Motto: " Berbuatlah baik, berguna untuk orang lain dan jangan bersikap merugikan orang lain"



Dr. Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Klaten, 06 September 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga lulus tahun 2012 dan 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 di Akper Hang Tuah Surabaya, sampai dengan sekarang dimana institusi tempat penulis bekerja sudah berubah bentuk menjadi Stikes Hang Tuah Surabaya. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak dan Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pujihastuti@stikeshangtuah-sby.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Lahir di Tumpang Laung, 06 April 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan, Universitas Diponegoro tahun 2007. Kemudian melanjutkan Program Profesi Ners Tahun 2008 Di Universitas Diponegoro. Selanjutnya pendidikan S2 dan Spesialis Keperawatan Maternitas pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan, sejak pada tahun 2002 hingga sekarang bekerja di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya. Mata kuliah yang diampu yaitu Keperawatan Maternitas, Kebutuhan Dasar Manusia, Ilmu Biomedik Dasar, Patofisiologi, Manajemen Keperawatan, Manajemen Nyeri dan Terapi Holistik, Keperawatan Diabetes Melitus, Falsafah dan Teori Keperawatan, Dokumentasi Keperawatan, Keperawatan Anak, Keperawatan Keluarga, Gizi dan Diet. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail yaitu:

aidakusnaningsih81@gmail.com.



Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.

Lahir di Tasikmalaya, 07 Juli 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Padjajaran tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1994 sebagai dosen di Akademi Keperawatan Bakti Tunas Husada. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bakti Tunas Husada mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi, Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis, Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: enoknurliawati@universitas-bth.ac.id

Motto: Success is not just about what you achieve, but how you benefit others

PROFIL PENULIS



Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Medan, 20 Mei 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2000 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2008 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 sebagai staf Pengajar pada SPK Kesdam I BB/Binjai.. Kemudian pernah bekerja di STIK Famika Makassar Saat

ini penulis bekerja di STIKes Medistra Indonesia mengampu mata kuliah Keperawatan Maternita, Keperawatan Kesehatan Reproduksi, Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Keperawatan Anak dengan Penyakit Terminal. Keperawatan Jiwa dan Psikososial. Keperawatan Psikiatrixxx, xxx. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis juga aktif sebagai anggota Profesi PPNI, IPEMI Jabar, Relawan dan fasilitator IRL (Indonesia Ramah Lansia) dan juga Assesor BNSP di LSP MANISKU. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernaulimeliyana6972@gmail.com

Motto: " Everything is Possible, Just be Yourself.



Dr. Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Lahir di Magelang. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan Spesialis pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai perawat pelaksana di RS Telogorejo Semarang dan tahun 1996 sd sekarang sebagai Dosen di Fakultas Ilmu

Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tutikrahayu@unissula.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Ayut Merdikawati, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Malang, 01 Agustus 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan profesi Ners di Universitas Brawijaya lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di Universitas Brawijaya mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi, Pendidikan dan Kolaborasi Interprofesi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar. Salah satu buku yang ditulis yaitu "Asuhan Keperawatan Bayi Risiko Tinggi" penerbit Universitas Brawijaya Press. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayut.fk@ub.ac.id

Sinopsis

Bunga rampai “Peran Perawat dalam Dukungan Menyusui pada Ibu Postpartum” menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai kontribusi perawat dalam mendampingi ibu pada masa nifas agar proses menyusui berlangsung aman, nyaman, dan berhasil. Masa postpartum merupakan periode adaptasi biologis dan psikologis yang menentukan keberlangsungan laktasi; karena itu, perawat berperan penting sebagai pemberi asuhan, edukator, konselor, sekaligus penghubung dukungan keluarga dan layanan kesehatan.

Pada Chapter 1, pembaca diajak memahami konsep dasar masa postpartum dan proses laktasi sebagai landasan praktik keperawatan. Chapter 2 menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyusui, meliputi kondisi ibu dan bayi, kesiapan psikologis, teknik menyusui, lingkungan, hingga dukungan sosial. Selanjutnya, Chapter 3 menekankan pentingnya pengkajian keperawatan pada ibu postpartum dalam pemberian ASI—meliputi riwayat kesehatan, kondisi payudara, pelekatan, frekuensi menyusui, dan tanda masalah laktasi—sebagai dasar penetapan diagnosis dan rencana tindakan.

Chapter 4 membahas edukasi teknik menyusui yang benar dan perawatan payudara, termasuk posisi menyusui, pelekatan efektif, tanda bayi cukup ASI, serta upaya pencegahan masalah laktasi. Chapter 5 memfokuskan intervensi keperawatan pada kondisi yang sering terjadi, seperti bendungan ASI dan puting lecet, dengan pendekatan berbasis edukasi, kenyamanan, pencegahan komplikasi, dan rujukan bila diperlukan. Penguatan peran keluarga menjadi sorotan pada Chapter 6, yang mengulas strategi melibatkan pasangan dan keluarga untuk menciptakan lingkungan suportif demi keberhasilan ASI eksklusif. Terakhir, Chapter 7 menutup pembahasan melalui evaluasi keberhasilan dukungan menyusui pada ibu postpartum, mencakup indikator klinis, kepuasan ibu, keberlanjutan praktik menyusui, serta tindak lanjut pelayanan.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan praktis dan ilmiah bagi perawat, mahasiswa keperawatan, serta tenaga kesehatan terkait dalam meningkatkan mutu asuhan postpartum. Dengan dukungan menyusui yang tepat, perawat dapat membantu ibu mencapai pengalaman menyusui yang positif serta meningkatkan peluang keberhasilan ASI eksklusif bagi tumbuh kembang optimal bayi.

Bunga rampai “Peran Perawat dalam Dukungan Menyusui pada Ibu Postpartum” menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai kontribusi perawat dalam mendampingi ibu pada masa nifas agar proses menyusui berlangsung aman, nyaman, dan berhasil. Masa postpartum merupakan periode adaptasi biologis dan psikologis yang menentukan keberlangsungan laktasi; karena itu, perawat berperan penting sebagai pemberi asuhan, edukator, konselor, sekaligus penghubung dukungan keluarga dan layanan kesehatan.

Pada Chapter 1, pembaca diajak memahami konsep dasar masa postpartum dan proses laktasi sebagai landasan praktik keperawatan. Chapter 2 menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyusui, meliputi kondisi ibu dan bayi, kesiapan psikologis, teknik menyusui, lingkungan, hingga dukungan sosial. Selanjutnya, Chapter 3 menekankan pentingnya pengkajian keperawatan pada ibu postpartum dalam pemberian ASI—meliputi riwayat kesehatan, kondisi payudara, pelekatan, frekuensi menyusui, dan tanda masalah laktasi—sebagai dasar penetapan diagnosis dan rencana tindakan.

Chapter 4 membahas edukasi teknik menyusui yang benar dan perawatan payudara, termasuk posisi menyusui, pelekatan efektif, tanda bayi cukup ASI, serta upaya pencegahan masalah laktasi. Chapter 5 memfokuskan intervensi keperawatan pada kondisi yang sering terjadi, seperti bendungan ASI dan puting lecet, dengan pendekatan berbasis edukasi, kenyamanan, pencegahan komplikasi, dan rujukan bila diperlukan. Penguatan peran keluarga menjadi sorotan pada Chapter 6, yang mengulas strategi melibatkan pasangan dan keluarga untuk menciptakan lingkungan suportif demi keberhasilan ASI eksklusif. Terakhir, Chapter 7 menutup pembahasan melalui evaluasi keberhasilan dukungan menyusui pada ibu postpartum, mencakup indikator klinis, kepuasan ibu, keberlanjutan praktik menyusui, serta tindak lanjut pelayanan.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan praktis dan ilmiah bagi perawat, mahasiswa keperawatan, serta tenaga kesehatan terkait dalam meningkatkan mutu asuhan postpartum. Dengan dukungan menyusui yang tepat, perawat dapat membantu ibu mencapai pengalaman menyusui yang positif serta meningkatkan peluang keberhasilan ASI eksklusif bagi tumbuh kembang optimal bayi.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-48-0 (PDF)



9

786347

756480